

Buku Referensi

KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN

Keterampilan Klinis, Hubungan Profesional, dan Keselamatan Pasien

Wijayanti • Mukhoirotin • Sulastri • Aini Alifatin
Neny Triana • Roma Sitio



BUKU REFERENSI

KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN

KETERAMPILAN KLINIS, HUBUNGAN

PROFESIONAL, DAN KESELAMATAN

PASIEN

Penulis:

Wijayanti, S.Kep, Ns., M.Kep.

Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sulastri, SKp., M.Kep.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Dr. Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep.

Dr. Ns. Roma Sitio, M.Kep.



Buku Referensi Komunikasi Terapeutik Keperawatan Keterampilan Klinis, Hubungan Profesional, dan Keselamatan Pasien

Penulis:

Wijayanti, S.Kep, Ns., M.Kep.
Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sulastri, SKp., M.Kep.
Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.
Dr. Nenry Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep.
Dr. Ns. Roma Sitio, M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-00-8

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul Komunikasi Terapeutik Keperawatan: Keterampilan Klinis, Hubungan Profesional, dan Keselamatan Pasien ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan komunikasi terapeutik sebagai bagian penting dari praktik keperawatan profesional.

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam praktik klinis, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan medis atau keperawatan, tetapi juga oleh kemampuan perawat dalam membangun hubungan saling percaya, memahami kebutuhan pasien, memberikan informasi yang jelas, serta menciptakan suasana pelayanan yang aman, nyaman, dan menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik menjadi fondasi utama dalam hubungan perawat dengan pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan lainnya.

Buku referensi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, teknik, dan penerapan komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan. Pembahasan dalam buku ini mencakup dasar-dasar komunikasi terapeutik, tahapan hubungan terapeutik, keterampilan mendengarkan aktif, empati, validasi perasaan, pemberian edukasi kesehatan, komunikasi dalam situasi sulit, komunikasi dengan pasien pada berbagai tahap usia, serta komunikasi dalam konteks pelayanan klinis yang kompleks. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam membangun hubungan profesional dan meningkatkan keselamatan pasien.

Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman, menurunkan kepuasan pasien, menghambat proses penyembuhan, bahkan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelayanan. Sebaliknya, komunikasi yang efektif, empatik, dan terarah dapat membantu pasien merasa didengar, dipahami, dan dilibatkan dalam proses perawatan. Hal ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan bersama, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, memperkuat hubungan profesional, serta menciptakan budaya keselamatan pasien di lingkungan pelayanan kesehatan.

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kontak paling sering dengan pasien dituntut untuk mampu menerapkan komunikasi terapeutik secara konsisten,

baik dalam kondisi stabil maupun kritis. Kemampuan ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kepekaan, kesabaran, keterampilan interpersonal, etika, serta sikap profesional. Dengan komunikasi yang baik, perawat dapat melakukan pengkajian yang lebih akurat, memberikan intervensi yang tepat, mengurangi kecemasan pasien, serta mendukung pemulihan fisik dan psikologis secara menyeluruh.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Melalui penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu membantu pembaca memahami komunikasi terapeutik tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai keterampilan klinis yang harus diterapkan dalam setiap interaksi pelayanan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, keluasan pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku referensi Komunikasi Terapeutik Keperawatan: Keterampilan Klinis, Hubungan Profesional, dan Keselamatan Pasien ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu rujukan yang mendukung terbentuknya perawat yang profesional, komunikatif, empatik, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang aman, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I KONSEP DASAR KOMUNIKASI TERAPEUTIK (TUJUAN, PRINSIP, EMPATI, KOMUNIKASI VERBAL–NONVERBAL, DAN KERAHASIAAN) 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Komunikasi Terapeutik.....	2
C. Tujuan Komunikasi Terapeutik.....	3
D. Prinsip-Prinsip Komunikasi Terapeutik	4
E. Empati dalam Komunikasi Terapeutik.....	4
E. Komunikasi Verbal dan Nonverbal.....	9
F. Kerahasiaan (Confidentiality).....	21
G. Penutup	21
Referensi.....	23

BAB II TAHAPAN HUBUNGAN PERAWAT–KLIEN, KONTRAK TERAPEUTIK, DAN BATAS PROFESIONAL.....25

F. Pendahuluan.....	25
G. Konsep Dasar Hubungan Perawat-Klien	26
H. Tahapan Hubungan Perawat–Klien	27
I. Kontrak Terapeutik.....	30
J. Batas Profesional dalam Hubungan Perawat–Klien	32
K. Peran Komunikasi Terapeutik dalam Hubungan Perawat–Klien.....	34
L. Penelitian Terkait (Literatur Review)	36
M.Sintesis Teori.....	37
N. Penutup	39
Referensi.....	40

BAB III TEKNIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK INTI: (MENDENGAR AKTIF, KLARIFIKASI, REFLEKSI, FOKUS, VALIDASI, DAN PERTANYAAN TERBUKA).....41

A. Pendahuluan.....	41
B. Kerangka Konseptual Teknik Komunikasi Terapeutik.....	42

C. Mendengar Aktif (Active Listening).....	43
D. Klarifikasi (Clarification)	46
E. Refleksi (Reflection).....	48
F. Fokus (Focusing)	51
G. Validasi (Validation)	53
H. Pertanyaan Terbuka (Open-Ended Questions)	56
I. Integrasi Teknik dalam Praktik Klinis	58
J. Tantangan dan Kesalahan Umum.....	59
K. Implikasi terhadap Keselamatan Pasien	60
L. Penutup	60
Referensi.....	61

BAB IV KOMUNIKASI PADA SITUASI KLINIS KHUSUS (NYERI, CEMAS, MARAH, BERDUKA, PENOLAKAN TINDAKAN, DAN PASIEN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS) 65

A. Pendahuluan.....	65
B. Komunikasi terapeutik	65
C. Definisi Nyeri, Cemas, Marah, dan Berduka	68
D. Komunikasi.....	69
E. Teknik Komunikasi.....	77
F. Aplikasi Komunikasi Terapeutik Pada Masalah Khusus	78
G. Penerapan Empat Fase Komunikasi Terapeutik—Pra-Interaksi, Orientasi, Kerja, Dan Terminasi.	78
H. Penutup	80
Referensi.....	80

BAB V KOMUNIKASI DENGAN KELUARGA DAN CAREGIVER (FAMILY CONFERENCE, SHARED DECISION-MAKING, EDUKASI, DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL) 85

A. Pendahuluan.....	85
B. Konsep Komunikasi dengan Keluarga dan <i>Caregiver</i>	87
C. Family Conference dalam Pelayanan Kesehatan	91
D. Shared Decision-Making dalam Pelayanan Kesehatan.....	93
E. Edukasi Kesehatan	95
F. Dukungan Psikososial	97
G. Komunikasi dalam Situasi Sulit (<i>Difficult Conversations</i>)	98

H. Pendekatan Budaya dalam Komunikasi dengan Keluarga	99
I. Evaluasi Efektivitas Komunikasi dengan Keluarga	100
J. Penutup	101
Referensi.....	102

BAB VI KOMUNIKASI KOLABORATIF ANTARPROFESI DAN KESELAMATAN PASIEN (SBAR, HANDOVER, KOMUNIKASI KRITIS, DAN PENCEGAHAN MISKOMUNIKASI.....	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Landasan Teoretis Komunikasi Kolaboratif Antarprofesi	109
C. SBAR sebagai model standarisasi komunikasi klinis.....	118
D. Handover dan Continuity of Care	126
E. Komunikasi Kritis dalam Situasi High-Risk	131
F. Miskomunikasi sebagai Akar Insiden Keselamatan Pasien.....	138
G. Strategi Pencegahan Miskomunikasi dan Penguatan Sistem.....	143
H. Transformasi Komunikasi Klinis di Era Digital	150
I. Penutup	158
Referensi.....	159
PROFIL PENULIS	175

BAB I

KONSEP DASAR KOMUNIKASI TERAPEUTIK (TUJUAN, PRINSIP, EMPATI, KOMUNIKASI VERBAL- NONVERBAL, DAN KERAHASIAAN)

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan komponen fundamental dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan karena menjadi sarana utama dalam membangun hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam konteks klinis, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi medis, tetapi juga sebagai intervensi terapeutik yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis, emosional, dan bahkan hasil klinis pasien. Interaksi yang efektif antara perawat dan pasien terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Komunikasi adalah proses dinamis yang melibatkan pertukaran informasi, emosi, dan makna antara individu dalam konteks sosial dan profesional. Dalam praktik keperawatan, komunikasi menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik yang memungkinkan perawat memahami kebutuhan pasien secara holistik, baik aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

Komunikasi terapeutik secara khusus didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berorientasi pada tujuan penyembuhan pasien. Konsep ini menekankan bahwa setiap interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien harus memiliki nilai terapeutik, yaitu membantu pasien mengatasi masalah kesehatan, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam literatur keperawatan, komunikasi terapeutik juga dipandang sebagai bagian integral dari intervensi keperawatan yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan klinis lainnya.

Dalam buku klasik keperawatan oleh Hildegard E. Peplau, komunikasi merupakan inti dari teori *Interpersonal Relations in Nursing*, yang menekankan bahwa hubungan antara perawat dan pasien berkembang melalui interaksi komunikasi yang sistematis. Peplau menyatakan bahwa hubungan terapeutik yang efektif dapat membantu pasien memahami kondisi dirinya, mengembangkan

mekanisme koping, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan (Peplau, 2004).

Dalam praktik keperawatan modern, komunikasi terapeutik dipandang sebagai kompetensi inti (*core competency*) yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan penurunan kesalahan medis. Studi terbaru dalam jurnal keperawatan internasional menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dapat berdampak negatif terhadap hasil perawatan pasien, sementara komunikasi terapeutik yang baik meningkatkan outcome klinis dan kepuasan pasien (Abraham et al., 2024).

Komunikasi terapeutik tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi klinis, tetapi juga mencakup aspek empati, kepercayaan, dukungan emosional, dan hubungan interpersonal yang efektif. Komunikasi terapeutik melibatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memahami perasaan pasien, memberikan respon yang tepat, serta membangun hubungan yang mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh (Abdolrahmi et al., 2017). Selain itu, pendekatan komunikasi terapeutik sangat erat kaitannya dengan konsep *patient-centered care*, yaitu pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh proses perawatan. Dalam pendekatan ini, komunikasi menjadi alat utama untuk memahami preferensi, nilai, dan kebutuhan pasien sehingga pelayanan yang diberikan lebih personal dan efektif. Komunikasi yang berfokus pada pasien dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan serta memperbaiki hasil kesehatan jangka panjang.

Dengan demikian, penguasaan komunikasi terapeutik menjadi syarat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemampuan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam berbicara, tetapi juga kemampuan interpersonal seperti empati, mendengarkan aktif, serta memahami komunikasi verbal dan nonverbal. Tanpa komunikasi terapeutik yang efektif, hubungan perawat-pasien tidak akan optimal, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penyembuhan pasien.

B. Pengertian Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan klien yang berlangsung selama perawat berfokus pada kebutuhan khusus klien untuk mempromosikan pertukaran informasi yang efektif (Videbeck, 2011).

Komunikasi terapeutik adalah hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien (klien), dalam hubungan ini perawat dan pasien memperoleh pengalaman

belajar bersama sebagai upaya untuk memperbaiki pengalaman emosional pasien (Stuart, 2013).

Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain (Northouse, 1998).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan untuk tujuan terapi sehingga dapat membantu mengatasi masalah pasien.

C. Tujuan Komunikasi Terapeutik

Tujuan dari komunikasi terapeutik diarahkan pada pertumbuhan dan kesejahteraan pasien yang meliputi beberapa dimensi (Stuart, 2013).

1. Meningkatkan realisasi diri, penerimaan diri, dan meningkatkan harga diri.
2. Rasa identitas personal yang jelas dan meningkatkan integrasi personal.
3. Kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang tidak superfisial, saling bergantung dengan kapasitas untuk memberi dan menerima kasih sayang.
4. Memperbaiki fungsi dan meningkatkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan dan mencapai tujuan pribadi yang realistis.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai aspek pengalaman hidup pasien dieksplorasi. Perawat meminta pasien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dan menghubungkannya dengan observasi dan perilaku yang dilaporkan pasien, mengklarifikasi area konflik dan kecemasan. Perawat mengidentifikasi dan memaksimalkan kekuatan ego klien dan mendorong sosialisasi dan hubungan dengan keluarga. Bersama-sama klien dan perawat mengoreksi masalah komunikasi dan memodifikasi pola perilaku maladaptif dengan menguji pola perilaku baru dan mekanisme koping yang lebih adaptif (Wheeler, 2011).

Menurut (Videbeck, 2011), tujuan dari komunikasi terapeutik diantaranya adalah:

1. Membangun hubungan terapeutik perawat-klien dengan bersikap empati, tulus, peduli dan menerima klien tanpa syarat terlepas dari perilaku atau keyakinannya.
2. Secara aktif mendengarkan klien untuk mengidentifikasi masalah klien dan merumuskan tujuan yang berpusat pada klien.
3. Mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi klien terhadap masalah dan menumbuhkan empati dalam hubungan perawat-klien.
4. Mengeksplorasi pikiran dan perasaan klien.
5. Memfasilitasi ekspresi pikiran dan perasaan klien
6. Mengajarkan klien untuk mengembangkan keterampilan baru dalam pemecahan masalah.

7. Menerapkan intervensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien.
8. Membimbing klien untuk mengidentifikasi rencana tindakan yang memuaskan dan resolusi yang dapat diterima secara sosial..

D. Prinsip-Prinsip Komunikasi Terapeutik

Beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dalam membangun dan mempertahankan hubungan terapeutik, diantaranya (Paula et al., 2021):

1. Hubungan perawat dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan ini didasarkan pada prinsip "*humanity of nurse and client*". Kualitas hubungan perawat dan klien ditentukan oleh bagaimana klien mendefinisikan dirinya sebagai manusia (*human*), dan hubungan ini tidak hanya sekedar hubungan seorang penolong dengan kliennya tetapi lebih dari itu, yaitu suatu hubungan antar manusia yang bermartabat .
2. Perawat harus menghargai keunikan klien. Setiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, perawat perlu memahami perasaan dan perilaku klien dengan melihat latar belakang budaya, keluarga dan keunikan setiap individu.
3. Komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri orang yang terlibat komunikasi baik pemberi maupun penerima pesan. Dengan demikian perawat harus mampu menjaga harga diri klien dan dirinya.
4. Komunikasi yang menciptakan hubungan saling percaya (*trust*) harus tercapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah(Stuart, 1998). Kunci dari komunikasi terapeutik adalah hubungan saling percaya antara perawat dengan klien. Kepercayaan terbangun saat klien yakin, perawat menunjukkan integritas dan keandalan. Kepercayaan berkembang ketika klien yakin bahwa perawat akan konsisten dalam perkataan dan tindakannya serta dapat diandalkan untuk melakukan apa yang dia katakan. Beberapa perilaku perawat yang dapat membantu membangun kepercayaan klien adalah peduli, keterbukaan, objektivitas, hormat, ketertarikan, memahami, konsistensi, memperlakukan klien sebagai manusia, memberi saran, mendengarkan, menepati janji, kejujuran (Videbeck, 2011). Hubungan terapeutik perawat-klien memungkinkan untuk mengembangkan kepercayaan sehingga klien dapat menerima bantuan yang ditawarkan (Warelow et al., 2008).

E. Empati dalam Komunikasi Terapeutik

Empati merupakan salah satu komponen paling esensial dalam komunikasi terapeutik, khususnya dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan. Dalam interaksi klinis, empati tidak hanya berfungsi sebagai bentuk respon emosional,

tetapi juga sebagai alat profesional untuk memahami kondisi pasien secara holistik. Kemampuan tenaga kesehatan dalam menunjukkan empati terbukti berperan penting dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Empati merupakan konsep sentral dalam komunikasi terapeutik dan praktik keperawatan karena berperan dalam membangun hubungan interpersonal yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Empati dipandang sebagai kemampuan multidimensional yang melibatkan aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Meskipun tidak terdapat satu definisi tunggal yang disepakati secara universal, empati secara umum dipahami sebagai kemampuan untuk memahami dan merespons pengalaman emosional orang lain secara tepat.

Dalam konteks keperawatan, empati dipandang sebagai keterampilan klinis yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Empati merupakan elemen kunci dalam komunikasi terapeutik yang membantu meningkatkan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, dan hasil klinis secara keseluruhan (Abdolrahmi et al., 2017).

1. Definisi Empati

Secara umum, empati dapat didefinisikan sebagai:

- a. Kemampuan memahami perasaan dan pengalaman pasien
- b. Kemampuan merasakan kondisi emosional pasien secara proporsional
- c. Kemampuan mengekspresikan kepedulian secara tulus dan profesional

Dalam kajian klinis, empati juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami perspektif pasien, mengenali emosi mereka, serta merespons secara tepat tanpa kehilangan batas profesional (Rohani et al., 2018).

Selain itu, dalam perspektif yang lebih luas, empati mencakup tiga komponen utama:

- a. Kognitif, memahami perspektif pasien
- b. Afektif, merasakan emosi pasien
- c. Perilaku, mengekspresikan pemahaman tersebut

Pendekatan multidimensional ini menunjukkan bahwa empati bukan hanya “merasakan”, tetapi juga melibatkan proses berpikir dan tindakan dalam interaksi klinis (van Dijke et al., 2020).

2. Konsep Empati

Terdapat empat atribut utama empati dalam konteks pelayanan Kesehatan (Wiseman, 1996):

- a. Melihat dunia dari perspektif pasien

Kemampuan untuk memahami pengalaman pasien dari sudut pandang mereka (perspective-taking), bukan dari sudut pandang tenaga kesehatan.

- b. Tidak menghakimi (*non-judgmental*)

Tenaga kesehatan harus menerima pasien tanpa penilaian moral atau bias pribadi.

c. Memahami perasaan pasien

Melibatkan kemampuan mengenali dan memahami kondisi emosional pasien secara akurat.

d. Mengkomunikasikan pemahaman tersebut

Empati tidak cukup hanya dirasakan, tetapi harus disampaikan kepada pasien melalui komunikasi verbal maupun nonverbal.

Konsep ini menegaskan bahwa empati adalah proses aktif yang melibatkan pemahaman sekaligus komunikasi.

3. Komponen Empati

Empati dalam praktik keperawatan merupakan kemampuan multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan komunikatif yang memungkinkan tenaga kesehatan memahami serta merespons pengalaman pasien secara tepat (Hall & Schwartz, 2019). Empati penting karena berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hubungan terapeutik antara perawat dan pasien serta berdampak pada hasil kesehatan yang lebih baik (Mercer & Reynolds, 2002). Terdapat tiga komponen empati, meliputi (van Dijke et al., 2020):

a. Empati sebagai kemampuan atau Tindakan, yaitu kapasitas dasar yang dimiliki perawat untuk memahami pasien (Decety & Cowell, 2015).

1) Empati afektif

Kemampuan untuk secara emosional menyelaraskan diri atau beresonansi dengan pengalaman orang lain.

Empati afektif memungkinkan perawat untuk merasakan emosi yang dialami pasien, sehingga tercipta kedekatan emosional yang mendukung proses penyembuhan (Hall & Schwartz, 2019). Misalnya, ketika seorang pasien menangis karena diagnosis penyakit kronis, perawat yang memiliki empati afektif akan ikut merasakan kesedihan tersebut dan menunjukkan kepedulian melalui sikap hangat dan penuh perhatian (Mercer & Reynolds, 2002).

2) Empati kognitif

Kemampuan untuk membayangkan pengalaman orang lain.

Empati kognitif memungkinkan perawat memahami kondisi pasien melalui sudut pandang pasien itu sendiri tanpa harus larut secara emosional (Decety & Cowell, 2015). Dalam praktiknya, perawat dapat memahami bahwa pasien yang tampak marah sebenarnya sedang mengalami kecemasan atau ketakutan terhadap prosedur medis yang akan dijalani. Dengan

kemampuan ini, perawat dapat memberikan respons yang lebih rasional dan tepat sesuai kebutuhan pasien (Hall & Schwartz, 2019).

3) Empati perseptif

Kemampuan untuk secara langsung memahami pengalaman orang lain.

Empati perseptif melengkapi kedua kemampuan tersebut dengan memungkinkan perawat menangkap kondisi emosional pasien secara langsung melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau perubahan perilaku. Sebagai contoh, perawat dapat menyadari bahwa pasien lansia yang diam dan menghindari kontak mata mungkin sedang mengalami rasa nyeri atau ketidaknyamanan meskipun tidak mengungkapkannya secara verbal (Morgan, 2017). Kemampuan ini sangat penting dalam situasi di mana pasien sulit berkomunikasi secara langsung.

b. Empati sebagai pengalaman

Empati sebagai pengalaman internal, yaitu bagaimana perawat memproses pemahaman terhadap kondisi pasien dalam dirinya (Oxley, 2019).

1) Empati sebagai mengetahui (knowing)

Kesadaran atau pemahaman terhadap pengalaman orang lain.

Empati sebagai mengetahui mengacu pada pemahaman kognitif terhadap situasi pasien, seperti memahami bahwa pasien merasa cemas karena kurangnya informasi tentang penyakitnya (Hall & Schwartz, 2019). Dalam praktiknya, perawat dapat menunjukkan pemahaman ini dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi pasien dan memberikan penjelasan yang jelas serta mudah dipahami (Mercer & Reynolds, 2002)).

2) Empati sebagai merespons

Respons batin atau afektif terhadap pengalaman orang lain.

Empati sebagai merespons melibatkan respons emosional terhadap kondisi pasien, yang mendorong perawat untuk memberikan dukungan secara lebih manusiawi (Decety & Cowell, 2015). Misalnya, ketika pasien merasa takut sebelum operasi, perawat dapat menunjukkan empati dengan memberikan dukungan emosional seperti menenangkan pasien dan meyakinkan bahwa ia tidak sendirian (Morgan, 2017). Respons ini membantu mengurangi kecemasan pasien dan meningkatkan rasa aman (Mercer & Reynolds, 2002).

c. Empati sebagai ekspresi atau komunikasi

Empati sebagai ekspresi yaitu bagaimana pemahaman dan perasaan empatik disampaikan kepada pasien.

1) Ekspresi kognitif

Mengungkapkan pemahaman empatik seseorang dan memeriksa keakuratannya. Ekspresi kognitif terjadi ketika perawat mengungkapkan

pemahamannya terhadap kondisi pasien untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan sudah tepat (Mercer & Reynolds, 2002). Sebagai contoh, perawat dapat berkata, "Saya melihat Anda tampak khawatir tentang hasil pemeriksaan, apakah benar demikian?" sehingga pasien merasa dipahami dan memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi perasaannya (Hall & Schwartz, 2019).

2) Ekspresi afektif

Mengungkapkan emosi empatik seseorang serta memeriksa apakah emosi tersebut serupa atau selaras dengan perasaan orang lain.

Ekspresi afektif melibatkan penyampaian emosi empatik secara verbal maupun nonverbal, seperti melalui sentuhan, ekspresi wajah, atau nada suara yang lembut (Oxley, 2019). Misalnya, perawat dapat menggenggam tangan pasien yang sedang cemas atau memberikan senyuman yang menenangkan sebagai bentuk dukungan emosional (Morgan, 2017). Namun, penting bahwa ekspresi ini selaras dengan kondisi pasien agar tidak terjadi ketidaksesuaian emosional (Decety & Cowell, 2015). Sebagai contoh, jika pasien merasa lega setelah mendapat kabar baik, maka perawat sebaiknya menunjukkan ekspresi positif, bukan kesedihan, agar komunikasi tetap tepat dan efektif (Hall & Schwartz, 2019).

Secara keseluruhan, ketiga komponen empati ini saling berkaitan dan membentuk proses empati yang utuh dalam praktik keperawatan (Mercer & Reynolds, 2002). Perawat tidak hanya dituntut untuk memahami pasien secara kognitif, tetapi juga merasakan secara emosional serta mampu mengkomunikasikan empati tersebut secara tepat (Morgan, 2017). Dengan demikian, empati tidak hanya menjadi keterampilan interpersonal, tetapi juga merupakan kompetensi profesional yang esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Decety & Cowell, 2015).

4. Perbedaan Empati dan Simpati

Dalam praktik klinis, empati sering disalah artikan sebagai simpati, padahal keduanya berbeda secara fundamental.

Tabel 1.1: Perbedaan Empati dan Simpati (Kourkouta & Papathanasiou, 2014)

Aspek	Empati	Simpati
Fokus	Memahami pasien	Ikut merasakan
Keterlibatan emosi	Terjaga (profesional)	Berlebihan
Dampak	Membantu pasien	Bisa mengaburkan objektivitas

Empati memungkinkan tenaga kesehatan tetap objektif dan profesional, sedangkan simpati yang berlebihan dapat mengganggu pengambilan keputusan

klinis. Empati yang tepat dapat meningkatkan hubungan terapeutik, sedangkan simpati berlebihan dapat menyebabkan *burnout* pada tenaga kesehatan dan ketergantungan emosional pasien.

5. Peran Empati dalam Hubungan Terapeutik

Empati berperan penting dalam:

- a. Membangun kepercayaan (*trust*)
- b. Mengurangi kecemasan pasien
- c. Meningkatkan keterbukaan pasien
- d. Memperkuat hubungan terapeutik

Empati merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas komunikasi terapeutik dan berdampak langsung pada hasil perawatan pasien (Abraham et al., 2024).

Selain itu, empati juga membantu:

- a. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan
- b. Mengurangi konflik antara pasien dan tenaga kesehatan
- c. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan

6. Dampak Empati terhadap Hasil Klinis

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa empati memiliki dampak signifikan terhadap:

- a. Kesehatan mental pasien
- b. Proses penyembuhan
- c. Kualitas hidup pasien

Empati yang tinggi dari tenaga kesehatan berkorelasi dengan:

- a. Penurunan tingkat kecemasan
- b. Peningkatan kenyamanan pasien
- c. Hubungan terapeutik yang lebih kuat

Dalam konteks ini, empati tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga menjadi bagian dari *evidence-based practice* dalam pelayanan kesehatan.

E. Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Dalam praktik klinis, komunikasi terapeutik selalu melibatkan dua aspek utama yaitu melalui cara verbal maupun nonverbal, baik secara konkret maupun simbolis. Perawat atau tenaga kesehatan tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga memanfaatkan gerakan tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, serta pengaturan jarak untuk menyampaikan empati, perhatian, dan dukungan kepada pasien. Keselarasan antara unsur-unsur tersebut sangat penting agar pesan yang disampaikan menjadi jelas dan membangun hubungan saling percaya. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara

komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, bahkan menghambat proses terapeutik.

1. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal menggunakan kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Bahasa verbal adalah sebuah kode yang menyampaikan makna tertentu melalui kombinasi kata-kata (Potter et al., 2021).

a. Aspek Komunikasi Verbal

Berikut adalah aspek-aspek terpenting dari komunikasi verbal.

1) Kosakata (*Vocabulary*)

Komunikasi menjadi tidak efektif apabila pengirim dan penerima tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap kosakata dan frasa. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penggunaan penerjemah profesional diperlukan saat berinteraksi dengan pasien yang menggunakan bahasa berbeda. Bahkan dalam bahasa yang sama, variasi makna dapat muncul akibat perbedaan latar belakang subkultural. Terminologi medis sering kali sulit dipahami oleh pasien awam, sehingga penggunaannya sebaiknya dibatasi pada komunikasi antar tenaga kesehatan. Selain itu, perbedaan usia juga mempengaruhi kosakata, di mana anak-anak memiliki perbendaharaan kata yang terbatas, sementara remaja cenderung menggunakan istilah yang khas dan tidak selalu dipahami oleh orang dewasa.

2) Makna Denotatif dan Konotatif (*Denotative and Connotative Meaning*)

Beberapa kata memiliki makna ganda. Penutur bahasa yang sama umumnya berbagi makna denotatif, namun makna dapat berbeda dalam konteks tertentu, seperti istilah *code* yang bagi tenaga kesehatan merujuk pada henti jantung. Selain itu, makna konotatif dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan pengalaman individu, sehingga dapat menimbulkan salah tafsir. Misalnya, istilah "serius" dapat dimaknai sebagai kondisi mendekati kematian oleh keluarga pasien, sementara bagi tenaga kesehatan hanya menunjukkan tingkat keparahan. Oleh karena itu, pemilihan kata harus dilakukan secara cermat dan jelas, terutama dalam menjelaskan kondisi atau tindakan medis, dengan menghindari istilah yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau ketakutan.

3) Kecepatan Berbicara (*Pacing*)

Percakapan akan lebih berhasil jika dilakukan dengan kecepatan yang tepat. Berbicaralah dengan agak lambat dan ucapkan kata-kata dengan jelas. Berbicara terlalu cepat, menggunakan jeda yang canggung, atau berbicara terlalu lambat dan berlebihan dapat menyampaikan pesan yang tidak diinginkan. Jeda yang panjang dan perubahan topik yang tiba-tiba dapat

memberi kesan bahwa Anda menyembunyikan sesuatu. Pikirkan sebelum berbicara dan kembangkan kesadaran akan ritme bicara Anda untuk meningkatkan kecepatan komunikasi.

4) Intonasi (*Intonation*)

Nada suara sangat mempengaruhi makna pesan. Bergantung pada intonasi, bahkan pertanyaan atau pernyataan sederhana dapat menunjukkan antusiasme, kemarahan, kepedulian, atau ketidakpedulian. Sadari nada suara untuk menghindari penyampaian pesan yang tidak diinginkan. Jika pasien menafsirkan nada suara sebagai merendahkan, hal ini akan menghambat komunikasi selanjutnya. Nada suara pasien juga memberikan informasi tentang keadaan emosional atau tingkat energinya.

5) Kejelasan dan Keringkasan (*Clarity and Brevity*)

Komunikasi yang efektif bersifat sederhana, singkat, dan langsung. Untuk kelompok tertentu seperti lansia, penggunaan kata yang lebih sedikit dapat mengurangi kebingungan. Berbicaralah perlahan, jelas, dan gunakan contoh singkat agar penjelasan lebih mudah dipahami. Mengulangi bagian penting dari pesan juga membantu memperjelas komunikasi. Ungkapan seperti "ya kan?" atau "oke?" di akhir setiap kalimat justru mengurangi kejelasan. Gunakan kalimat dan kata yang sederhana dan langsung. "Di mana letak nyeri Anda?" jauh lebih baik daripada "Saya ingin Anda menjelaskan lokasi ketidaknyamanan Anda."

6) Waktu dan Relevansi (*Timing and Relevance*)

Waktu sangat penting dalam komunikasi. Meskipun pesan sudah jelas, waktu yang tidak tepat dapat membuatnya tidak efektif. Misalnya, Perawat tidak memulai edukasi rutin ketika pasien sedang mengalami nyeri hebat atau tekanan emosional. Sering kali, waktu terbaik untuk berinteraksi adalah ketika pasien menunjukkan keinginan untuk berkomunikasi. Jika pesan relevan dengan situasi yang sedang dihadapi, maka akan lebih efektif. Ketika pasien akan menjalani operasi darurat, membahas risiko merokok kurang relevan dibandingkan menjelaskan prosedur sebelum operasi. Waktu tatap muka saat melakukan pengkajian, pemberian obat, atau tindakan merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berbicara dengan pasien serta memberikan dukungan atau edukasi. Pasien melaporkan peningkatan kepuasan, pemahaman, dan rasa aman ketika perawat memberikan informasi secara langsung di samping tempat tidur mengenai rencana perawatan.

b. Komunikasi Verbal dalam Komunikasi Terapeutik

Komunikasi verbal dalam konteks terapeutik adalah penggunaan kata-kata secara sadar, terstruktur, dan empatik untuk membantu pasien memahami kondisi dan mengekspresikan perasaannya.

1) Karakteristik

- a) Menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana
- b) Bersifat empatik dan tidak menghakimi
- c) Fokus pada pasien (patient-centered)
- d) Menggunakan teknik terapeutik khusus

2) Teknik Komunikasi Verbal Terapeutik

Teknik-teknik dari komunikasi verbal terapeutik dalam praktik keperawatan, bertujuan membangun hubungan saling percaya serta meningkatkan kualitas asuhan pasien. Beberapa teknik komunikasi verbal terapeutik, diantaranya (Lee et al., 2022).

a) Pertanyaan terbuka (*open-ended questions*)

Pertanyaan terbuka memungkinkan pasien menjawab dengan bebas tanpa dibatasi pilihan "ya" atau "tidak". Teknik ini mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan kekhawatiran secara lebih mendalam. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta memahami kondisi pasien secara holistik.

b) Refleksi (*reflection*)

Refleksi dilakukan dengan mengulang atau memparafrasekan pernyataan pasien. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa tenaga kesehatan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami apa yang disampaikan. Selain itu, refleksi membantu pasien mengeksplorasi lebih lanjut perasaan atau pikirannya.

c) Klarifikasi (*clarification*)

Klarifikasi digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang diterima sesuai dengan maksud pasien. Teknik ini dilakukan dengan meminta penjelasan tambahan atau mengonfirmasi informasi yang kurang jelas. Dengan klarifikasi, kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga komunikasi menjadi lebih akurat.

d) Diam terapeutik (*therapeutic silence*)

Diam terapeutik adalah penggunaan keheningan secara sengaja untuk memberi waktu kepada pasien berpikir, merasakan, atau mengungkapkan emosinya. Keheningan ini dapat menciptakan suasana

yang mendukung dan tidak menekan, sehingga pasien merasa dihargai dan lebih nyaman dalam berkomunikasi.

e) Memberi informasi (*giving information*)

Memberikan informasi bertujuan meningkatkan pemahaman pasien mengenai kondisi kesehatan, prosedur, atau terapi yang akan dijalani. Informasi yang jelas dan mudah dipahami membantu pasien membuat keputusan yang tepat serta mengurangi kecemasan.

Secara keseluruhan, penerapan teknik-teknik ini mendukung komunikasi yang efektif, memperkuat hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan.

3) Fungsi Komunikasi Verbal dalam Terapi

- a) Menggali informasi kondisi pasien
- b) Memberikan edukasi kesehatan
- c) Membantu pasien mengekspresikan emosi
- d) Membangun hubungan terapeutik

2. Komunikasi Nonverbal (*Nonverbal Communication*)

Komunikasi nonverbal mencakup kelima indera dan segala sesuatu yang tidak melibatkan kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Aspek nonverbal seperti nada suara, kontak mata, dan posisi tubuh sering kali sama pentingnya dengan pesan verbal. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal biasanya dipengaruhi secara tidak sadar dan lebih akurat menunjukkan makna yang sebenarnya dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal, penerima biasanya "menangkap" pesan nonverbal sebagai pesan yang sebenarnya. Semua bentuk komunikasi nonverbal itu penting, tetapi penafsirannya sering kali menjadi sulit. Menilai dan merespons pesan nonverbal merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan (Potter et al., 2021).

a. Dimensi Komunikasi Nonverbal

Beberapa dimensi komunikasi nonverbal, meliputi:

1) Penampilan Pribadi (*Personal Appearance*)

Penampilan pribadi meliputi karakteristik fisik, ekspresi wajah, cara berpakaian, dan perawatan diri. Faktor-faktor ini merupakan sarana komunikasi nonverbal yang kuat bagi pasien maupun tim kesehatan. Dalam lingkungan pelayanan kesehatan, penelitian menunjukkan bahwa pasien lebih menyukai perawat yang mengenakan seragam yang sama dalam suatu institusi. Banyak fasilitas kesehatan membatasi penggunaan perhiasan serta mengatur apakah tato tertentu harus ditutupi. Demi kebersihan, perawat sebaiknya mengikat rambut panjang dan menjaga kuku tetap pendek serta bersih. Ingat, kesan pertama sangat dipengaruhi oleh penampilan. Perawat

dapat menilai kondisi kesehatan dan status emosional pasien dari penampilannya, dan pasien juga membentuk kesan tentang profesionalisme serta kepedulian perawat dengan cara yang sama.

2) Postur dan Cara Berjalan (*Posture and Gait*)

Postur dan cara berjalan (pola berjalan) dapat menjadi bentuk ekspresi diri. Cara seseorang duduk, berdiri, dan bergerak mencerminkan sikap, emosi, konsep diri, dan kondisi kesehatan. Misalnya, postur tegak dan langkah cepat serta mantap menunjukkan rasa percaya diri dan kesejahteraan. Membungkuk ke depan menunjukkan perhatian. Postur yang terkulai dan langkah lambat serta terseret dapat menunjukkan depresi, penyakit, atau kelelahan.

3) Ekspresi Wajah (*Facial Expression*)

Wajah adalah bagian tubuh yang paling ekspresif. Ekspresi wajah menyampaikan emosi seperti terkejut, takut, marah, bahagia, dan sedih. Beberapa orang memiliki wajah tanpa ekspresi (*flat affect*), yang hanya sedikit menunjukkan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Ekspresi yang tidak sesuai adalah ekspresi wajah yang tidak sejalan dengan pesan verbal (misalnya tersenyum saat menceritakan hal yang menyedihkan). Terkadang orang tidak menyadari pesan yang disampaikan oleh ekspresi mereka. Misalnya, seorang perawat mengerutkan dahi saat berkonsentrasi melakukan tindakan, tetapi pasien dapat menafsirkannya sebagai kemarahan atau ketidaksetujuan. Pasien sangat memperhatikan perawat. Pertimbangkan dampak ekspresi wajah Anda ketika seseorang bertanya, "Apakah saya akan meninggal?" Perubahan kecil pada mata, bibir, atau otot wajah dapat mengungkapkan perasaan Anda. Walaupun sulit mengontrol semua ekspresi, usahakan untuk tidak menunjukkan keterkejutan, jijik, atau reaksi negatif lainnya di depan pasien.

4) Kontak Mata (*Eye Contact*)

Kontak mata menunjukkan kesiapan untuk berkomunikasi. Mempertahankan kontak mata saat berbicara menunjukkan rasa hormat dan kesediaan untuk mendengarkan. Kontak mata juga memungkinkan orang saling mengamati dengan lebih dekat. Kurangnya kontak mata dapat menunjukkan kecemasan, sikap defensif, ketidaknyamanan, atau kurangnya kepercayaan diri. Namun, dalam beberapa budaya, kontak mata dianggap mengganggu atau mengancam sehingga dihindari. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan budaya seseorang saat menafsirkan makna kontak mata. Gerakan mata juga menyampaikan perasaan dan emosi. Memandang dari posisi lebih tinggi dapat menunjukkan otoritas, sedangkan

berada pada tingkat mata yang sama menunjukkan kesetaraan dalam hubungan. Menyamakan posisi mata dengan orang yang sedang marah dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik.

5) Gerakan (*Gestures*)

Gerakan tubuh menekankan, memperjelas, dan memperkuat kata-kata yang diucapkan. Gerakan juga dapat memiliki makna tersendiri atau membentuk pesan bersama isyarat komunikasi lainnya. Menunjuk seseorang dengan jari dapat memiliki berbagai arti, tetapi jika disertai ekspresi marah dan suara tegas, hal tersebut bisa menjadi tuduhan atau ancaman. Menunjuk area yang sakit seringkali lebih akurat daripada menjelaskan lokasinya dengan kata-kata.

6) Suara (*Sounds*)

Suara seperti desahan, rintihan, erangan, atau tangisan juga menyampaikan perasaan dan pikiran. Jika dikombinasikan dengan komunikasi nonverbal lainnya, suara membantu menyampaikan pesan yang lebih jelas. Namun, suara dapat memiliki berbagai makna. Misalnya, rintihan bisa menunjukkan kenikmatan atau penderitaan, dan tangisan bisa menandakan kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Penting untuk mengonfirmasi makna pesan nonverbal dengan pasien agar tidak salah tafsir, misalnya: "Saya melihat Anda meringis saat bergerak, apakah Anda merasa nyeri?"

7) Teritorialitas dan Ruang Pribadi (*Territoriality and Personal Space*)

Teritorialitas adalah kebutuhan untuk memperoleh, mempertahankan, dan melindungi ruang pribadi. Wilayah atau teritorial penting karena memberikan rasa privasi, identitas, keamanan, dan kontrol. Terkadang batas wilayah terlihat jelas, seperti pagar rumah atau tirai di sekitar tempat tidur pasien di rumah sakit. Ruang pribadi bersifat tidak terlihat, bersifat individual, dan "bergerak" bersama seseorang. Dalam interaksi, orang menjaga jarak yang berbeda-beda tergantung budaya, hubungan, dan situasi. Ketika ruang pribadi terganggu, seseorang dapat bereaksi defensif dan komunikasi menjadi kurang efektif. Situasi menentukan apakah jarak antara perawat dan pasien sudah tepat. Perawat sering memasuki wilayah dan ruang pribadi pasien karena sifat pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan kepercayaan diri, kelembutan, dan rasa hormat terhadap privasi, terutama saat tindakan melibatkan kontak fisik atau area sensitif pasien.

b. Komunikasi Nonverbal dalam Komunikasi Terapeutik

Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan melalui isyarat tanpa kata, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh.

1) Bentuk Komunikasi Nonverbal dalam Terapi

Komunikasi nonverbal merupakan bagian penting dalam interaksi perawat–pasien dan mencakup berbagai perilaku tanpa kata yang menyampaikan makna dan emosi. Beberapa bentuk utama komunikasi nonverbal yang relevan dengan praktik keperawatan, dijelaskan sebagai berikut (Wanko Keutchafo et al., 2020):

a) Kontak mata (*Eye contact* – bagian dari kinesics)

Kontak mata termasuk dalam kategori *kinesics* (bahasa tubuh). Dalam studi ini, kontak mata digunakan untuk:

- (1) Menunjukkan perhatian dan keterlibatan perawat terhadap pasien
- (2) Menandakan kesiapan untuk mendengarkan
- (3) Membangun hubungan terapeutik dan kepercayaan

Namun, kontak mata juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien (misalnya lansia dengan gangguan kognitif atau budaya tertentu), karena dapat ditafsirkan secara berbeda.

b) Postur tubuh (*Body posture* – bagian dari kinesics)

Postur tubuh mencerminkan sikap dan niat perawat dalam berinteraksi. Studi menunjukkan bahwa:

- (1) Postur terbuka dan condong ke arah pasien menunjukkan empati dan keterlibatan
- (2) Postur tertutup atau menjauh dapat diartikan sebagai ketidakpedulian atau kurang minat

Postur tubuh berfungsi untuk:

- (1) Menunjukkan kehadiran (*presence*)
- (2) Menyampaikan perhatian dan penghargaan terhadap pasien

Hal ini sangat penting terutama pada pasien lansia yang mungkin sensitif terhadap isyarat nonverbal.

c) Ekspresi wajah (*Facial expression* – bagian dari kinesics)

Ekspresi wajah merupakan indikator utama emosi dalam komunikasi nonverbal. Senyuman dapat menunjukkan keramahan, penerimaan, dan dukungan. Ekspresi serius atau tegang dapat meningkatkan kecemasan pasien

Fungsi ekspresi wajah meliputi:

- (1) Menyampaikan empati dan kepedulian
- (2) Memperkuat atau memperjelas pesan verbal

Pasien sering menafsirkan kondisi emosional perawat melalui ekspresi wajah, sehingga konsistensi antara verbal dan nonverbal sangat penting.

d) Sentuhan terapeutik (*Therapeutic touch* – haptics)

Sentuhan termasuk dalam kategori *haptics* dan merupakan salah satu bentuk nonverbal yang paling sering digunakan dalam praktik keperawatan. Bentuknya meliputi:

- (1) Berjabat tangan
- (2) Memegang tangan pasien
- (3) Menepuk bahu atau memberikan pelukan ringan

Fungsi sentuhan terapeutik:

- (1) Menunjukkan kepedulian dan dukungan emosional
- (2) Memberikan rasa nyaman dan aman
- (3) Membantu membangun hubungan interpersonal

Namun, penggunaannya harus mempertimbangkan:

- (1) Preferensi pasien
- (2) Norma budaya
- (3) Kondisi klinis pasien

Komunikasi nonverbal termasuk kontak mata, postur, ekspresi wajah, dan sentuhan—berperan besar dalam:

- a) Menyampaikan empati dan perhatian
- b) Membangun hubungan terapeutik
- c) Meningkatkan kualitas perawatan

Namun, interpretasi pasien terhadap komunikasi nonverbal dapat bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki kesadaran diri (*self-awareness*) dan menyesuaikan perilaku nonverbal sesuai kebutuhan pasien.

2) Teknik Nonverbal (Model SOLER)

Model SOLER merupakan mnemonic yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi nonverbal dalam interaksi terapeutik antara perawat dan pasien. Model ini terutama berkaitan dengan *active listening* (mendengarkan aktif), di mana komunikasi tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga melalui bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian dan empati (Ernstmeyer et al., 2025).

a) S – *Sit squarely* (menghadap pasien)

Perawat dianjurkan untuk duduk dan menghadap pasien secara langsung. Posisi ini menunjukkan:

- (1) Kesiapan untuk berinteraksi
- (2) Fokus penuh kepada pasien
- (3) Keterlibatan dalam komunikasi

Posisi sejajar (*eye level*) juga membantu menciptakan hubungan yang lebih setara dan nyaman bagi pasien.

b) O – *Open posture* (postur terbuka)

Postur terbuka berarti tidak menyilangkan tangan atau kaki, serta menjaga sikap tubuh yang terbuka. Hal ini bertujuan untuk:

- (1) Menghindari kesan defensif atau menutup diri
- (2) Menunjukkan penerimaan dan kesiapan mendengarkan
- (3) Menciptakan suasana komunikasi yang aman

Postur tertutup dapat diinterpretasikan sebagai kurang tertarik atau tidak ramah oleh pasien.

c) L – *Lean forward* (condong ke pasien)

Condong sedikit ke arah pasien menandakan:

- (1) Minat dan perhatian terhadap apa yang disampaikan
- (2) Keterlibatan aktif dalam proses komunikasi
- (3) Empati terhadap kondisi pasien

Gerakan ini merupakan sinyal nonverbal bahwa perawat benar-benar mendengarkan, bukan sekadar hadir secara fisik.

d) E – *Eye contact* (kontak mata)

Kontak mata yang tepat berfungsi untuk:

- (1) Menunjukkan perhatian dan kejujuran
- (2) Membangun kepercayaan
- (3) Memperkuat hubungan terapeutik

Namun, intensitas kontak mata perlu disesuaikan dengan budaya dan kenyamanan pasien agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman

e) R – *Relax* (sikap rileks)

Sikap rileks mencerminkan:

- (1) Ketenangan dan profesionalisme
- (2) Lingkungan komunikasi yang tidak tegang
- (3) Kesiapan mendengarkan tanpa tekanan

Ketegangan atau gerakan gelisah dapat membuat pasien merasa tidak nyaman atau tidak dihargai.

Model SOLER membantu perawat menampilkan bahasa tubuh yang konsisten dengan sikap empati dan perhatian, sehingga memperkuat komunikasi terapeutik. Teknik ini merupakan bagian penting dari mendengarkan aktif, yang menekankan bahwa pesan nonverbal sama pentingnya dengan pesan verbal dalam membangun hubungan perawat-pasien.

3) Fungsi Komunikasi Nonverbal

- a) Menunjukkan empati dan perhatian
- b) Memperkuat pesan verbal
- c) Membantu pasien merasa aman
- d) Menyampaikan emosi secara lebih autentik

Dalam praktik, nonverbal sering lebih “jujur” dibanding verbal karena sulit dimanipulasi.

4) Integrasi Verbal dan Nonverbal dalam Komunikasi Terapeutik

a) Hakikat integrasi verbal dan nonverbal

Komunikasi terapeutik tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disampaikan melalui bahasa tubuh.

(1) Verbal: pilihan kata, nada suara, jeda, dan teknik seperti refleksi atau klarifikasi

(2) Nonverbal: kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sentuhan
Keduanya bekerja secara bersamaan (integratif) untuk menciptakan lingkungan yang suportif, sehingga pasien merasa dipahami, diterima dan nyaman untuk mengekspresikan diri

b) Prinsip keselarasan (*congruence*)

Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kesesuaian antara pesan verbal dan nonverbal.

(1) Jika keduanya selaras, pesan dianggap jujur, empatik, dan dapat dipercaya

(2) Jika tidak selaras, pasien dapat mengalami kebingungan atau ketidakpercayaan

Contoh:

(a) Verbal: *“Saya mengerti perasaan Anda”*

(b) Nonverbal selaras: kontak mata, anggukan, ekspresi empati → meningkatkan kepercayaan

(c) Nonverbal tidak selaras: wajah datar, menghindari kontak mata dan pesan dianggap tidak tulus

Dalam konteks ini, pasien sering lebih mempercayai isyarat nonverbal dibandingkan kata-kata jika terjadi ketidaksesuaian (Punyanunt-Carter & Maria, 2024).

c) Peran integrasi dalam keberhasilan komunikasi terapeutik

Sumber tersebut menekankan bahwa komunikasi terapeutik yang efektif:

(1) Menggunakan kombinasi teknik verbal dan nonverbal

(2) Bertujuan untuk:

(a) Mengumpulkan informasi pasien

(b) Memahami emosi dan perilaku

(c) Memberikan edukasi kesehatan

Selain itu, integrasi ini membantu:

(1) Membangun rapport (hubungan saling percaya)

(2) Meningkatkan kenyamanan psikologis pasien

(3) Mendorong keterbukaan dalam komunikasi

d) Keterkaitan dengan active listening

Integrasi verbal-nonverbal merupakan inti dari active listening, yaitu:

(1) Verbal: paraphrasing, pertanyaan terbuka, klarifikasi

(2) Nonverbal: kontak mata, postur terbuka, sikap perhatian

Keduanya menunjukkan bahwa tenaga kesehatan:

(1) Benar-benar mendengarkan

(2) Menghargai pengalaman pasien

(3) Terlibat secara emosional dan profesional

e) Dampak jika tidak terintegrasi

Ketidaksesuaian antara verbal dan nonverbal dapat menjadi hambatan komunikasi, seperti:

(1) Pasien merasa tidak dihargai

(2) Muncul ketidakpercayaan

(3) Hubungan terapeutik melemah

Sebaliknya, komunikasi yang selaras meningkatkan:

(1) Kepercayaan

(2) Kepuasan pasien

(3) Efektivitas perawatan

Keberhasilan komunikasi terapeutik sangat ditentukan oleh integrasi yang tepat antara strategi verbal dan nonverbal. Keduanya harus konsisten (*congruent*) agar pesan tersampaikan secara efektif, membangun hubungan terapeutik, dan mendukung hasil perawatan yang optimal.

5) Dampak Komunikasi Verbal & Nonverbal dalam Terapi

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik (Mersha et al., 2023):

a) Meningkatkan kepuasan pasien

b) Membantu proses penyembuhan

c) Mengurangi kecemasan pasien

d) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan

Selain itu, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan:

a) Ketidakpercayaan pasien

b) Kesalahan medis

c) Penurunan kualitas pelayanan

F. Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan merupakan prinsip etika penting dalam komunikasi terapeutik. Kerahasiaan adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk melindungi informasi pribadi pasien dari akses yang tidak berwenang.

Tujuan:

- a. Melindungi privasi pasien
- b. Meningkatkan kepercayaan pasien
- c. Menjaga profesionalisme

Dalam praktik:

- a. Informasi pasien hanya dibagikan untuk kepentingan medis
- b. Tidak membicarakan kondisi pasien di tempat umum
- c. Mengikuti kode etik dan hukum kesehatan

Komunikasi efektif harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan untuk menjaga hubungan profesional dan kepercayaan pasien (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

G. Penutup

Komunikasi terapeutik merupakan elemen fundamental dalam praktik keperawatan yang berperan tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai intervensi profesional yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis, emosional, dan hasil klinis pasien. Melalui komunikasi yang terencana, sadar, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, perawat dapat membangun hubungan terapeutik yang efektif, yang menjadi dasar dalam pemberian asuhan keperawatan yang holistik dan berpusat pada pasien (patient-centered care).

Pembahasan dalam bab ini menegaskan bahwa komunikasi terapeutik melibatkan berbagai komponen penting, mulai dari tujuan, prinsip, hingga penerapan empati sebagai inti dari hubungan interpersonal. Empati, sebagai kemampuan multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku, menjadi kunci dalam memahami pengalaman pasien secara menyeluruh serta memberikan respons yang tepat dan profesional. Selain itu, prinsip-prinsip komunikasi seperti penghargaan terhadap keunikan individu, menjaga harga diri, serta membangun kepercayaan (trust) menjadi landasan dalam menciptakan hubungan yang bermakna dan efektif.

Komunikasi terapeutik juga tidak dapat dipisahkan dari penggunaan strategi verbal dan nonverbal yang saling melengkapi. Komunikasi verbal yang efektif ditunjang oleh pemilihan kata yang tepat, kejelasan pesan, intonasi yang sesuai, serta penggunaan teknik-teknik terapeutik seperti pertanyaan terbuka, refleksi,

klarifikasi, diam terapeutik, dan pemberian informasi. Sementara itu, komunikasi nonverbal meliputi kontak mata, postur tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, dan pengaturan ruang sering kali menjadi indikator yang lebih jujur dalam menyampaikan makna dan emosi. Oleh karena itu, keselarasan (*congruence*) antara komunikasi verbal dan nonverbal menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan interaksi terapeutik.

Model komunikasi nonverbal seperti SOLER memberikan panduan praktis bagi tenaga kesehatan dalam menunjukkan sikap mendengarkan aktif (*active listening*) dan keterlibatan emosional yang autentik. Integrasi yang tepat antara kedua bentuk komunikasi ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pasien, mengurangi kecemasan, serta mendorong keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhan.

Selain aspek keterampilan komunikasi, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi terapeutik. Perlindungan terhadap informasi pasien merupakan bentuk tanggung jawab etis dan profesional yang berperan dalam menjaga privasi, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

Secara keseluruhan, komunikasi terapeutik merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki dan terus dikembangkan oleh setiap tenaga kesehatan. Penerapan komunikasi yang efektif, empatik, dan profesional tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan perawat–pasien, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta keberhasilan proses penyembuhan. Oleh karena itu, penguatan keterampilan komunikasi terapeutik perlu menjadi bagian integral dalam pendidikan dan praktik keperawatan guna mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, humanis, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdolrahmi, M., Ghiyasvandian, S., & Zakerimoghadam, M. (2017). Therapeutic communication in nursing. *Electronic Physician*, 9(8), 4968–4977. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5614280/pdf/epj-09-4968.pdf>
- Abraham, S. A., Nsatimba, F., Agyare, D. F., Agyeiwaa, J., Opoku-Danso, R., Ninnoni, J. P., Doe, P. F., Kuffour, B. O., Anumel, B. K., Berchie, G. O., Boso, C. M., Druye, A. A., Okantey, C., Owusu, G., Obeng, P., Amoadu, M., & Commey, I. T. (2024). Barriers and outcomes of therapeutic communication between nurses and patients in Africa: a scoping review. *BMC Nursing*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02038-0>
- Decety, J., & Cowell, J. M. (2015). Empathy, Justice, and Moral Behavior. *AJOB Neuroscience*, 6(3), 3–14. <https://doi.org/10.1080/21507740.2015.1047055>
- Ernstmeyer, K., Christman, E., & Editors. (2025). Chapter 2 Therapeutic Communication And The Nurse-Client Relationship. In *Nursing: Mental Health and Community Concepts [Internet]* (2nd ed.). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK617004/>
- Hall, J. A., & Schwartz, R. (2019). Empathy present and future. *The Journal of Social Psychology*, 159(3), 225–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00224545.2018.1477442>
- Kourkouta, L., & Papathanasiou, I. (2014). Communication in Nursing Practice. *Materia Socio Medica*, 26(1), 65. <https://doi.org/10.5455/msm.2014.26.65-67>
- Lee, H. J., Park, B. M., Shin, M. J., & Kim, D. Y. (2022). Therapeutic Communication Experiences of Nurses Caring for Patients with Hematology. *Healthcare*, 10(12), 1–15. <https://doi.org/10.3390/healthcare10122403>
- Mercer, S. W., & Reynolds, W. J. (2002). Empathy and quality of care. *British Journal of General Practice*, 52(SUPPL.), 9–12.
- Mersha, A., Abera, A., Tesfaye, T., Abera, T., Belay, A., Melaku, T., Shiferaw, M., Shibiru, S., Estifanos, W., & Wake, S. K. (2023). Therapeutic communication and its associated factors among nurses working in public hospitals of Gamo zone, southern Ethiopia: application of Hildegard Peplau's nursing theory of interpersonal relations. *BMC Nursing*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01526-z>
- Morgan, A. (2017). Against compassion: in defence of a “hybrid” concept of empathy. *Nursing Philosophy*, 18(3), e12148. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nup.12148>
- Northouse. (1998). *Health Communication: Strategies for Health Professionals*. Connecticut, Appleton & Lange.

- Oxley, J. C. (2019). *The Moral Dimensions of Empathy*. Palgrave Macmillan.
- Paula, V., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Hadiansyah, T., Mukhoirotin, Widodo, D., Florensa, M. V. A., Nasution, R. A., & Marlina, T. (2021). *Keperawatan Jiwa Lanjutan*. Yayasan Kita Menulis.
- Peplau, H. E. (2004). *Interpersonal Relations in Nursing: A Conceptual Frame of Reference for Psychodynamic Nursing*. Springer Pub. Co.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Punyanunt-Carter, N., & Maria. (2024). Therapeutic communication. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/therapeutic-communication#research-starter-title>
- Rohani, C., Kesbakhi, M. S., & Mohtashami, J. (2018). Clinical empathy with cancer patients: A content analysis of oncology nurses' perception. *Patient Preference and Adherence*, 12, 1089–1098. <https://doi.org/10.2147/PPA.S156441>
- Stuart, G. W. (1998). *Therapeutic Nurse-Patient Relationship dalam Stuart, G. W. & Sundeen, S. J. (1998). Principle and Practice of Psychiatric Nursing* (6th ed.). Mosby Year Book.
- Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Elsevier Mosby.
- van Dijke, J., van Nistelrooij, I., Bos, P., & Duyndam, J. (2020). Towards a relational conceptualization of empathy. *Nursing Philosophy*, 21(3), 1–9. <https://doi.org/10.1111/nup.12297>
- Videbeck, S. L. (2011). *Psychiatric–MentalHealth Nursing* (5th ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Wanko Keutchafo, E. L., Kerr, J., & Jarvis, M. A. (2020). Evidence of nonverbal communication between nurses and older adults: A scoping review. *BMC Nursing*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00443-9>
- Warelow, P., Edward, K.-L., & Vinek, J. (2008). Care: What nurses say and what nurses do. *Holistic Nursing Practice*, 22(3), 146–153.
- Wheeler, K. (2011). A relationship-based model for psychiatric nursing practice. *Perspect Psychiatr Care*, 47(3), 151–159. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2010.00285.x>
- Wiseman, T. (1996). A concept analysis of empathy. *Journal of Advanced Nursing*, 23(6), 1162–1167. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1996.12213.x>

BAB II

TAHAPAN HUBUNGAN PERAWAT–KLIEN, KONTRAK TERAPEUTIK, DAN BATAS PROFESIONAL

F. Pendahuluan

Hubungan perawat–klien merupakan inti dari praktik keperawatan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara holistik. Hubungan ini tidak hanya berfokus pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional yang mempengaruhi proses penyembuhan klien. Dalam praktiknya, hubungan terapeutik dibangun melalui interaksi yang terencana, penuh empati, serta dilandasi oleh prinsip komunikasi yang efektif. Keberhasilan asuhan keperawatan sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang terjalin antara perawat dan klien, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan tahapan hubungan tersebut (Potter et al., 2021; Stuart, 2013).

Tahapan hubungan perawat–klien secara umum terdiri dari tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Setiap tahap memiliki tujuan, karakteristik, serta intervensi komunikasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan klien. Tahap orientasi berfokus pada pembentukan kepercayaan dan pengenalan masalah, tahap kerja menekankan pada pelaksanaan intervensi keperawatan, sedangkan tahap terminasi bertujuan untuk mengakhiri hubungan secara profesional serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Proses ini harus dilakukan secara sistematis agar hubungan terapeutik dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan klien (Peplau, 1997; Townsend & Morgan, 2018).

Selain tahapan hubungan, kontrak terapeutik dan batas profesional merupakan komponen penting yang harus dijaga dalam interaksi perawat–klien. Kontrak terapeutik berfungsi sebagai kesepakatan yang mengatur waktu, tempat, dan tujuan interaksi sehingga menciptakan hubungan yang terstruktur dan aman bagi klien. Sementara itu, batas profesional diperlukan untuk menjaga hubungan tetap berada dalam koridor etika dan mencegah terjadinya pelanggaran seperti keterlibatan emosional yang berlebihan atau hubungan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Dengan memahami dan menerapkan ketiga aspek tersebut secara tepat, perawat dapat memberikan asuhan yang berkualitas, aman, dan beretika (American Nurses Association, 2015; Videbeck, 2020).

G. Konsep Dasar Hubungan Perawat-Klien

1. Pengertian Hubungan Perawat-Klien

Hubungan perawat-klien merupakan suatu interaksi profesional yang terencana antara perawat dan klien dengan tujuan membantu klien mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan terapeutik, yaitu hubungan yang berfokus pada kebutuhan klien melalui pendekatan komunikasi yang efektif, empatik, dan berorientasi pada penyembuhan. Dalam hubungan ini, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi tindakan medis, tetapi juga sebagai fasilitator, pendidik, dan pendukung dalam proses pemulihan klien (Peplau, 1997; Videbeck, 2020).

Hubungan terapeutik memiliki tujuan utama untuk membantu klien mengatasi masalah kesehatan, baik fisik maupun psikososial, serta meningkatkan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Selain itu, hubungan ini juga bertujuan untuk membangun rasa percaya antara perawat dan klien, sehingga klien merasa aman dalam mengungkapkan perasaan, keluhan, dan kebutuhannya. Dengan demikian, hubungan perawat-klien menjadi dasar dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif dan berkualitas (Potter et al., 2021).

Karakteristik hubungan profesional dalam keperawatan ditandai oleh adanya batas yang jelas, fokus pada kebutuhan klien, serta dilandasi oleh kode etik profesi. Hubungan ini bersifat terarah (goal-oriented), memiliki waktu yang terbatas sesuai kebutuhan perawatan, serta menempatkan kepentingan klien sebagai prioritas utama. Selain itu, hubungan profesional juga menuntut perawat untuk bersikap objektif, tidak terlibat secara emosional secara berlebihan, serta menjaga integritas dan tanggung jawab dalam praktik keperawatan (Stuart, 2013).

2. Prinsip Hubungan Terapeutik

Hubungan terapeutik dalam keperawatan dibangun atas beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam interaksi antara perawat dan klien.

Prinsip empati merupakan kemampuan perawat untuk memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandang klien tanpa kehilangan objektivitas. Empati memungkinkan perawat memberikan respon yang tepat dan penuh kepedulian sehingga klien merasa dipahami dan diterima (Videbeck, 2020).

Kejujuran atau genuineness mengacu pada sikap perawat yang tulus, terbuka, dan tidak dibuat-buat dalam berinteraksi dengan klien. Sikap ini penting untuk menciptakan hubungan yang autentik dan meningkatkan kepercayaan klien terhadap perawat (Townsend & Morgan, 2018).

Kepercayaan (trust) merupakan dasar dari hubungan terapeutik yang efektif. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, kejujuran, serta kemampuan perawat

dalam menjaga komitmen dan kerahasiaan klien. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan terapeutik tidak dapat berkembang secara optimal.

Respek terhadap klien berarti menghargai martabat, nilai, keyakinan, dan pilihan klien tanpa diskriminasi. Perawat harus mampu menerima klien apa adanya serta memberikan pelayanan yang adil dan bermartabat.

Kerahasiaan (confidentiality) merupakan prinsip etika yang mengharuskan perawat menjaga informasi pribadi klien agar tidak disebarluaskan tanpa izin. Hal ini penting untuk melindungi privasi klien dan meningkatkan rasa aman dalam hubungan terapeutik (American Nurses Association, 2015).

3. Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Perawat–Klien

Hubungan perawat–klien dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari perawat, klien, maupun lingkungan pelayanan kesehatan.

Faktor perawat meliputi pengetahuan, keterampilan komunikasi, sikap, serta pengalaman klinis. Perawat yang memiliki pengetahuan yang baik dan keterampilan komunikasi terapeutik yang efektif akan lebih mampu membangun hubungan yang positif dengan klien. Selain itu, sikap empatik, sabar, dan tidak menghakimi juga sangat berperan dalam keberhasilan hubungan terapeutik (Potter et al., 2021).

Faktor klien mencakup kondisi fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Klien dengan kondisi sakit berat, kecemasan tinggi, atau gangguan psikologis mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau mempercayai perawat. Selain itu, perbedaan latar belakang budaya, bahasa, dan nilai juga dapat mempengaruhi cara klien berinteraksi dengan perawat sehingga memerlukan pendekatan yang sensitif budaya (Stuart, 2013).

Lingkungan pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan perawat–klien. Lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung privasi akan mempermudah terjalinnya komunikasi yang efektif. Sebaliknya, lingkungan yang bising, kurang privasi, atau beban kerja perawat yang tinggi dapat menghambat interaksi terapeutik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hubungan perawat–klien (Townsend & Morgan, 2018).

H. Tahapan Hubungan Perawat–Klien

1. Tahap Orientasi

Tahap orientasi merupakan tahap awal dalam hubungan perawat–klien yang dimulai sejak pertemuan pertama antara perawat dan klien. Pada tahap ini, perawat berusaha membangun hubungan saling percaya serta mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dialami klien. Tahap orientasi menjadi fondasi

penting bagi keberhasilan hubungan terapeutik selanjutnya (Peplau, 1997; Videbeck, 2020).

Tujuan utama tahap orientasi adalah membangun kepercayaan, menciptakan rasa aman, serta menyepakati tujuan dan rencana interaksi antara perawat dan klien. Pada tahap ini juga dilakukan klarifikasi peran perawat dan harapan klien sehingga hubungan yang terbentuk menjadi jelas, terarah, dan profesional (Stuart, 2013).

Kegiatan yang dilakukan pada tahap orientasi meliputi beberapa hal berikut:

Perkenalan diri dilakukan oleh perawat dengan menyebutkan nama, peran, dan tujuan interaksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memperjelas posisi perawat dalam hubungan terapeutik. Perkenalan yang baik akan mempermudah terbentuknya komunikasi yang efektif.

Identifikasi masalah dilakukan melalui pengkajian awal terhadap kondisi klien, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Perawat menggali keluhan utama, riwayat kesehatan, serta persepsi klien terhadap penyakitnya. Proses ini penting untuk menentukan fokus asuhan keperawatan (Potter et al., 2021).

Penjelasan peran perawat bertujuan agar klien memahami fungsi perawat sebagai pemberi asuhan, pendidik, dan pendukung. Kejelasan peran akan mencegah kesalahpahaman serta meningkatkan kerja sama antara perawat dan klien.

Pembentukan kepercayaan dilakukan melalui sikap empati, kejujuran, dan konsistensi perawat. Kepercayaan merupakan dasar hubungan terapeutik yang memungkinkan klien terbuka dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhannya (Townsend & Morgan, 2018).

Namun, tahap orientasi juga dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti kecemasan klien, kurangnya keterampilan komunikasi perawat, perbedaan budaya atau bahasa, serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Hambatan ini dapat mengganggu proses pembentukan hubungan terapeutik sehingga perlu diantisipasi oleh perawat (Videbeck, 2020).

2. Tahap Kerja (Working Phase)

Tahap kerja merupakan fase inti dalam hubungan perawat–klien, di mana perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi pada tahap orientasi. Pada tahap ini, intervensi keperawatan dilakukan secara aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Peplau, 1997).

Tujuan tahap kerja adalah membantu klien memahami kondisi kesehatannya, mengembangkan mekanisme koping yang efektif, serta meningkatkan kemampuan klien dalam mengatasi masalah kesehatan secara

mandiri. Tahap ini menuntut keterlibatan aktif dari kedua belah pihak (Stuart, 2013).

Aktivitas utama dalam tahap kerja meliputi:

Pengkajian mendalam dilakukan untuk menggali informasi lebih rinci mengenai kondisi klien. Perawat mengeksplorasi aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual yang mempengaruhi kesehatan klien.

Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah klien, baik berupa tindakan mandiri maupun kolaboratif. Intervensi disesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan (Potter et al., 2021).

Pemberian edukasi bertujuan meningkatkan pengetahuan klien tentang penyakit, pengobatan, dan perawatan diri. Edukasi membantu klien menjadi lebih mandiri dan berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan.

Dukungan emosional diberikan untuk membantu klien mengatasi stres, kecemasan, atau ketakutan yang dialami. Perawat berperan sebagai pendengar yang baik dan memberikan motivasi kepada klien (Videbeck, 2020).

Komunikasi terapeutik memiliki peran penting dalam tahap kerja, karena menjadi sarana utama dalam membangun hubungan yang efektif dan membantu klien mengekspresikan perasaan serta pikirannya. Teknik seperti mendengarkan aktif, refleksi, dan klarifikasi sangat diperlukan dalam fase ini (Townsend & Morgan, 2018).

Evaluasi respon klien dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan. Perawat mengamati perubahan kondisi klien serta menyesuaikan rencana asuhan jika diperlukan.

3. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap akhir dalam hubungan perawat–klien yang menandai berakhirnya interaksi terapeutik. Tahap ini dapat terjadi karena tujuan telah tercapai atau karena berakhirnya periode perawatan. Terminasi harus dilakukan secara profesional untuk memberikan penutupan yang positif bagi klien (Peplau, 1997).

Terdapat dua jenis terminasi, yaitu:

Terminasi sementara, yaitu pengakhiran hubungan dalam jangka pendek, misalnya pada akhir shift atau pertemuan sementara, dengan rencana untuk melanjutkan interaksi di waktu berikutnya.

Terminasi akhir, yaitu pengakhiran hubungan secara permanen karena tujuan telah tercapai, klien pulang, atau dirujuk ke layanan lain (Stuart, 2013).

Tujuan tahap terminasi adalah mengevaluasi hasil asuhan keperawatan, meningkatkan kemandirian klien, serta mempersiapkan klien menghadapi kondisi tanpa ketergantungan pada perawat.

Kegiatan pada tahap terminasi meliputi:

Evaluasi hasil dilakukan dengan menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada awal hubungan. Perawat dan klien bersama-sama merefleksikan perkembangan yang telah dicapai.

Reinforcement kemampuan klien bertujuan memperkuat kemampuan klien dalam mengatasi masalah secara mandiri. Perawat memberikan penghargaan dan dorongan positif terhadap kemajuan klien.

Perencanaan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan perawatan, seperti edukasi lanjutan, kontrol rutin, atau rujukan ke layanan lain (Potter et al., 2021).

Pada tahap terminasi, baik perawat maupun klien dapat mengalami reaksi emosional seperti sedih, kehilangan, atau bahkan lega. Perawat perlu membantu klien mengelola perasaan tersebut secara adaptif agar proses terminasi berjalan dengan baik (Videbeck, 2020).

I. Kontrak Terapeutik

1. Pengertian Kontrak Terapeutik

Kontrak terapeutik merupakan kesepakatan yang dibuat antara perawat dan klien dalam hubungan terapeutik yang mencakup tujuan, waktu, tempat, serta aturan interaksi selama proses asuhan keperawatan. Kontrak ini menjadi landasan dalam membangun hubungan profesional yang terarah dan sistematis, sehingga interaksi yang terjadi tidak bersifat spontan, melainkan direncanakan sesuai kebutuhan klien (Videbeck, 2020).

Dalam hubungan terapeutik, kontrak berfungsi sebagai pedoman yang mengatur batasan dan ekspektasi antara perawat dan klien. Fungsi utama kontrak adalah memberikan struktur dalam hubungan, memperjelas peran masing-masing pihak, serta menciptakan rasa aman bagi klien. Selain itu, kontrak juga membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dan meminimalkan kesalahpahaman selama proses asuhan keperawatan (Townsend & Morgan, 2018).

2. Komponen Kontrak Terapeutik

Kontrak terapeutik terdiri dari beberapa komponen utama yang harus disepakati oleh perawat dan klien agar hubungan berjalan efektif.

Waktu (*time*) mengacu pada kapan interaksi dilakukan, termasuk jadwal pertemuan antara perawat dan klien. Penentuan waktu yang jelas membantu

klien merasa dihargai serta mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam interaksi.

Tempat (*place*) berkaitan dengan lokasi dilakukannya interaksi terapeutik. Tempat yang nyaman, tenang, dan menjaga privasi sangat penting untuk mendukung komunikasi yang efektif.

Topik pembicaraan mencakup hal-hal yang akan dibahas selama interaksi, seperti masalah kesehatan, perasaan klien, atau rencana perawatan. Penentuan topik membantu menjaga fokus pembicaraan agar tetap sesuai tujuan.

Peran dan tanggung jawab menjelaskan fungsi perawat sebagai pemberi asuhan dan peran klien sebagai individu yang aktif dalam proses penyembuhan. Kejelasan ini penting untuk menciptakan kerja sama yang efektif.

Durasi interaksi menunjukkan lamanya waktu setiap pertemuan berlangsung. Durasi yang jelas membantu menjaga konsistensi dan efisiensi dalam hubungan terapeutik (Stuart, 2013).

3. Tujuan dan Manfaat Kontrak Terapeutik

Kontrak terapeutik memiliki berbagai tujuan dan manfaat dalam praktik keperawatan.

Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kepercayaan antara perawat dan klien. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, klien merasa lebih aman dan percaya terhadap perawat.

Selain itu, kontrak terapeutik berfungsi untuk menciptakan struktur hubungan, sehingga interaksi menjadi lebih terarah dan profesional. Struktur ini membantu menghindari hubungan yang terlalu personal atau tidak sesuai dengan batas profesional.

Kontrak juga berperan dalam mengurangi kecemasan klien, karena klien mengetahui apa yang akan terjadi selama proses perawatan. Kepastian ini memberikan rasa kontrol dan kenyamanan bagi klien.

Lebih lanjut, kontrak terapeutik membantu memfasilitasi pencapaian tujuan terapi dengan memastikan bahwa setiap interaksi berfokus pada kebutuhan dan masalah klien secara spesifik (Videbeck, 2020; Townsend & Morgan, 2018).

4. Implementasi Kontrak Terapeutik dalam Praktik

Implementasi kontrak terapeutik dilakukan secara bertahap sesuai dengan fase hubungan perawat–klien.

Pada tahap orientasi, kontrak terapeutik diperkenalkan dan disepakati bersama. Perawat menjelaskan waktu, tempat, tujuan, serta peran masing-masing dalam hubungan tersebut. Misalnya, perawat menyampaikan bahwa interaksi akan dilakukan setiap hari selama 15–30 menit untuk membahas kondisi kesehatan klien.

Selama tahap kerja, kontrak dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi klien. Perawat dapat mengubah fokus pembicaraan atau durasi interaksi berdasarkan kebutuhan klien, namun tetap dalam kerangka kesepakatan awal.

Pada tahap terminasi, kontrak terapeutik dievaluasi untuk menilai apakah tujuan yang telah disepakati tercapai. Perawat dan klien bersama-sama merefleksikan hasil interaksi serta mempersiapkan penghentian hubungan secara profesional. Evaluasi ini penting untuk memastikan keberhasilan proses terapeutik dan meningkatkan kemandirian klien (Stuart, 2013; Potter et al., 2021).

J. Batas Profesional dalam Hubungan Perawat–Klien

1. Pengertian Batas Profesional

Batas profesional (professional boundaries) adalah garis pembatas yang mengatur hubungan antara perawat dan klien agar tetap berada dalam koridor terapeutik, etis, dan profesional. Batas ini memastikan bahwa hubungan yang terjalin berfokus pada kepentingan klien, bukan kepentingan pribadi perawat.

Menurut American Nurses Association (ANA), batas profesional adalah “struktur yang memisahkan hubungan terapeutik dari hubungan pribadi dan memastikan interaksi tetap berorientasi pada kebutuhan pasien.”

Menjaga batas profesional sangat penting karena menjamin keselamatan dan kesejahteraan klien, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan perawat-klien, menjaga integritas dan kredibilitas profesi keperawatan, menciptakan hubungan terapeutik yang efektif dan terpercaya, melindungi perawat dari risiko pelanggaran etik dan hukum

2. Jenis Batas Profesional

a. Batas Fisik

- 1) Batas fisik berkaitan dengan kontak fisik antara perawat dan klien.
- 2) Sentuhan harus bertujuan terapeutik (misalnya pemeriksaan fisik)
- 3) Menghindari sentuhan yang tidak perlu atau dapat menimbulkan salah persepsi
- 4) Menjaga privasi tubuh klien selama tindakan

b. Batas Emosional

- 1) Batas emosional mengatur keterlibatan perasaan perawat terhadap klien.
- 2) Perawat harus menunjukkan empati, bukan simpati berlebihan
- 3) Tidak membawa masalah pribadi ke dalam hubungan profesional
- 4) Menghindari ketergantungan emosional antara perawat dan klien

c. Batas Sosial

- 1) Batas sosial berkaitan dengan hubungan di luar konteks profesional.

- 2) Tidak menjalin hubungan pertemanan atau keluarga dengan klien
 - 3) Menghindari interaksi di media sosial yang tidak profesional
 - 4) Tidak menerima hadiah berlebihan dari klien
- d. Batas Komunikasi
- 1) Batas komunikasi mencakup cara berinteraksi secara verbal dan nonverbal.
 - 2) Menggunakan bahasa yang sopan, profesional, dan terapeutik
 - 3) Menghindari pembicaraan yang bersifat pribadi atau tidak relevan
 - 4) Menjaga kerahasiaan informasi klien

3. Pelanggaran Batas Profesional

- a. Overinvolvement (Terlalu Terlibat)
- Terjadi ketika perawat terlalu dekat secara emosional atau personal dengan klien.
- Contoh:
- 1) Memberikan perhatian berlebihan
 - 2) Berbagi masalah pribadi
 - 3) Mengembangkan hubungan romantis
- b. Underinvolvement (Kurang Terlibat)
- Terjadi ketika perawat kurang menunjukkan kepedulian atau keterlibatan.
- Contoh:
- 1) Bersikap acuh tak acuh
 - 2) Tidak responsif terhadap kebutuhan klien
 - 3) Kurang empati
- c. Bentuk Pelanggaran Batas
- 1) Hubungan Personal/Romantis
 - Menjalinkan hubungan cinta atau seksual dengan klien
 - Merupakan pelanggaran etik berat
 - 2) Penyalahgunaan Kekuasaan
 - Memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi
 - Misalnya meminta uang, hadiah, atau bantuan pribadi
 - 3) Pelanggaran Privasi
 - Membocorkan informasi klien tanpa izin
 - Tidak menjaga kerahasiaan data medis

4. Dampak Pelanggaran Batas Profesional

- a. Dampak pada Klien
- 1) Kehilangan rasa percaya terhadap tenaga kesehatan
 - 2) Trauma psikologis
 - 3) Gangguan proses penyembuhan
- b. Dampak pada Perawat

- 1) Sanksi etik dan disiplin
- 2) Kehilangan izin praktik
- 3) Masalah hukum dan reputasi profesional
- c. Dampak pada Institusi Pelayanan Kesehatan
 - 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat
 - 2) Risiko tuntutan hukum
 - 3) Kerusakan citra institusi

5. Strategi Menjaga Batas Profesional

- a. Kesadaran Diri (Self-Awareness)
 - 1) Memahami perasaan, nilai, dan batas pribadi
 - 2) Mengenali tanda-tanda keterlibatan berlebihan
- b. Supervisi dan Refleksi Praktik
 - 1) Diskusi dengan supervisor atau tim
 - 2) Melakukan refleksi terhadap pengalaman praktik
- c. Kepatuhan terhadap Kode Etik Keperawatan
 - 1) Perawat harus berpedoman pada kode etik dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan standar profesi.
 - 2) Mengutamakan kepentingan klien
 - 3) Menjaga profesionalitas dalam setiap tindakan
- d. Komunikasi Profesional
 - 1) Menggunakan komunikasi terapeutik
 - 2) Menetapkan batasan secara jelas sejak awal interaksi
 - 3) Menghindari komunikasi di luar konteks pelayanan

Batas profesional merupakan elemen penting dalam hubungan perawat–klien yang menjamin hubungan tetap terapeutik, aman, dan etis. Pelanggaran batas dapat berdampak serius bagi semua pihak, sehingga perawat harus memiliki kesadaran diri, kompetensi komunikasi, serta komitmen terhadap kode etik profesi.

K. Peran Komunikasi Terapeutik dalam Hubungan Perawat–Klien

1. Pengertian Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi interpersonal yang direncanakan secara sadar oleh perawat untuk membantu klien meningkatkan kesehatan fisik maupun psikologisnya. Komunikasi ini tidak hanya berfokus pada pertukaran informasi, tetapi juga bertujuan membangun hubungan saling percaya, memberikan dukungan emosional, serta membantu klien mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara terbuka (Arnold & Boggs, 2020; Videbeck, 2020).

Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik menjadi alat utama dalam membangun hubungan perawat–klien yang efektif. Melalui komunikasi yang tepat, perawat dapat memahami kebutuhan klien secara holistik, mengidentifikasi masalah secara akurat, serta memberikan intervensi yang sesuai. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi terapeutik merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap perawat (Potter et al., 2021).

2. Teknik Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi terapeutik merupakan keterampilan khusus yang digunakan perawat untuk memfasilitasi interaksi yang efektif dengan klien. Beberapa teknik utama meliputi:

Mendengarkan aktif (*active listening*) adalah kemampuan perawat untuk mendengarkan secara penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan klien, baik secara verbal maupun nonverbal. Perawat menunjukkan perhatian melalui kontak mata, bahasa tubuh yang terbuka, serta memberikan respon yang sesuai. Teknik ini membantu klien merasa dihargai dan dipahami (Arnold & Boggs, 2020).

Klarifikasi adalah teknik untuk memperjelas informasi yang disampaikan klien agar tidak terjadi kesalahpahaman. Perawat dapat mengulang atau menanyakan kembali pernyataan klien dengan kalimat yang sederhana untuk memastikan makna yang sebenarnya.

Refleksi merupakan kemampuan perawat untuk mengungkapkan kembali perasaan atau isi pembicaraan klien dengan kata-kata sendiri. Teknik ini bertujuan membantu klien memahami perasaan dan pikirannya secara lebih mendalam.

Empati verbal dan nonverbal adalah kemampuan menunjukkan pemahaman terhadap perasaan klien melalui kata-kata maupun ekspresi nonverbal seperti sentuhan terapeutik, ekspresi wajah, dan nada suara. Empati membantu memperkuat hubungan terapeutik serta meningkatkan kenyamanan klien (Videbeck, 2020; Townsend & Morgan, 2023).

3. Hambatan Komunikasi Terapeutik

Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik tidak selalu berjalan lancar karena adanya berbagai hambatan yang dapat berasal dari perawat, klien, maupun lingkungan.

Hambatan dari perawat meliputi kurangnya keterampilan komunikasi, sikap tidak empatik, penggunaan bahasa medis yang sulit dipahami, serta kurangnya waktu akibat beban kerja yang tinggi. Selain itu, prasangka atau bias pribadi juga dapat mengganggu objektivitas perawat dalam berkomunikasi (Potter et al., 2021).

Hambatan dari klien dapat berupa kondisi fisik seperti nyeri atau kelelahan, gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta perbedaan budaya

dan bahasa. Klien yang tidak percaya atau merasa takut juga cenderung sulit untuk terbuka dalam berkomunikasi.

Hambatan lingkungan meliputi kondisi ruangan yang bising, kurangnya privasi, serta suasana yang tidak nyaman. Lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi dan menghambat terciptanya komunikasi yang efektif antara perawat dan klien (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

L. Penelitian Terkait (Literatur Review)

1. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan terapeutik antara perawat dan klien memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan hasil kesehatan pasien. Penelitian oleh Forchuk et al. (2000) menemukan bahwa hubungan perawat–klien berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif serta kepercayaan yang terbangun selama interaksi. Hubungan yang baik terbukti meningkatkan keterlibatan klien dalam proses perawatan.

Selain itu, penelitian oleh Kourkouta dan Papathanasiou (2014) menegaskan bahwa komunikasi terapeutik merupakan komponen kunci dalam praktik keperawatan. Komunikasi yang efektif membantu perawat memahami kebutuhan klien secara lebih mendalam serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan.

Penelitian lain oleh Rørtveit et al. (2015) menunjukkan bahwa kepercayaan dalam hubungan perawat–klien berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien. Klien yang memiliki kepercayaan terhadap perawat cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan masalah kesehatan dan lebih patuh terhadap rencana perawatan.

Lebih lanjut, studi oleh O'Hagan et al. (2014) menyatakan bahwa keterampilan komunikasi terapeutik yang baik, seperti empati dan mendengarkan aktif, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas interaksi perawat–klien serta hasil klinis yang lebih baik.

2. Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan terapeutik dan komunikasi dalam keperawatan, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek komunikasi secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji integrasi antara tahapan hubungan perawat–klien, kontrak terapeutik, dan batas profesional dalam satu kerangka yang utuh.

Kedua, penelitian yang ada masih didominasi oleh konteks negara maju, sehingga kurang menggambarkan kondisi praktik keperawatan di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki perbedaan budaya, sistem pelayanan kesehatan, dan beban kerja perawat.

Ketiga, masih terbatas penelitian yang mengkaji implementasi kontrak terapeutik secara praktis di lapangan serta pengaruhnya terhadap keberhasilan hubungan terapeutik. Selain itu, aspek batas profesional seringkali dibahas secara teoritis, namun belum banyak diteliti secara empiris dalam praktik klinis sehari-hari.

3. Relevansi dengan Topik

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan terapeutik, komunikasi efektif, serta kepercayaan merupakan elemen penting dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tahapan hubungan perawat–klien, kontrak terapeutik, dan batas profesional.

Topik ini menjadi penting karena mengintegrasikan beberapa aspek yang saling berkaitan dalam praktik keperawatan, yaitu proses hubungan (tahapan), struktur hubungan (kontrak terapeutik), serta batasan etis (batas profesional). Dengan mengkaji ketiga aspek tersebut secara bersamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hubungan terapeutik dibangun dan dipertahankan dalam praktik klinis.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, khususnya dalam hal komunikasi terapeutik dan profesionalisme perawat. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan praktik keperawatan yang lebih efektif, aman, dan beretika.

M.Sintesis Teori

1. Ringkasan Keterkaitan Antar Konsep

Berdasarkan kajian teori pada bab ini, hubungan perawat–klien merupakan inti dari praktik keperawatan yang dibangun melalui proses interpersonal yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan klien. Hubungan ini berkembang melalui tiga tahapan utama, yaitu orientasi, kerja, dan terminasi, yang masing-masing memiliki tujuan dan peran penting dalam keberhasilan asuhan keperawatan (Peplau, 1997; Stuart, 2021).

Tahapan hubungan perawat–klien tidak dapat dipisahkan dari komunikasi terapeutik sebagai alat utama dalam membangun dan mempertahankan hubungan tersebut. Komunikasi terapeutik memungkinkan perawat untuk

memahami kondisi klien secara holistik, membangun kepercayaan, serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan klien selama proses perawatan. Teknik komunikasi seperti mendengarkan aktif, empati, refleksi, dan klarifikasi menjadi komponen penting dalam setiap tahap hubungan (Arnold & Boggs, 2020).

Selain itu, kontrak terapeutik berperan sebagai struktur yang mengatur interaksi antara perawat dan klien, meliputi waktu, tempat, peran, serta tujuan interaksi. Kontrak ini memberikan kejelasan dan arah dalam hubungan terapeutik sehingga interaksi menjadi lebih terencana dan profesional. Di sisi lain, batas profesional berfungsi sebagai landasan etis yang menjaga hubungan tetap berada dalam koridor profesional serta mencegah terjadinya pelanggaran hubungan, baik berupa keterlibatan emosional yang berlebihan maupun penyalahgunaan peran (American Nurses Association, 2015; Videbeck, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahapan hubungan perawat–klien, komunikasi terapeutik, kontrak terapeutik, dan batas profesional merupakan konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keempat konsep ini membentuk suatu sistem yang utuh dalam praktik keperawatan, di mana keberhasilan hubungan terapeutik sangat bergantung pada integrasi yang baik antara proses, komunikasi, struktur, dan etika profesional.

2. Implikasi dalam Praktik Keperawatan Klinis

Sintesis teori ini memiliki implikasi penting dalam praktik keperawatan klinis, khususnya dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Perawat perlu memahami bahwa setiap interaksi dengan klien harus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tahapan hubungan terapeutik, dimulai dari orientasi hingga terminasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hubungan yang terbentuk memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi klien.

Selain itu, perawat dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi terapeutik yang baik sebagai kompetensi utama dalam praktik klinis. Kemampuan dalam mendengarkan aktif, menunjukkan empati, serta memberikan respon yang tepat akan membantu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan klien. Dengan demikian, komunikasi terapeutik tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai intervensi keperawatan yang efektif (Townsend & Morgan, 2023).

Penerapan kontrak terapeutik dalam praktik klinis juga menjadi hal yang penting untuk menciptakan hubungan yang profesional dan terarah. Kontrak ini membantu perawat dan klien memahami batasan serta tujuan interaksi, sehingga

dapat meningkatkan kerja sama dan mengurangi kecemasan klien selama proses perawatan.

Di sisi lain, menjaga batas profesional merupakan aspek krusial dalam praktik keperawatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika. Perawat harus mampu menjaga keseimbangan antara empati dan objektivitas, serta menghindari keterlibatan emosional yang berlebihan. Kepatuhan terhadap kode etik keperawatan menjadi pedoman utama dalam menjaga profesionalisme dan melindungi keselamatan klien.

Secara keseluruhan, integrasi antara tahapan hubungan, komunikasi terapeutik, kontrak terapeutik, dan batas profesional akan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, memperkuat hubungan perawat–klien, serta mendukung pencapaian hasil kesehatan yang optimal bagi klien.

N. Penutup

Berdasarkan uraian teori yang telah dibahas, hubungan perawat–klien merupakan fondasi utama dalam praktik keperawatan yang efektif dan profesional. Hubungan ini dibangun melalui tahapan orientasi, kerja, dan terminasi yang saling berkaitan serta didukung oleh komunikasi terapeutik sebagai sarana utama interaksi. Selain itu, kontrak terapeutik memberikan struktur yang jelas dalam hubungan, sedangkan batas profesional menjadi landasan etis untuk menjaga interaksi tetap berada dalam koridor yang aman dan sesuai standar profesi. Integrasi dari seluruh konsep tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan asuhan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan klinis, tetapi juga oleh kemampuan perawat dalam membangun hubungan interpersonal yang terapeutik.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai tahapan hubungan perawat–klien, komunikasi terapeutik, kontrak terapeutik, dan batas profesional sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Penerapan konsep-konsep tersebut dalam praktik klinis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, serta partisipasi aktif klien dalam proses perawatan. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam menjaga profesionalisme perawat serta mendukung tercapainya hasil kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, teori-teori yang telah dibahas pada bab ini menjadi dasar penting dalam pengembangan praktik keperawatan yang berkualitas, aman, dan beretika.

Referensi

- American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements. ANA.
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses (8th ed.). Elsevier.
- Forchuk, C., Westwell, J., Martin, M. L., Bamber-Azzopardi, W., Kosterewa-Tolman, D., & Hux, M. (2000). The developing nurse–client relationship: Nurses’ perspectives. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 6(1), 3–10.
- Kourkouta, L., & Papathanasiou, I. V. (2014). Communication in nursing practice. *Materia Socio-Medica*, 26(1), 65–67. <https://doi.org/10.5455/msm.2014.26.65-67>
- O’Hagan, M., Manias, E., Elder, C., Pill, J., Woodward-Kron, R., McNamara, T., Webb, G., & McColl, G. (2014). What counts as effective communication in nursing? Evidence from nurse educators’ and clinicians’ feedback on nurse interactions with simulated patients. *Journal of Advanced Nursing*, 70(6), 1344–1355. <https://doi.org/10.1111/jan.12296>
- Peplau, H. E. (1997). Peplau’s theory of interpersonal relations. *Nursing Science Quarterly*, 10(4), 162–167.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2016). Kode etik perawat Indonesia. PPNI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier.
- Rørtveit, K., Hansen, B. S., Leiknes, I., Joa, I., Testad, I., & Severinsson, E. (2015). Patients’ experiences of trust in the patient–nurse relationship—A systematic review of qualitative studies. *Open Journal of Nursing*, 5(3), 195–209
- Stuart, G. W. (2013). Principles and practice of psychiatric nursing (10th ed.). Elsevier.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2018). Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice (9th ed.). F.A. Davis.
- Videbeck, S. L. (2020). Psychiatric-mental health nursing (8th ed.). Wolters Kluwer.

BAB III

TEKNIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK INTI: (MENDENGAR AKTIF, KLARIFIKASI, REFLEKSI, FOKUS, VALIDASI, DAN PERTANYAAN TERBUKA)

A. Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan inti dari proses hubungan interpersonal dalam praktik klinis yang berperan langsung terhadap terjadinya perubahan psikologis pada individu. Rogers menekankan bahwa perubahan kepribadian tidak terutama ditentukan oleh teknik atau intervensi spesifik, melainkan oleh kualitas hubungan yang dibangun antara terapis dan klien. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi sebagai medium relasional yang memungkinkan terbentuknya kepercayaan, keterbukaan, dan eksplorasi diri secara mendalam. Kegagalan komunikasi, sebaliknya, berpotensi menghambat proses terapeutik karena mengganggu pemahaman dan keterhubungan emosional antara kedua pihak (Rogers & Rogers, 1957).

Teknik komunikasi terapeutik merupakan komponen fundamental dalam praktik keperawatan yang secara langsung memengaruhi kualitas interaksi klinis, keselamatan pasien, serta *outcome* pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan modern yang berorientasi pada *patient-centered care*, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai intervensi klinis yang memiliki dampak terukur terhadap kepuasan, kepatuhan, dan keselamatan pasien (Street et al., 2009).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama *medical error* di fasilitas kesehatan. Laporan dari *Joint Commission* mengidentifikasi bahwa lebih dari 60% kejadian sentinel berkaitan dengan kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan maupun antara tenaga kesehatan dan pasien (AMA, 2022).

Namun demikian, dalam praktik klinis, teknik komunikasi terapeutik sering digunakan secara intuitif tanpa landasan *evidence* yang kuat. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas komunikasi serta meningkatkan risiko misinterpretasi informasi klinis. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk mengkaji teknik komunikasi terapeutik inti secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah.

B. Kerangka Konseptual Teknik Komunikasi Terapeutik

Hubungan terapeutik yang efektif ditandai oleh tiga kondisi utama, yaitu *congruence* (keaslian terapis), penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan empati. Ketiga kondisi ini berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan psikologis yang aman bagi klien untuk mengekspresikan pengalaman internalnya tanpa rasa takut akan penilaian. Rogers menjelaskan bahwa empati memungkinkan terapis memahami dunia subjektif klien secara mendalam, sementara penerimaan tanpa syarat memberikan ruang bagi klien untuk menerima dirinya sendiri. Kongruensi memastikan bahwa interaksi yang terjadi bersifat autentik dan tidak defensif. Ketika kondisi ini dikomunikasikan secara efektif dan dirasakan oleh klien, hubungan terapeutik menjadi sarana utama perubahan (Rogers & Rogers, 1957).

Proses perubahan kepribadian dalam kerangka ini dimulai dari kondisi awal klien yang mengalami *incongruence*, yaitu ketidaksesuaian antara pengalaman aktual dengan konsep diri. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kecemasan dan ketegangan psikologis. Melalui hubungan terapeutik yang empatik dan suportif, klien secara bertahap mampu mengeksplorasi pengalaman yang sebelumnya terdistorsi atau ditolak. Proses ini memungkinkan integrasi antara pengalaman dan *self-concept*, sehingga mengurangi konflik internal. Dengan kata lain, komunikasi terapeutik yang efektif memfasilitasi restrukturisasi makna pengalaman individu, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan fungsi psikologis.

Rogers menegaskan bahwa keberlangsungan enam kondisi inti, termasuk kontak psikologis, kondisi vulnerabilitas klien, serta komunikasi empati dan penerimaan, bersifat tidak hanya diperlukan tetapi juga cukup untuk menghasilkan perubahan kepribadian yang konstruktif. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa kualitas hubungan dan komunikasi memiliki peran yang lebih fundamental dibandingkan teknik terapi tertentu. Dengan demikian, penguatan keterampilan komunikasi terapeutik menjadi krusial dalam praktik keperawatan maupun profesi kesehatan lainnya, karena secara langsung berkontribusi terhadap proses penyembuhan psikologis dan adaptasi individu.

Teknik komunikasi terapeutik inti dapat dipahami sebagai keterampilan mikro (*micro-skills*) yang digunakan perawat dalam membangun, mempertahankan, dan mengarahkan interaksi terapeutik dengan pasien. Teknik ini berakar pada teori hubungan interpersonal Peplau yang menekankan bahwa interaksi perawat-pasien merupakan sarana utama dalam proses penyembuhan (Peplau, 1994).

Secara konseptual, teknik komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama:

a. Teknik eksploratif (misalnya pertanyaan terbuka)

- b. Teknik klarifikatif (misalnya klarifikasi dan fokus)
- c. Teknik validatif (misalnya refleksi dan validasi)

Pendekatan ini juga dipengaruhi oleh teori humanistik Carl Rogers yang menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dalam komunikasi (Rogers & Rogers, 1957).

C. Mendengar Aktif (Active Listening)

1. Definisi operasional

Mendengar aktif (*active listening*) didefinisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan perhatian penuh, pemahaman mendalam, serta respons yang disengaja terhadap pesan yang disampaikan oleh individu lain baik pada aspek verbal maupun nonverbal. Berbeda dengan mendengar pasif, mendengar aktif menuntut keterlibatan kognitif dan emosional dari pendengar untuk menangkap makna yang lebih luas dari sekadar kata-kata. Rogers dan Farson menekankan bahwa mendengar aktif merupakan proses di mana pendengar membantu pembicara memperjelas pemikirannya sendiri melalui respons yang reflektif dan tidak menghakimi (Rogers & Farson, 2015).

Mendengar aktif juga mencakup keterlibatan empatik yang mendalam, di mana pendengar tidak hanya memahami isi pesan tetapi juga mampu menangkap kebutuhan emosional pembicara serta merespons secara tepat melalui komunikasi verbal dan nonverbal (Brown, Yu, & Etherington, 2020). Dalam konteks klinis, proses ini bahkan dipahami sebagai bentuk keterhubungan interpersonal (*connectedness*) yang memungkinkan interaksi menjadi lebih bermakna dan berorientasi pada pengalaman pasien. Dengan demikian, mendengar aktif tidak hanya berfungsi untuk memahami pesan, tetapi juga sebagai sarana fasilitasi eksplorasi diri dan pembentukan makna dalam interaksi terapeutik.

2. Komponen utama

Mendengar aktif terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi. Pertama, *attending behavior*, yaitu kehadiran penuh yang ditunjukkan melalui kontak mata, orientasi tubuh, dan ekspresi yang menunjukkan perhatian. Kedua, kesadaran terhadap isyarat nonverbal, yang memungkinkan pendengar menangkap emosi dan konteks yang tidak diungkapkan secara verbal. Ketiga, respons minimal (*minimal encouragers*) seperti anggukan atau kata singkat untuk mempertahankan alur komunikasi. Keempat, parafrase dan klarifikasi, yang berfungsi memastikan bahwa pesan dipahami secara akurat (Mălureanu & Enachi-vasluianu, 2016). Selain itu, studi juga menekankan pentingnya aspek operasional seperti menghilangkan distraksi, menjaga interaksi tetap aktif, serta

mengajukan pertanyaan eksploratif sebagai bagian dari proses mendengar aktif (Astuti, Novianti, Santos, Pinto, & Azhar, 2025).

Penguatan dari studi empiris menunjukkan bahwa komponen mendengar aktif dapat dipetakan dalam tiga proses utama, yaitu sensing (menangkap pesan dan emosi), processing (memahami dan menginterpretasikan informasi), serta responding (memberikan respons yang sesuai) (Brown et al., 2020). Selain itu, respons sederhana seperti "hm", "ya", atau anggukan dikategorikan sebagai *active listening responses* yang berfungsi sebagai sinyal perhatian dan keterlibatan dalam percakapan (Simon, 2018). Komponen tambahan ini menegaskan bahwa mendengar aktif merupakan keterampilan multidimensional yang melibatkan aspek perilaku, kognitif, dan afektif secara simultan.

3. Evidence klinis

Secara empiris, mendengar aktif terbukti berkontribusi signifikan terhadap kualitas hubungan terapeutik dan *outcome* klinis. Pendekatan ini memungkinkan pasien merasa didengar dan dipahami, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap intervensi. Rogers menjelaskan bahwa ketika individu mengalami pemahaman empatik melalui proses mendengarkan yang mendalam, mereka cenderung lebih mampu mengakses dan mengintegrasikan pengalaman internalnya (Rogers & Farson, 2015).

Temuan penelitian terbaru memperkuat bahwa mendengar aktif berhubungan dengan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, termasuk aspek tanggung jawab, empati, dan kualitas hubungan interpersonal (Brown et al., 2020). Selain itu, mendengar aktif memiliki hubungan langsung dengan peningkatan empati, yang berperan sebagai mediator dalam tercapainya *patient-centered care* dan *outcome* klinis yang lebih baik (Haley et al., 2017). Dalam konteks pelayanan kronis, praktik deep listening juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam memberikan dukungan emosional, membangun kepercayaan, serta meningkatkan pengalaman pasien selama proses perawatan (Bradshaw, Siddiqui, Green, & Sharma, 2022). Hal ini berdampak pada penurunan konflik internal dan peningkatan fungsi psikologis, sekaligus meningkatkan akurasi pengkajian klinis karena data subjektif yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan valid.

4. Risiko jika tidak diterapkan

Ketiadaan mendengar aktif dalam komunikasi klinis dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Secara langsung, hal ini meningkatkan risiko

miskomunikasi dan kesalahan interpretasi informasi, yang dapat berujung pada kesalahan klinis. Selain itu, pasien yang tidak merasa didengar cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah, resistensi terhadap intervensi, serta keterbatasan dalam mengungkapkan informasi penting. Dari perspektif relasional, kurangnya keterampilan mendengar aktif dapat menghambat terbentuknya hubungan terapeutik yang efektif. Rogers juga menggarisbawahi bahwa kegagalan dalam mendengarkan secara empatik dapat menghalangi proses eksplorasi diri pasien, sehingga perubahan psikologis yang diharapkan tidak terjadi secara optimal (Rogers & Farson, 2015).

Tambahan *evidence* menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan mendengar aktif juga berdampak pada rendahnya kualitas dukungan emosional yang diberikan kepada pasien, sehingga pengalaman perawatan menjadi kurang optimal dan hubungan terapeutik tidak terbentuk secara kuat (Bradshaw et al., 2022). Selain itu, keterbatasan dalam keterampilan mendengar juga dikaitkan dengan rendahnya perkembangan profesionalisme tenaga kesehatan, mengingat komunikasi interpersonal merupakan komponen inti dalam praktik profesional (Brown et al., 2020). Oleh karena itu, mendengar aktif bukan hanya keterampilan komunikasi tambahan, melainkan elemen esensial dalam praktik klinis yang berorientasi pada keselamatan dan kualitas pelayanan.

5. Contoh-contoh kalimat yang tepat saat mendengar aktif

Tujuan: menunjukkan kehadiran dan perhatian penuh, membangun kepercayaan, serta memfasilitasi pasien mengekspresikan pengalaman dan perasaannya

Fokus: isi pesan dan emosi pasien (content & feeling)

Bentuk: respons verbal minimal dan pernyataan suportif (bukan pertanyaan dominan)

Arah komunikasi: dari pasien → perawat (perawat menerima dan memfasilitasi ekspresi pasien)

Berikut contoh kalimat yang mencerminkan mendengar aktif (*active listening*) fokus pada kehadiran, empati, dan minimal *encouragers*:

- a. "Saya di sini untuk mendengarkan Anda, silakan ceritakan apa yang sedang Anda rasakan."
- b. "Saya mendengarkan, tidak perlu terburu-buru, silakan lanjutkan."
- c. "Terima kasih sudah berbagi, saya tetap bersama Anda mendengarkan."
- d. "Silakan lanjutkan, saya memperhatikan apa yang Anda sampaikan."
- e. "Saya memahami ini penting bagi Anda, saya siap mendengarkan sepenuhnya."

Kalimat-kalimat ini menekankan *presence*, perhatian, dan dukungan verbal ringan, tanpa mengarah ke klarifikasi atau interpretasi.

D. Klarifikasi (Clarification)

1. Definisi operasional

Klarifikasi merupakan teknik komunikasi terapeutik yang digunakan untuk memastikan bahwa makna pesan yang disampaikan pasien dipahami secara akurat oleh perawat, sekaligus meminimalkan ambiguitas dalam proses interaksi. Dalam perspektif teori komunikasi, pemahaman (*understanding*) merupakan komponen esensial yang menentukan apakah komunikasi benar-benar terjadi, bukan sekadar pertukaran informasi (Baraldi, Corsi, & Esposito, 2021). Dengan demikian, klarifikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi, tetapi sebagai mekanisme untuk mencapai kesamaan makna antara pemberi dan penerima pesan.

Lebih lanjut, komunikasi interpersonal pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya akurat karena makna tidak melekat pada kata, melainkan dibentuk dalam pikiran individu berdasarkan pengalaman dan konteks masing-masing (Chartier, 1981). Oleh karena itu, klarifikasi menjadi kebutuhan fundamental dalam komunikasi terapeutik untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa interpretasi perawat terhadap kondisi pasien sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Dalam konteks klinis, klarifikasi juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara informasi yang diutarakan pasien dan pemahaman profesional tenaga kesehatan.

2. Teknik implementasi

Klarifikasi dilakukan melalui serangkaian teknik yang bertujuan memperjelas makna pesan tanpa mengubah isi atau menimbulkan distorsi. Teknik utama meliputi permintaan penjelasan ulang, penggunaan pertanyaan terbuka yang netral, serta konfirmasi pemahaman melalui parafrase. Dalam kerangka proses komunikasi, teknik ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses *decoding* dan *feedback* dalam model komunikasi, di mana penerima pesan aktif memverifikasi interpretasinya terhadap pesan yang diterima (Taylor, 1962).

Selain itu, klarifikasi juga melibatkan kesadaran terhadap konteks komunikasi, termasuk latar belakang sosial, budaya, serta kondisi emosional pasien. Komunikasi bukan sekadar transmisi informasi, tetapi merupakan proses interaksi simbolik yang melibatkan interpretasi bersama antara individu (Fuchs, 2020). Oleh karena itu, klarifikasi tidak hanya berfokus pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan makna implisit, emosi, dan tujuan komunikasi.

Dalam praktik interpersonal, klarifikasi juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyesuaikan respons secara dinamis dalam interaksi dua arah. Komunikasi bersifat transaksional dan melibatkan pertukaran informasi serta pengaruh secara simultan antara kedua pihak (Reynolds & Darden, 1971). Hal ini menegaskan bahwa klarifikasi bukan tindakan satu arah, melainkan bagian dari proses interaktif yang terus berkembang selama komunikasi berlangsung.

3. Evidence klinis

Secara klinis, klarifikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan akurasi komunikasi dan kualitas pengambilan keputusan. Ketidakjelasan pesan merupakan salah satu penyebab utama miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan, yang dapat berujung pada kesalahan diagnosis maupun intervensi. Oleh karena itu, klarifikasi berfungsi sebagai strategi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kejelasan informasi dalam interaksi klinis (Chartier, 1981).

Selain itu, dalam konteks komunikasi terapeutik, pertukaran informasi yang akurat dan pemahaman yang tepat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pasien, merencanakan asuhan, serta membangun hubungan terapeutik yang efektif (Pavlova, 2024). Komunikasi yang jelas memungkinkan tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara holistik, baik dari aspek fisik maupun psikososial.

Dari perspektif hubungan interpersonal, kejelasan komunikasi juga berkontribusi terhadap stabilitas hubungan dan kepercayaan antara individu. Komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial dan identitas individu dalam interaksi (Schein, 1960). Dengan demikian, klarifikasi tidak hanya berdampak pada aspek klinis, tetapi juga pada kualitas hubungan terapeutik yang terbentuk antara perawat dan pasien.

4. Batasan penggunaan

Meskipun klarifikasi merupakan teknik yang esensial, penggunaannya harus mempertimbangkan aspek etika dan kenyamanan pasien. Klarifikasi yang dilakukan secara berlebihan atau dengan cara yang tidak tepat dapat menimbulkan kesan interogatif, mengganggu alur komunikasi, serta menurunkan kepercayaan pasien. Oleh karena itu, klarifikasi harus dilakukan secara empatik, menggunakan bahasa yang sederhana, serta disesuaikan dengan kondisi emosional dan kognitif pasien.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa komunikasi selalu memiliki keterbatasan dalam mencapai keakuratan penuh. Ketidakpastian tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat dikurangi hingga tingkat yang cukup

untuk memungkinkan pemahaman yang memadai (Chartier, 1981). Oleh karena itu, klarifikasi harus diposisikan sebagai proses berkelanjutan, bukan tindakan sekali selesai.

Dalam konteks yang lebih luas, klarifikasi juga perlu mempertimbangkan dinamika hubungan interpersonal. Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan sikap, nilai, dan hubungan antara individu. Jika tidak dilakukan dengan tepat, klarifikasi dapat mengganggu keseimbangan hubungan dan menghambat interaksi terapeutik (Schein, 1960). Oleh karena itu, keterampilan dalam menggunakan klarifikasi secara tepat menjadi bagian penting dari kompetensi komunikasi profesional dalam keperawatan.

5. Contoh-contoh kalimat yang tepat saat klarifikasi (*clarification*)

Tujuan: memastikan akurasi informasi

Fokus: isi pesan (*content*)

Bentuk: bertanya / meminta penjelasan

Arah komunikasi: dari perawat → pasien (minta data lebih jelas)

Berikut contoh kalimat klarifikasi (*clarification*) yang sesuai dengan fungsi memastikan makna dan menghindari asumsi:

- a. "Maaf, bisa Anda jelaskan lebih lanjut apa yang Anda maksud dengan 'tidak nyaman' itu?"
- b. "Ketika Anda mengatakan pusing, apakah yang Anda rasakan lebih seperti berputar atau terasa ringan?"
- c. "Saya ingin memastikan saya memahami dengan benar, maksud Anda nyeri muncul sejak tadi pagi, ya?"
- d. "Bisa Anda ceritakan lebih detail bagian mana yang paling terasa sakit?"
- e. "Apakah yang Anda maksud sulit tidur itu karena sering terbangun atau sulit untuk mulai tidur?"

Kalimat-kalimat ini menekankan verifikasi makna, spesifikasi informasi, dan menghindari interpretasi sepihak.

E. Refleksi (*Reflection*)

1. Jenis refleksi

Refleksi dalam komunikasi terapeutik merujuk pada teknik komunikasi di mana perawat mengembalikan kembali isi atau perasaan yang disampaikan pasien untuk membantu pasien memahami pengalaman internalnya secara lebih jelas. Dalam praktik keperawatan, refleksi tidak hanya terbatas pada refleksi isi (*content reflection*) dan refleksi perasaan (*feeling reflection*), tetapi juga dapat mencakup refleksi makna (*meaning reflection*) yang membantu pasien memahami signifikansi pengalaman yang dialaminya.

Refleksi isi berfokus pada pengulangan atau parafrase pesan faktual pasien, sedangkan refleksi perasaan berfokus pada identifikasi dan pengungkapan emosi yang mendasari pesan tersebut. Dalam komunikasi terapeutik, refleksi menjadi bagian dari teknik dasar seperti *listening*, *clarifying*, dan *summarizing* yang bertujuan membangun hubungan terapeutik yang efektif (Lee, Park, Shin, & Kim, 2022). Dengan demikian, refleksi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rangkaian keterampilan komunikasi terapeutik yang saling terintegrasi.

Selain itu, dalam konteks praktik profesional, refleksi juga dipahami sebagai proses kognitif dan metakognitif yang terjadi baik secara langsung saat interaksi (*reflection in action*) maupun setelah interaksi (*reflection on action*), yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan (Nursing & Midwifery council, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa refleksi memiliki dimensi ganda: sebagai teknik komunikasi interpersonal dan sebagai proses pembelajaran profesional.

2. Mekanisme psikologis

Secara psikologis, refleksi bekerja melalui mekanisme peningkatan *self-awareness* dan *emotional processing*. Ketika perawat merefleksikan perasaan pasien, pasien didorong untuk mengenali, memberi label, dan memahami emosinya sendiri. Proses ini penting karena individu seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi atau mengekspresikan emosi secara langsung.

Refleksi juga berfungsi sebagai validasi pengalaman emosional pasien, yang berkontribusi pada terbentuknya rasa diterima dan dipahami. Dalam hubungan terapeutik, kemampuan perawat untuk menunjukkan empati dan memahami perspektif pasien merupakan komponen kunci dalam membangun hubungan yang efektif (Bramhall, 2014). Empati yang diekspresikan melalui refleksi memungkinkan pasien merasa aman secara psikologis, sehingga lebih terbuka dalam mengungkapkan pengalaman dan perasaannya.

Lebih lanjut, refleksi berperan dalam proses regulasi emosi. Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi secara verbal, intensitas emosi negatif dapat berkurang, sehingga pasien mampu berpikir lebih jernih dan adaptif. Dalam konteks pembelajaran profesional, refleksi juga mendorong perawat untuk mengevaluasi pengalaman klinis, memahami respons emosional mereka sendiri, dan meningkatkan kompetensi komunikasi secara berkelanjutan (Nursing & Midwifery council, 2024).

3. Evidence klinis

Secara empiris, refleksi terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan komunikasi dan kualitas asuhan keperawatan. Studi

intervensi menunjukkan bahwa praktik refleksi secara sistematis, seperti *reflective writing* selama beberapa minggu, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal perawat secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol (Pangh, Jouybari, Vakili, Sanagoo, & Torik, 2019).

Selain itu, refleksi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hubungan perawat–pasien. Komunikasi yang reflektif memungkinkan perawat memahami kebutuhan emosional pasien secara lebih mendalam, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat dan berpusat pada pasien. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa komunikasi terapeutik yang efektif berhubungan dengan peningkatan kepuasan pasien, pemahaman kondisi kesehatan, serta hasil klinis yang lebih baik (Lee et al., 2022).

Dalam praktik klinis yang kompleks, seperti di ICU atau unit emergensi, refleksi juga membantu tenaga kesehatan mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan kualitas interaksi dengan pasien maupun keluarga. Ketidakjelasan komunikasi sering menjadi sumber miskomunikasi dan ketidakpuasan pasien, sehingga refleksi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kejelasan dan kualitas komunikasi (Emaliyawati, Widiasih, Sutini, & Rahayu, 2020).

4. Batasan Penggunaan

Meskipun refleksi merupakan teknik yang efektif, penggunaannya memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Refleksi yang tidak tepat, seperti interpretasi yang keliru terhadap perasaan pasien, dapat menyebabkan distorsi makna dan menurunkan kepercayaan pasien. Oleh karena itu, refleksi harus didasarkan pada observasi yang akurat dan disampaikan dengan bahasa yang tentatif, bukan asertif.

Selain itu, refleksi yang berlebihan atau terlalu intens dapat membuat pasien merasa tidak nyaman atau tertekan untuk mengungkapkan emosi yang belum siap diungkapkan. Dalam konteks ini, perawat perlu mempertimbangkan kesiapan emosional pasien serta situasi klinis yang dihadapi.

Dari perspektif profesional, refleksi juga memerlukan keterampilan dan latihan yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang memadai, tenaga kesehatan mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan refleksi secara efektif, terutama dalam situasi dengan tekanan tinggi atau keterbatasan waktu. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi komunikasi, termasuk refleksi, perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

5. Contoh-contoh kalimat yang tepat saat Refleksi (Reflection)

Tujuan: membantu pasien **menyadari perasaan/ pengalaman**

Fokus: emosi dan makna (*feeling & meaning*)

Bentuk: pernyataan, bukan pertanyaan

Arah komunikasi: dari perawat → pasien (mengembalikan pengalaman pasien)

Berikut contoh **5 kalimat refleksi:**

- a. "Pengalaman ini tampaknya membuat Anda merasa tidak nyaman."
- b. "Situasi ini terasa sangat berat bagi Anda, dan Anda tampak cemas."
- c. "Anda tampak sangat khawatir dengan kondisi yang sedang Anda hadapi."
- d. "Ini terasa melelahkan bagi Anda menjalani semua ini."
- e. "Anda tampaknya merasa tidak berdaya dalam situasi ini."

F. Fokus (Focusing)

1. Definisi

Fokus (*focusing*) merupakan teknik komunikasi terapeutik yang digunakan untuk mengarahkan percakapan pada isu utama yang relevan dengan kondisi pasien, sehingga interaksi tetap terstruktur dan bermakna secara klinis. Teknik ini berfungsi untuk membantu perawat dan pasien mengidentifikasi prioritas masalah serta mencegah percakapan yang melebar dan tidak terarah. Dalam konteks komunikasi terapeutik, kemampuan memfokuskan pembicaraan merupakan bagian dari kompetensi komunikasi inti yang memungkinkan perawat memahami, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kebutuhan pasien secara efektif (Lee et al., 2022).

Secara konseptual, fokus berkaitan erat dengan tujuan komunikasi dalam hubungan terapeutik, yaitu mencapai pemahaman yang jelas terhadap kondisi pasien dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Tanpa adanya fokus, komunikasi berisiko menjadi tidak efisien dan dapat mengaburkan informasi penting yang dibutuhkan dalam proses asuhan keperawatan.

2. Teknik

Teknik fokus dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi utama, yaitu *narrowing topic* dan *redirecting*. *Narrowing topic* dilakukan dengan mempersempit pembahasan pada aspek tertentu yang dianggap paling relevan, sehingga percakapan menjadi lebih mendalam dan terarah. Sementara itu, *redirecting* digunakan untuk mengembalikan percakapan yang mulai menyimpang agar kembali pada tujuan utama komunikasi.

Dalam praktiknya, teknik ini tidak dilakukan secara kaku, tetapi melalui interaksi yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasien. Perawat perlu menggunakan pertanyaan terbuka, klarifikasi, dan refleksi sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembicaraan secara halus tanpa mengganggu kenyamanan pasien. Komunikasi dalam konteks ini bersifat transaksional, di mana perawat dan

pasien saling memengaruhi dalam proses pertukaran informasi dan makna (Reynolds & Darden, 1971).

Selain itu, kemampuan memfokuskan komunikasi juga dipengaruhi oleh sensitivitas terhadap isyarat verbal dan nonverbal pasien. Perawat harus mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dan mengabaikan distraksi yang tidak berkaitan dengan tujuan klinis. Dengan demikian, fokus bukan hanya teknik komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis dalam memilah informasi yang penting.

Dalam konteks komunikasi terapeutik, teknik fokus juga berkaitan erat dengan prinsip *"start by listening"* dan keterlibatan aktif pasien dalam proses komunikasi. Perawat perlu memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan pengalaman tanpa interupsi, kemudian secara bertahap mengarahkan pembicaraan pada aspek yang paling relevan melalui pertanyaan klarifikasi dan penguatan topik utama. Pendekatan ini memungkinkan proses komunikasi tetap terarah tanpa mengabaikan kebutuhan emosional pasien. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana, sikap *nonjudgmental*, serta lingkungan komunikasi yang aman dan privat merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas teknik fokus dalam praktik klinis (Ernstmeyer & Christman, 2022).

3. Relevansi klinis

Fokus memiliki peran yang sangat penting dalam praktik klinis, terutama pada situasi dengan keterbatasan waktu dan kompleksitas tinggi, seperti di unit gawat darurat (IGD) atau intensive care unit (ICU). Dalam kondisi tersebut, komunikasi yang efektif dan terarah menjadi kunci untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan pasien dan keluarga (Bramhall, 2014).

Selain itu, dalam lingkungan klinis yang kompleks seperti ICU, perawat sering menghadapi tantangan komunikasi akibat kondisi pasien yang kritis, keterlibatan keluarga, serta kebutuhan informasi yang tinggi. Dalam situasi ini, kemampuan untuk memfokuskan komunikasi sangat diperlukan untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak (Emaliyawati et al., 2020).

Lebih lanjut, fokus dalam komunikasi juga berkontribusi terhadap efisiensi kerja tenaga kesehatan. Dengan komunikasi yang terarah, perawat dapat menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas pengkajian dan hubungan terapeutik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa komunikasi yang efektif tidak

hanya meningkatkan *outcome* pasien, tetapi juga mendukung kinerja profesional tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang aman dan berkualitas.

Lebih lanjut, teknik fokus tidak hanya berfungsi untuk efisiensi komunikasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pengkajian secara holistik. Dalam praktik keperawatan kesehatan mental, komunikasi yang terstruktur membantu perawat mengidentifikasi masalah utama, memahami tingkat distress pasien, serta mengevaluasi fungsi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengarahkan percakapan secara tepat, perawat dapat mengintegrasikan data subjektif dan objektif secara lebih sistematis, sehingga mendukung *clinical judgment* dan pengambilan keputusan yang lebih akurat (Ernstmeyer & Christman, 2022).

4. Contoh-contoh kalimat yang tepat saat Fokus (Focusing)

Tujuan: mengarahkan percakapan pada isu utama yang relevan dengan kondisi pasien

Fokus: masalah inti/prioritas (problem & priority)

Bentuk: pernyataan atau pertanyaan terarah

Arah komunikasi: dari perawat → pasien (mengarahkan pembicaraan secara halus)

Berikut contoh kalimat-kalimat memfokuskan:

- a. "Mari kita fokus dulu pada keluhan utama yang paling mengganggu Anda saat ini."
- b. "Dari yang Anda ceritakan, saya ingin kita membahas lebih lanjut tentang nyeri yang Anda rasakan."
- c. "Kita kembali ke bagian yang Anda sebutkan tadi tentang sulit tidur, bisa Anda ceritakan lebih lanjut?"
- d. "Saya ingin mengarahkan pembicaraan kita pada kondisi yang paling Anda khawatirkan saat ini."
- e. "Agar kita bisa membantu dengan tepat, mari kita fokus pada gejala yang paling sering Anda alami."

Kalimat-kalimat di atas menunjukkan pengalihan yang **halus, tidak memotong**, tetap menjaga **hubungan terapeutik** dan mengarahkan tanpa menghakimi.

G. Validasi (Validation)

1. Definisi

Teknik Komunikasi Terapeutik Inti: (Mendengar Aktif, Klarifikasi, Refleksi, Fokus, Validasi, Dan Pertanyaan Terbuka)

Validasi merupakan teknik komunikasi terapeutik yang berfokus pada pengakuan, penerimaan, dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif serta respons emosional pasien tanpa memberikan penilaian. Teknik ini menunjukkan bahwa perawat memahami makna yang dibangun pasien terhadap pengalaman yang dialaminya, baik pada aspek kognitif maupun emosional.

Dalam perspektif komunikasi modern, proses pemahaman (*understanding*) merupakan komponen esensial dalam terjadinya komunikasi itu sendiri, bukan sekadar penyampaian informasi (Baraldi et al., 2021). Oleh karena itu, validasi tidak hanya berfungsi sebagai respons empatik, tetapi juga sebagai bentuk konfirmasi bahwa pesan pasien telah dipahami secara bermakna.

Dalam konteks keperawatan, validasi menjadi bagian integral dari komunikasi terapeutik yang berorientasi pada pasien (*patient-centered care*), di mana pengalaman subjektif pasien digunakan sebagai dasar dalam pengkajian dan perencanaan asuhan. Komunikasi terapeutik sendiri merupakan proses interaksi profesional yang bertujuan membangun hubungan, menggali informasi, serta mendukung pemulihan pasien melalui interaksi emosional dan informasional secara simultan (Lee et al., 2022).

2. Perbedaan konsep

Validasi sering disalahartikan sebagai bentuk persetujuan terhadap keyakinan atau perilaku pasien. Padahal, validasi hanya berfokus pada pengakuan terhadap pengalaman dan emosi pasien, bukan membenarkan tindakan yang mungkin tidak adaptif.

Secara konseptual, komunikasi interpersonal tidak pernah sepenuhnya identik antara pesan yang disampaikan dan yang diterima, karena makna berada pada individu, bukan pada kata-kata itu sendiri (Chartier, 1981). Dalam konteks ini, validasi berfungsi untuk menjembatani kesenjangan makna tersebut dengan memastikan bahwa interpretasi perawat terhadap pengalaman pasien selaras dengan maksud pasien.

Selain itu, dalam hubungan interpersonal, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menyampaikan nilai, sikap, dan penghargaan terhadap individu lain (Schein, 1960). Validasi berada pada dimensi relasional ini, yaitu menunjukkan penerimaan terhadap individu tanpa harus menyetujui isi perilaku atau keyakinannya. Dengan demikian, validasi memungkinkan perawat tetap menjaga empati sekaligus mempertahankan objektivitas klinis dan prinsip keselamatan pasien.

3. Evidence

Konsep validasi memiliki dasar kuat dalam psikologi humanistik, khususnya dalam teori Carl Rogers yang menekankan bahwa hubungan terapeutik yang

efektif memerlukan kondisi seperti empati, penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan keaslian (*genuineness*) sebagai prasyarat terjadinya perubahan kepribadian (Rogers & Rogers, 1957). Validasi merupakan manifestasi praktis dari penerimaan tanpa syarat tersebut dalam komunikasi klinis.

Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik yang mengandung unsur empati, penghargaan, dan validasi terbukti berkontribusi terhadap pembentukan hubungan terapeutik yang positif, peningkatan kepuasan pasien, serta perbaikan *outcome* klinis (Han, Yoo, & Kang, 2024). Studi lain menunjukkan bahwa penggunaan teknik komunikasi seperti refleksi, fokus, dan validasi membantu pasien merasa dipahami, meningkatkan keterbukaan, serta mempermudah proses pengumpulan data klinis yang akurat (Mercan & Mersin, 2025).

Selain itu, komunikasi terapeutik merupakan proses interaktif dua arah yang melibatkan pertukaran informasi dan pengaruh secara timbal balik antara tenaga kesehatan dan pasien (Reynolds & Darden, 1971). Dalam proses ini, validasi berperan sebagai mekanisme untuk memperkuat hubungan emosional, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan rasa aman pasien. Ketika pasien merasa diakui dan dipahami, mereka cenderung lebih kooperatif, lebih terbuka, dan lebih mampu terlibat dalam proses perawatan, yang pada akhirnya mendukung efektivitas intervensi keperawatan secara keseluruhan.

4. Contoh-contoh kalimat yang tepat saat Validasi (Validation)

Tujuan: mengakui dan menerima pengalaman serta emosi pasien untuk meningkatkan rasa dipahami dan aman

Fokus: emosi dan pengalaman subjektif pasien (*feeling & experience*)

Bentuk: pernyataan empatik yang menunjukkan penerimaan, tanpa menghakimi atau menilai

Arah komunikasi: dari perawat pasien (menguatkan dan mengakui pengalaman pasien)

Berikut contoh kalimat-kalimat validasi:

- a. "Perasaan Anda itu bisa dimengerti dalam situasi seperti ini."
- b. "Apa yang Anda rasakan saat ini memang tidak mudah."
- c. "Saya bisa melihat bahwa ini sangat berarti bagi Anda."
- d. "Reaksi Anda terhadap kondisi ini adalah hal yang manusiawi."
- e. "Saya memahami bahwa situasi ini membuat Anda merasa tertekan."

Kalimat-kalimat ini mengandung **penerimaan (*acceptance*)**, tidak menghakimi dan tidak mengarahkan atau mengoreksi pasien.

H. Pertanyaan Terbuka (Open-Ended Questions)

1. Definisi dan karakteristik

Pertanyaan terbuka adalah teknik komunikasi terapeutik yang memungkinkan pasien memberikan jawaban yang luas, naratif, dan eksploratif, tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban tertentu. Teknik ini mendorong pasien untuk mengekspresikan pengalaman, persepsi, dan makna subjektif secara lebih mendalam.

Secara teoritis, komunikasi tidak hanya terdiri dari penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan proses pemahaman (*understanding*) terhadap makna yang dikonstruksi oleh individu (Baraldi et al., 2021). Dalam konteks ini, pertanyaan terbuka berfungsi sebagai stimulus yang memfasilitasi munculnya makna tersebut melalui eksplorasi verbal pasien.

Karakteristik utama pertanyaan terbuka meliputi:

- a. Menggunakan kata tanya seperti *"bagaimana," "apa yang Anda rasakan," "bisakah Anda ceritakan"*
- b. Tidak mengarahkan atau membatasi jawaban.
- c. Memberikan ruang bagi pasien untuk mengembangkan narasi secara bebas.
- d. Berorientasi pada pengalaman subjektif pasien.

Dalam komunikasi terapeutik, teknik ini selaras dengan prinsip bahwa interaksi bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi juga proses simbolik di mana individu membangun dan menegosiasikan makna bersama (Fuchs, 2020).

2. Fungsi dalam pengkajian

Pertanyaan terbuka memiliki peran penting dalam tahap pengkajian keperawatan, terutama dalam memperoleh data yang komprehensif dan bermakna.

- a. Menggali data subjektif

Pertanyaan terbuka memungkinkan pasien mengungkapkan keluhan, pengalaman, dan perasaan secara lebih detail. Hal ini penting karena data subjektif sering kali tidak dapat diperoleh secara optimal melalui pertanyaan tertutup.

- b. Mengidentifikasi persepsi pasien

Teknik ini membantu perawat memahami bagaimana pasien memaknai kondisi kesehatannya, termasuk keyakinan, harapan, dan kekhawatiran yang dimiliki.

Dalam praktik komunikasi terapeutik, kemampuan tenaga kesehatan untuk mendorong pasien berbicara secara bebas merupakan bagian penting dari proses interaksi yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, dan memberikan informasi secara efektif (Pavlova, 2024).

Selain itu, komunikasi interpersonal bersifat dua arah dan melibatkan pertukaran informasi serta pengaruh secara timbal balik (Reynolds & Darden, 1971). Pertanyaan terbuka memperkuat proses ini dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi pasien untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi.

3. Perbandingan dengan pertanyaan tertutup

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membatasi jawaban pasien, biasanya dalam bentuk “ya/tidak” atau pilihan singkat. Sebaliknya, pertanyaan terbuka memberikan ruang eksplorasi yang lebih luas.

Secara konseptual:

- a. Pertanyaan tertutup berfokus pada **konfirmasi informasi**
- b. Pertanyaan terbuka berfokus pada **eksplorasi makna dan pengalaman**

Dalam model komunikasi, pesan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan komunikasi, sikap, dan konteks sosial baik dari sumber maupun penerima (Taylor, 1962). Pertanyaan terbuka memungkinkan variabel-variabel tersebut muncul secara lebih utuh karena pasien tidak dibatasi dalam merespons.

Namun, pertanyaan tertutup tetap memiliki fungsi dalam situasi tertentu, seperti klarifikasi data spesifik. Oleh karena itu, penggunaan kedua jenis pertanyaan harus bersifat komplementer, bukan saling menggantikan.

4. Evidence klinis

Penelitian oleh Heritage & Robinson (2006) menunjukkan bahwa penggunaan pertanyaan terbuka dalam wawancara klinis meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh serta mendukung akurasi diagnosis

Secara lebih luas, literatur komunikasi terapeutik menunjukkan bahwa teknik yang mendorong pasien untuk berbicara secara aktif termasuk pertanyaan terbuka berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien, kualitas hubungan terapeutik, serta efektivitas pengumpulan data klinis (Lee et al., 2022).

Selain itu, dalam konteks hubungan interpersonal, komunikasi berperan dalam membentuk hubungan, persepsi diri, dan interaksi sosial yang stabil (Schein, 1960). Dengan demikian, penggunaan pertanyaan terbuka tidak hanya berdampak pada aspek diagnostik, tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien.

Keseluruhan bukti ini menunjukkan bahwa pertanyaan terbuka merupakan teknik fundamental dalam komunikasi terapeutik yang mendukung pendekatan *patient-centered care*, meningkatkan kualitas pengkajian, dan memperkuat keterlibatan pasien dalam proses perawatan.

5. Contoh-contoh kalimat yang tepat saat pertanyaan terbuka

Tujuan: menggali informasi secara mendalam dan mendorong pasien mengekspresikan pengalaman serta persepsinya

Fokus: pengalaman, persepsi, dan makna subjektif pasien (experience, perception & meaning)

Bentuk: pertanyaan terbuka (diawali "apa", "bagaimana", "bisakah Anda ceritakan...")

Arah komunikasi: dari perawat → pasien (mendorong pasien berbicara dan mengeksplorasi)

Berikut contoh kalimat-kalimat pertanyaan terbuka:

- a. "Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda rasakan sejak keluhan ini muncul?"
- b. "Bagaimana kondisi ini memengaruhi aktivitas Anda sehari-hari?"
- c. "Apa yang paling Anda khawatirkan tentang kondisi ini?"
- d. "Bagaimana Anda biasanya mengatasi situasi seperti ini?"
- e. "Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut pengalaman yang Anda alami?"

Kalimat-kalimat ini:

- a. mendorong **jawaban luas dan naratif**
- b. tidak membatasi pasien
- c. membantu eksplorasi data subjektif secara mendalam

I. Integrasi Teknik dalam Praktik Klinis

Dalam praktik klinis, teknik komunikasi terapeutik tidak digunakan secara terpisah, melainkan terintegrasi secara dinamis dalam satu proses interaksi. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan pertukaran informasi, pemaknaan, serta pemahaman antara pemberi dan penerima pesan (Baraldi et al., 2021). Oleh karena itu, efektivitas komunikasi klinis sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam mengombinasikan berbagai teknik secara kontekstual.

Kombinasi teknik seperti mendengar aktif, refleksi, dan pertanyaan terbuka memungkinkan perawat tidak hanya memperoleh data subjektif yang lebih komprehensif, tetapi juga membangun hubungan terapeutik yang bermakna. Mendengar aktif berperan dalam menunjukkan perhatian penuh dan memfasilitasi ekspresi pasien, refleksi membantu klarifikasi dan validasi pengalaman pasien, sedangkan pertanyaan terbuka memperluas eksplorasi makna.

Dalam interaksi interpersonal, komunikasi bersifat dua arah dan saling memengaruhi antara individu yang terlibat (Reynolds & Darden, 1971). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi terapeutik tidak hanya ditentukan oleh teknik yang digunakan, tetapi juga oleh respons adaptif perawat terhadap pasien selama interaksi berlangsung.

Selain itu, komunikasi terapeutik merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek emosional dan informasional dalam pelayanan kesehatan (Lee et

al., 2022). Integrasi teknik komunikasi memungkinkan kedua aspek ini berjalan secara simultan, sehingga kebutuhan pasien dapat diidentifikasi secara lebih holistik.

1. Adaptasi teknik sesuai setting pelayanan

Penggunaan teknik komunikasi harus disesuaikan dengan konteks klinis, seperti:

- a. Rawat inap: membutuhkan komunikasi berkelanjutan dan relasional
- b. Layanan komunitas: menekankan pendekatan budaya dan sosial
- c. Kegawatdaruratan: menuntut komunikasi singkat, jelas, dan fokus

Perbedaan setting ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan proses statis, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, situasional, dan tujuan interaksi (Fuchs, 2020).

J. Tantangan dan Kesalahan Umum

Dalam praktik, penerapan teknik komunikasi terapeutik sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat menurunkan efektivitas interaksi klinis.

Beberapa tantangan yang umum ditemukan meliputi:

1. Penggunaan teknik secara mekanis.

Teknik komunikasi yang digunakan tanpa pemahaman konteks dapat menyebabkan interaksi menjadi kaku dan tidak autentik. Komunikasi seharusnya merupakan proses adaptif, bukan sekadar penerapan prosedural.

2. Bias interpretasi perawat.

Kesalahan asumsi dalam memahami pesan pasien dapat menyebabkan distorsi makna. Komunikasi tidak menjamin kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, karena makna tidak melekat secara otomatis pada kata-kata yang digunakan (Chartier, 1981).

3. Hambatan budaya dan Bahasa.

Perbedaan nilai, bahasa, dan latar belakang sosial dapat memengaruhi proses decoding pesan, sehingga meningkatkan risiko miskomunikasi.

4. Beban kerja tinggi.

Tekanan kerja dan keterbatasan waktu dapat mengurangi kualitas komunikasi, termasuk kemampuan untuk melakukan mendengar aktif dan refleksi secara optimal.

Literatur menunjukkan bahwa hambatan komunikasi terapeutik dapat berasal dari faktor individu, lingkungan, maupun sistem pelayanan kesehatan, termasuk kurangnya keterampilan, stres kerja, dan faktor sosiodemografis (Abraham et al., 2024).

Kesalahan-kesalahan ini dapat berdampak langsung pada kualitas hubungan terapeutik dan meningkatkan risiko kesalahan klinis, terutama dalam tahap pengkajian dan interpretasi data pasien.

K. Implikasi terhadap Keselamatan Pasien

Komunikasi yang efektif merupakan komponen kunci dalam keselamatan pasien, terutama dalam proses pengkajian, pengambilan keputusan klinis, dan koordinasi pelayanan.

Komunikasi dalam praktik kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh dan menentukan intervensi yang tepat (Pavlova, 2024). Ketika komunikasi tidak efektif, terjadi peningkatan risiko kesalahan seperti misinterpretasi data, kesalahan diagnosis, dan tindakan yang tidak sesuai.

WHO (2017) menegaskan bahwa komunikasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama dalam insiden keselamatan pasien.

Teknik komunikasi terapeutik berkontribusi terhadap keselamatan pasien melalui:

1. Meningkatkan akurasi data

Mendengar aktif dan pertanyaan terbuka memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih lengkap dan valid.

2. Mengurangi miskomunikasi

Klarifikasi dan refleksi membantu memastikan kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan yang dipahami.

3. Mendukung clinical reasoning

Komunikasi yang efektif menyediakan dasar informasi yang kuat untuk proses berpikir klinis dan pengambilan keputusan.

Selain itu, kemampuan komunikasi dan mendengar aktif terbukti berhubungan dengan profesionalisme tenaga kesehatan, termasuk kemampuan klinis, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan (Brown et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya keterampilan interpersonal, tetapi juga kompetensi inti yang berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

L. Penutup

Teknik komunikasi terapeutik inti merupakan keterampilan esensial yang mendukung praktik keperawatan berbasis evidence. Penerapan teknik secara tepat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan, hubungan terapeutik, serta keselamatan pasien.

Referensi

- Abraham, S. A., Nsatimba, F., Agyare, D. F., Agyeiwaa, J., Danso, R. O., Ninnoni, J. P., ... Commey, I. T. (2024). Barriers and outcomes of therapeutic communication between nurses and patients in Africa: a scoping review. *BMC Nursing*, 1–11. <http://doi.org/10.1186/s12912-024-02038-0>
- AMA. (2022). Specifications Manual for Joint Commission National Quality Measures. In American Medical Association (pp. 1–1398).
- Astuti, A. M., Novianti, N. P., Santos, N. M. dos, Pinto, O. M., & Azhar, B. (2025). Effectiveness of Nurse Therapeutic Communication in Enhancing Patient Cooperation During Treatment. *Proceeding of International Conference on Science, Health, And Technology*, 44–50. <http://doi.org/10.47701/fxv4tn51>
- Baraldi, C., Corsi, G., & Esposito, E. (2021). Communication. In *Unlocking Luhmann*. transcript Verlag, Bielefeld University Press.
- Bradshaw, J., Siddiqui, N., Green, D., & Sharma, A. (2022). Kindness, Listening, and Connection: Patient and Clinician Key Requirements for Emotional Support in Chronic and Complex Care. *Journal of Patient Experience*, 9, 1–7. <http://doi.org/10.1177/23743735221092627>
- Bramhall, E. (2014). Effective communication skills in nursing practice. *Nursing Standard* (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987), 29(14), 53–59. <http://doi.org/10.7748/ns.29.14.53.e9355>
- Brown, T., Yu, M., & Etherington, J. (2020). Are Listening and Interpersonal Communication Skills Predictive of Professionalism in Undergraduate Occupational Therapy Students? *Health Professions Education*, 6, 187–200.
- Chartier, M. R. (1981). Clarity of Expression in Interpersonal Communication Clarity in Interpersonal of Expression Communication. *The Journal of Nursing Administration*, 11(7), 42–46.
- Emaliyawati, E., Widiasih, R., Sutini, T., & Rahayu, U. (2020). Nurses' Reflections on Challenges and Barriers of Communication in The Intensive Care Unit: A Phenomenology Study. In *Jurnal Keperawatan Padjadjaran* (Vol. 8, pp. 65–73). <http://doi.org/DOI: 10.24198/jkp>
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2022). Chapter 2 Therapeutic Communication and the Nurse-Client Relationship. In *Nursing: Mental Health and Community Concepts*. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK617004/>
- Fuchs, C. (2020). Communication and Society. In *Communication and Capitalism*. <http://doi.org/https://doi.org/10.16997/book45>

- Haley, B., Heo, S., Wright, P., Barone, C., Rettiganti, M. R., & Anders, M. (2017). Relationships Among Active Listening, Self- Awareness, Empathy, and Patient-Centered Care in Associate and Baccalaureate Degree Nursing Students. *NursingPlus Open*. <http://doi.org/10.1016/j.npls.2017.05.001>
- Han, S., Yoo, J., & Kang, K. (2024). Development and Validation of the Therapeutic Communication Scale in Nursing Students. *Healthcare*, 12, 394. <http://doi.org/doi.org/10.3390https://doi.org/10.3390/healthcare12030394>
- Lee, H., Park, B., Shin, M., & Kim, D. (2022). Therapeutic Communication Experiences of Nurses Caring for Patients with Hematology. In *Healthcare* (Vol. 10, pp. 1–15). <http://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare10122403>
- Mălureanu, F., & Enachi-vasluianu, L. (2016). THE IMPORTANCE OF ELEMENTS OF ACTIVE LISTENING IN DIDACTIC COMMUNICATION: A STU DENT’ S PERSPECTIVE. In *CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION* (pp. 332–335). <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.776>
- Mercan, N., & Mersin, S. (2025). Evaluating the therapeutic communication skills of nursing students in the clinical setting: The experiences of students, patients and patients relatives. *Heliyon*, 11(January). <http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41677>
- Nursing &Midwifery council. (2024). Supporting information for reflection in nursing and midwifery practice. Nursing &Midwifery Council.
- Pangh, B., Jouybari, L., Vakili, M. A., Sanagoo, A., & Torik, A. (2019). The Effect of Reflection on Nurse-Patient Communication Skills in Emergency Medical Centers. In *Journal of Caring Sciences* (Vol. 8, pp. 75–81). <http://doi.org/10.15171/jcs.2019.011>
- Pavlova, S. (2024). Therapeutic Communication in Clinical Practice. *Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers)*, 30(2), 5509–5512. <http://doi.org/10.5272/jimab.2024302.5509>
- Peplau, H. E. (1994). *Interpersonal Theory in Nursing*. (M. Anita Werner O’Toole, R.N., C.5., Ph.D. Sheila Rouslin Welt, R.N., Ed.) Springer Publi shing Company.
- Reynolds, F. D., & Darden, W. R. (1971). Mutually Adaptive Effects of Interpersonal Communication. *Journal of Marketing Research*, 8(4), 449–454.
- Rogers, C. R., & Farson, R. E. (2015). *Active Listening*. Martino Publishing.
- Rogers, C. R., & Rogers, C. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2).

- Schein, E. H. (1960). Interpersonal Communication, Group Solidarity, and Social. Sociometry, 23(2), 148–161.
- Simon, C. (2018). The functions of active listening responses. Behavioural Processes, 157(August), 47–53. <http://doi.org/10.1016/j.beproc.2018.08.013>
- Taylor, H. R. (1962). A Model for the Communication Process. Society for Technical Communication (Vol. 9).
- WHO. (2017). Communicating risk in public health emergencies: a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice. Geneva.

BAB IV

KOMUNIKASI PADA SITUASI KLINIS KHUSUS (NYERI, CEMAS, MARAH, BERDUKA, PENOLAKAN TINDAKAN, DAN PASIEN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS)

A. Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan komponen fundamental dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk membina hubungan saling percaya, mengurangi kecemasan, dan memfasilitasi kesembuhan pasien, dalam praktik klinis, perawat tidak hanya berhadapan dengan pasien dalam kondisi stabil, tetapi sering kali menghadapi situasi klinis khusus yang kompleks dan menantang. Keberhasilan perawatan kesehatan bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara empatik dan responsif terhadap kondisi pasien. Perawat dan tenaga kesehatan harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi berdasarkan situasi klinis mulai dari pasien yang mengalami nyeri, cemas atau marah, hingga keluarga yang berduka atau pasien yang menolak tindakan. Laporan ini merangkum bukti-bukti dari jurnal ilmiah dan penelitian yang menjelaskan strategi komunikasi efektif untuk enam situasi khusus: (1) pasien nyeri, (2) pasien cemas atau takut, (3) pasien marah, (4) keluarga berduka, (5) penolakan tindakan, dan (6) pasien dengan kebutuhan khusus (gangguan pendengaran). Selain itu, disertakan teknik komunikasi terapeutik umum yang mendukung semua situasi.

B. Komunikasi terapeutik

1. Definisi

komunikasi terapeutik tidak hanya mencakup pertukaran informasi, tetapi juga mencakup kemampuan mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan merespons secara tepat terhadap ekspresi emosional pasien.

2. Unsur-unsur

Komunikasi terapeutik melibatkan beberapa elemen penting:

- a. Sender (Pengirim) - pihak yang menginisiasi pesan.
- b. Message (Pesan) informasi atau perasaan yang ingin disampaikan.

- c. Channel (Saluran) verbal, tulisan). media komunikasi (verbal, non-verbal, tulisan).
- d. Receiver (Penerima) menafsirkan pesan. pihak yang menerima dan respon penerima terhadap e. Feedback (Umpan balik) pesan, yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar.

3. Prinsip-prinsip

Beberapa prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik meliputi:

- 1. Empati: Mampu memahami perasaan dan perspektif pasien tanpa menghakimi.
- 2. Respek: Menghargai integritas, hak, dan martabat pasien.
- 3. Kejujuran: Memberikan informasi yang benar dan sesuai kapasitas pemahaman pasien.

4. Manfaat komunikasi terapeutik bagi pasien

Manfaat komunikasi terapeutik tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga berpengaruh terhadap hasil klinis. Beberapa manfaat nyata bagi pasien meliputi:

- a. Peningkatan kepuasan terhadap pelayanan keperawatan
- b. Penurunan kecemasan dan stres selama proses rawat inap
- c. Peningkatan kepatuhan terhadap terapi dan pengobatan
- d. Penguatan kemandirian dalam proses penyembuhan
- e. Penurunan risiko kesalahan medis akibat miskomunikasi

5. Faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik

a. Pengantar

Komunikasi terapeutik merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri perawat dan pasien, maupun dari lingkungan sekitar. Memahami faktor-faktor ini penting agar perawat dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi yang efektif dalam setiap situasi (Hunsaker, S. & Alessandra, 2021).

b. Faktor Internal

1) Usia

Perbedaan usia antara perawat dan pasien memengaruhi cara berbicara, pilihan kata, dan metode komunikasi. Pasien anak-anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan pasien dewasa atau lansia.

2) Jenis Kelamin

Beberapa individu mungkin merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan perawat yang memiliki jenis kelamin sama, terutama dalam konteks perawatan yang bersifat personal atau sensitif.

3) Tingkat Pendidikan dan Literasi Kesehatan

Kemampuan pasien dalam memahami istilah medis, instruksi pengobatan, dan penjelasan prosedur sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan literasi kesehatan.

4) Keadaan Emosi dan Psikologis

Pasien yang sedang cemas, marah, depresi, atau takut cenderung memiliki hambatan dalam menerima atau memproses pesan secara rasional. Perawat perlu peka dan empatik dalam situasi ini.

5) Status Kognitif

Kondisi seperti demensia, delirium, atau gangguan perkembangan dapat menghambat komunikasi. Dalam kasus ini, komunikasi harus disesuaikan dengan kemampuan dan respons pasien.

3. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Fisik

Kebisingan, pencahayaan yang tidak memadai, atau ketidaknyamanan ruangan dapat mengganggu konsentrasi pasien dan efektivitas komunikasi.

b. Waktu

Waktu yang terbatas atau tergesa-gesa saat perawat melakukan tugasnya bisa menurunkan kualitas komunikasi. Komunikasi terapeutik memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan dan hubungan.

c. Budaya dan Bahasa

Perbedaan budaya memengaruhi cara individu mengekspresikan emosi, menunjukkan rasa hormat, atau menanggapi perintah. Bahasa yang tidak dipahami pasien menjadi penghalang besar, sehingga perlu penggunaan juru bahasa profesional bila diperlukan.

d. Kebijakan Institusi

Kebijakan rumah sakit tentang waktu kunjungan, privasi pasien, atau protokol keamanan juga bisa memengaruhi ruang lingkup dan fleksibilitas dalam komunikasi.

4. Faktor Sosial dan Spiritual

Pasien yang memiliki dukungan sosial yang kuat, seperti keluarga atau komunitas keagamaan, cenderung lebih terbuka dalam berkomunikasi dan menunjukkan harapan terhadap proses penyembuhan. Sebaliknya, isolasi sosial dapat memicu perasaan tidak berdaya yang menghambat komunikasi (Chan, et al, 2020).

5. Strategi Menghadapi Hambatan Komunikasi

a. Melakukan assessment komunikasi sebagai bagian dari pengkajian keperawatan.

b. Menerapkan prinsip cultural competence.

- c. Menyediakan lingkungan komunikasi yang nyaman dan privat.
- d. Menghindari jargon medis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- e. Meningkatkan kesiapan emosional perawat melalui pelatihan dan supervisi.

C. Definisi Nyeri, Cemas, Marah, dan Berduka

Memahami konsep dasar dari kondisi emosi dan pengalaman pasien membantu tenaga kesehatan menyesuaikan komunikasi. Berikut beberapa definisi kunci dari literatur ilmiah:

Tabel 4.1 definisi kunci dari literatur ilmiah

Konsep	Definisi
Nyeri	<i>International Association for the Study of Pain</i> mendefinisikan nyeri sebagai "pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan atau menyerupai yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial". Nyeri bersifat personal dan dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan sosial; laporan pasien harus dipercayai dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi tidak meniadakan pengalaman nyeri.
Cemas/Anxiety	<i>Anxiety</i> merupakan keadaan mood yang berorientasi masa depan, terdiri dari respon kognitif, afektif, fisiologis, dan perilaku terhadap ancaman yang dirasakan. Kecemasan patologis muncul ketika persepsi ancaman berlebihan sehingga mengganggu fungsi sehari-hari.
Marah/Anger	ICD-11 menggambarkan marah sebagai keadaan emosional yang muncul dari interpretasi psikologis seseorang bahwa ia terancam. Intensitas marah berkisar dari iritasi ringan hingga kemarahan agresif.
Kehilangan, Duka, dan Berkabung	<i>Loss</i> adalah ketidakhadiran sesuatu atau seseorang; <i>grief</i> (duka) adalah respon emosional terhadap kehilangan – sering mencakup perasaan marah, frustrasi, sedih, atau bersalah; <i>mourning</i> (berkabung) adalah ekspresi lahiriah dari duka yang dibentuk oleh budaya, termasuk ritual dan peringatan.

D. Komunikasi

1. Komunikasi dengan Pasien yang Mengalami Nyeri

a. Strategi Utama

1) Empati dan keterlibatan pasien

Studi perbandingan lintas-seksional di Israel menemukan bahwa perawat menunjukkan tingkat empati dan komunikasi lebih tinggi dibandingkan dokter. Mereka lebih sering mengungkapkan dukungan emosional, mengenali perasaan pasien, menggunakan isyarat nonverbal, mendorong pasien mengungkapkan kekhawatiran, memberi penguatan, serta membangun kepercayaan. Empati meningkatkan kepuasan pasien, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan kepatuhan pengobatan.

2) Transparansi dan keterlibatan keputusan bersama

Perawat juga lebih sering menggunakan komunikasi transparan tentang ketidakpastian hasil pengobatan, sedangkan dokter cenderung menyampaikan penjelasan biomedis. Strategi ini penting pada nyeri kronis; mengakui keterbatasan terapi dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan (shared decision-making) meningkatkan kepercayaan dan harapan realistis.

3) Percaya penilaian pasien dan tidak meremehkan keluhan

Artikel *Journal of Personalized Medicine* menekankan bahwa persepsi nyeri sangat bervariasi antarpasien sehingga dokter harus percaya pada evaluasi nyeri yang disampaikan pasien dan menghindari meminimalkan keluhan. Bahkan jika pemeriksaan tidak menemukan gangguan struktural, pengakuan terhadap nyeri pasien dan pendekatan multidisipliner diperlukan.

4) Komunikasi terbuka tentang nyeri kompleks

Artikel *American Journal of Hospice & Palliative Medicine* menyajikan wawancara dengan 21 perawat yang menggali cara mereka memperoleh informasi tentang nyeri pasien. Perawat menggunakan berbagai metode untuk menggali pengalaman nyeri dan melaporkan tantangan ketika berkomunikasi dengan pasien tentang pengelolaan nyeri dan preferensi obat. Penelitian ini menyoroti perlunya pelatihan tambahan untuk mengatasi dilema komunikasi nyeri.

5) "I Statements" dan dukungan emosional

Artikel pandangan *AMA Journal of Ethics* menekankan bahwa komunikasi yang baik bersifat terapeutik. Penulis merekomendasikan perawat untuk menyatakan kepada pasien bahwa mereka "di sini untuk membantu," mempertahankan ketenangan, menunjukkan empati, menggunakan

ungkapan “saya” (misalnya, “Saya ingin membantu mengurangi rasa sakit Anda”) dibandingkan ungkapan yang menyalahkan, mendorong pasien menulis pertanyaan, serta menyediakan waktu cukup untuk diskusi.

b. Rekomendasi Praktis

- 1) Dengarkan deskripsi nyeri pasien dan validasi pengalaman mereka. Hindari meremehkan rasa sakit meskipun pemeriksaan objektif tidak menemukan kelainan.
- 2) Gunakan pertanyaan terbuka dan ungkapan “saya” untuk menunjukkan empati dan komitmen membantu.
- 3) Jelaskan opsi terapi dengan jujur, akui ketidakpastian, dan libatkan pasien dalam pengambilan keputusan.
- 4) Dorong pasien mengungkapkan kekhawatiran dan rasa takut; gunakan isyarat nonverbal (kontak mata, anggukan) untuk menunjukkan perhatian.

c. Tambahan Bukti dan Strategi

- 1) Komunikasi nyeri pada pasien dengan gangguan pendengaran
Sistematis review dari *BMC Public Health* menyoroti minimnya pedoman khusus untuk menilai nyeri pada individu dengan deafness. Untuk memfasilitasi komunikasi, peneliti merekomendasikan pelibatan anggota keluarga sebagai mediator, pelatihan tenaga kesehatan dalam bahasa isyarat, dan penyesuaian lingkungan (misalnya, melepas masker, pencahayaan baik) sehingga pasien dapat membaca gerak bibir. Strategi ini memastikan inklusivitas dalam pengelolaan nyeri.
- 2) Edukasi preoperatif interaktif
Uji klinis di *Scientific Reports* mengevaluasi layanan platform anestesi (ASP) yang menyediakan informasi praoperasi melalui aplikasi. Intervensi ini mengurangi kecemasan praoperasi dan waktu rawat inap, tetapi meningkatkan nyeri pascaoperasi dan penggunaan analgesik. Hasil ini menyoroti perlunya menyeimbangkan edukasi praoperasi yang menenangkan dengan pengelolaan nyeri pascaoperasi.

2. Komunikasi dengan Pasien Cemas atau Takut

Pasien cemas atau takut sering merasakan ketidakpastian terkait diagnosis atau prosedur. Komunikasi terapeutik yang efektif dapat menurunkan kecemasan.

a. Bukti Penelitian

1) Teknik komunikasi terapeutik

Studi BMC Nursing menerapkan teori Hildegard Peplau dan menyoroti teknik komunikasi seperti diam, menerima, memberi pengakuan, menawarkan diri, membuka percakapan luas, mendengar aktif, mencari klarifikasi, merangkul, merefleksikan, memfokuskan, dan menghadirkan

harapan atau humor. Komunikasi yang berpusat pada pasien meningkatkan hasil klinis dan kepuasan pasien, sedangkan komunikasi yang tidak efektif memicu stres psikologis dan membuat pasien merasa tidak aman.

2) Keseimbangan antara kehangatan dan keahlian

Perawat perlu menyeimbangkan welas asih, keahlian klinis, dan tuntutan teknologi untuk menciptakan pertemuan yang mendukung kesehatan fisik dan emosional pasien.

b. Rekomendasi Praktis

- 1) Berikan penjelasan yang jelas, menggunakan bahasa sederhana dan hindari istilah medis. Tanyakan kembali apakah pasien memahami informasi.
- 2) Gunakan teknik komunikasi terapeutik (mendengarkan aktif, klarifikasi, refleksi) untuk membangun hubungan dan mengurangi kecemasan.
- 3) Sediakan waktu bagi pasien untuk mengajukan pertanyaan dan berikan dukungan emosional. Kontak mata dan sikap tubuh terbuka membantu menciptakan rasa aman.
- 4) Jika memungkinkan, libatkan keluarga atau pendamping yang dipercaya untuk memberikan dukungan tambahan.

c. Tambahan Bukti dan Strategi

1) Intervensi keperawatan menurunkan kecemasan praoperasi

Sebuah studi kuasi-eksperimental pada pasien preoperatif melaporkan bahwa pendidikan praoperasi, komunikasi terapeutik, teknik relaksasi, dan modifikasi lingkungan menurunkan skor kecemasan dari 58,6 menjadi 42,3 ($p < 0,001$). Ini menunjukkan bahwa kombinasi informasi, dukungan emosional, dan relaksasi efektif menurunkan kecemasan.

2) Psychoeducation dan persiapan bedah

Artikel *Frontiers in Public Health* menyoroti bahwa program psikoedukasi yang komprehensif termasuk penjelasan tentang operasi, teknik relaksasi, dan dukungan keluarga dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan keterampilan koping sebelum dan setelah operasi. Pendidikan yang jelas membantu pasien mempersiapkan diri secara mental.

3) Preferensi komunikasi pada pasien dengan gagal jantung

Studi *PLOS One* membandingkan prioritas komunikasi antara pasien gagal jantung dan tenaga kesehatan. Pasien lebih memprioritaskan penjelasan tentang perangkat medis, sedangkan tenaga kesehatan fokus pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Kebutuhan komunikasi berkorelasi dengan literasi kesehatan, perilaku swaperawatan, dan dukungan sosial; perilaku swaperawatan menjadi faktor paling dominan. Peneliti menekankan

pentingnya strategi komunikasi yang dipersonalisasi dan meningkatkan literasi kesehatan untuk mengurangi kecemasan.

3. Komunikasi dengan Pasien Marah atau Agitasi

Marah merupakan salah satu pemicu utama kekerasan di instalasi gawat darurat. Penelitian menyoroti bahwa keterampilan komunikasi yang buruk meningkatkan risiko kekerasan, sedangkan komunikasi efektif dapat mencegah eskalasi.

a. Bukti Penelitian

1) Pemicu kemarahan dan kekerasan

Studi cross-sectional di ED Tiongkok menemukan bahwa pertemuan dengan pasien marah dan kemampuan komunikasi perawat yang buruk merupakan faktor penting yang meningkatkan risiko kekerasan di tempat kerja. Kurangnya komunikasi yang efektif memicu dan memperburuk kemarahan; strategi terbaik adalah melatih keterampilan komunikasi de-eskalasi. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa peningkatan keterampilan interpersonal dapat mencegah dan meredakan insiden kekerasan.

2) Komponen komunikasi saat menghadapi pasien marah

Kemampuan berkomunikasi dengan pasien marah mencakup persepsi kemarahan, eksplorasi penyebab kemarahan, persiapan diri, dan efikasi diri. Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda kemarahan, mencari tahu penyebabnya dengan bertanya terbuka, dan mempersiapkan diri secara mental (mengatur emosi, menyimak, menilai lingkungan) untuk memberikan dukungan emosional. Efikasi diri yang tinggi memengaruhi kemampuan berkomunikasi efektif

3) Rekomendasi Praktis

a) Kenali tanda kemarahan

Perhatikan perubahan nada suara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Segera respons dengan tenang dan empatik.

- **Gali penyebab kemarahan**

Gunakan pertanyaan terbuka ("Bisakah Anda jelaskan apa yang membuat Anda marah?") untuk memahami situasi.

- **Self-*preparation* dan kontrol diri**

Sebelum merespons, ambil napas dalam, tenangkan diri, dan atur posisi tubuh agar tidak defensif. Persiapan diri (mendengarkan, berempati, menilai lingkungan) meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas komunikasi.

- **Gunakan de-eskalasi verbal**

Tetap tenang, dengarkan tanpa menyela, mengakui perasaan pasien ("Saya memahami Anda merasa kesal"), tawarkan pilihan (misalnya, "Apakah Anda ingin berbicara di tempat yang lebih tenang?") dan pastikan keselamatan semua pihak.

b) Tambahan Bukti dan Strategi

Uji coba terklaster terhadap mahasiswa keperawatan menunjukkan bahwa pelatihan de-eskalasi selama 50 menit signifikan meningkatkan keterampilan de-eskalasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi agresi pasien. De-eskalasi didefinisikan sebagai cara berbicara dengan orang yang marah atau agitasi untuk mencegah kekerasan dan memulihkan ketenangan dan kontrol diri. Hasil ini menegaskan pentingnya memasukkan pelatihan de-eskalasi ke dalam kurikulum dan program pelatihan rumah sakit.

4. Komunikasi dengan Keluarga yang Berduka

Menyampaikan informasi kepada keluarga setelah kematian pasien memerlukan komunikasi yang sensitif dan transparan.

a. Bukti Penelitian

Studi campuran ENHANCE di *BMJ Open* meneliti strategi memberi tahu keluarga bahwa pasien meninggal setelah ikut serta dalam uji klinis darurat. Mayoritas keluarga menghargai diberi tahu tentang partisipasi pasien dan menekankan perlunya komunikasi yang transparan dan sensitif. Penelitian merekomendasikan agar keluarga diberi pilihan untuk menerima informasi segera setelah kematian dan menyoroti bahwa komunikasi tersebut membangun kepercayaan.

b. Rekomendasi Praktis

- 1) Segera hubungi keluarga dengan bahasa yang jelas dan empatik. Sampaikan belasungkawa sebelum memberikan informasi klinis.
- 2) Jelaskan peran pasien dalam penelitian atau perawatan dengan jujur dan sensitif; beri kesempatan keluarga untuk bertanya.
- 3) Pastikan keluarga memiliki pilihan untuk menerima informasi tambahan sesuai kebutuhan mereka; tindak lanjuti setelah komunikasi awal untuk memastikan dukungan berkelanjutan.

c. Tambahan Bukti dan Strategi

1) Kejujuran membangun kepercayaan

Studi kualitatif di *Palliative & Supportive Care* menelaah pengalaman keluarga sebelum dan sesudah kematian pasien. Peserta menilai bahwa komunikasi yang jelas, jujur, dan langsung membangun kepercayaan,

meskipun berita buruk sulit didengar. Sebaliknya, informasi yang ditahan atau tidak lengkap menimbulkan ketidakpercayaan dan frustrasi.

2) Persiapan akhir hayat dan dukungan pascakematian

Studi yang sama melaporkan bahwa keluarga membutuhkan informasi sistematis dan tindak lanjut setelah kematian. Diskusi terbuka tentang prognosis dan gejala akhir hayat membantu keluarga mempersiapkan diri secara praktis, mengurangi distress, dan memungkinkan mereka untuk mendukung pasien secara optimal.

3) Pengalaman kehilangan perinatal

Penelitian kualitatif di *European Journal of Midwifery* mengeksplorasi pengalaman orang tua dan tenaga kesehatan selama kehilangan perinatal. Tema yang muncul termasuk pentingnya menyesuaikan tempo interaksi, mengakui keorangtuaan, menyediakan informasi yang jelas dan jujur untuk keputusan bersama, menjalin kontak autentik sambil menghormati waktu sendiri, menggunakan bahasa yang lembut, dan mendukung kesehatan mental tenaga kesehatan. Orang tua menekankan nilai pengakuan identitas mereka sebagai orang tua dan kesempatan membuat keputusan tentang bayi mereka.

5. Komunikasi Saat Pasien Menolak Tindakan

Penolakan perawatan adalah hak legal pasien, tetapi dapat menimbulkan dilema etis bagi tenaga kesehatan. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencegah dan menangani penolakan.

a. Bukti Penelitian

1) Faktor penyebab penolakan

Studi *cross-sectional* di Lithuania terhadap 393 dokter menemukan bahwa 85 % dokter pernah menghadapi pasien yang menolak perawatan. Kurangnya informasi yang memadai kepada pasien diidentifikasi sebagai penyebab utama penolakan (62,9 %); penolakan menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan pada dokter. Meskipun hukum memberikan hak untuk menolak, sebagian dokter masih cenderung melakukan tindakan tanpa persetujuan, mencerminkan pola paternalistik.

2) Dilema etika dan hak pasien

Studi tersebut menekankan bahwa penolakan adalah manifestasi dari prinsip otonomi pasien dan harus diinformasikan secara jelas seperti halnya persetujuan. Dokter yang memaksa tindakan tanpa persetujuan dapat menghadapi tanggung jawab hukum.

b. Rekomendasi Praktis

1) Evaluasi kapasitas pengambilan keputusan

Pastikan pasien memahami informasi tentang kondisi mereka, konsekuensi penolakan, dan dapat mengutarakan pilihan secara konsisten.

2) Berikan informasi lengkap

Jelaskan manfaat, risiko, dan alternatif tindakan; hindari terminologi teknis yang membingungkan. Kurangnya informasi adalah penyebab utama penolakan.

3) Dengarkan alasan penolakan dengan empatik

Tanyakan apa yang membuat pasien menolak dan validasi kekhawatiran mereka. Catat diskusi dalam rekam medis.

4) Hormati keputusan pasien

Jika pasien berkapasitas dan tetap menolak, hormati pilihannya dan pertimbangkan rencana perawatan alternatif. Jangan memaksa, karena hal itu dapat melanggar hukum dan etika.

c. Tambahan Bukti dan Strategi

Menggunakan bahasa sederhana dan alat bantu komunikasi. Analisis etika tentang penolakan tindakan menekankan bahwa pasien sering menolak karena kurang memahami konsekuensi. Tenaga kesehatan harus menggunakan bahasa sederhana, gambar, atau video, serta melibatkan penerjemah bila dibutuhkan untuk memastikan pasien memahami situasi mereka. Faktor emosional dan budaya juga dapat mempengaruhi keputusan; komunikasi harus sensitif terhadap perbedaan budaya..

6. Komunikasi dengan Pasien Berkebutuhan Khusus (Gangguan Pendengaran)

a. Bukti Penelitian

1) Kebutuhan komunikasi sering diabaikan

Studi kualitatif PLOS One mengenai pengalaman pasien dengan gangguan pendengaran menemukan tiga tema utama: (1) gangguan pendengaran adalah disabilitas "tak terlihat" dan sering luput dari perhatian sehingga pasien dianggap lamban atau memiliki hambatan kognitif; (2) komunikasi adalah usaha tim-pasien perlu didorong untuk mengungkapkan preferensi komunikasi mereka dan staf harus menyesuaikan; dan (3) setiap pasien memiliki kebutuhan berbeda sehingga strategi komunikasi harus disesuaikan. Peserta menekankan bahwa kemampuan untuk berpartisipasi dalam percakapan merupakan hak dan diperlukan untuk perawatan berkualitas.

2) Dukungan dan dokumentasi kebutuhan komunikasi

Peserta menyampaikan bahwa tenaga kesehatan perlu dilatih untuk mengenali kebutuhan pendengaran dan memastikan dokumentasi dalam

catatan medis sehingga seluruh tim mengetahui kebutuhan tersebut. Mereka juga menyoroti pentingnya alat komunikasi seperti papan tulis kecil, aplikasi *voice-to-text*, alat bantu dengar portabel (*pocketalker*), dan akses yang mudah di berbagai unit.

b. Rekomendasi Praktis

1) Identifikasi kebutuhan komunikasi

Tanyakan kepada pasien apakah mereka memiliki gangguan pendengaran dan bagaimana cara terbaik berkomunikasi. Gunakan kartu identifikasi, gelang, atau catatan di rekam medis untuk menandai kebutuhan tersebut.

2) Gunakan berbagai metode komunikasi

Sertakan tulisan, papan tulis, gestur, aplikasi *voice-to-text*, atau penerjemah bahasa isyarat sesuai preferensi pasien.

3) Latih staf dan sediakan alat bantu

Rumah sakit harus menyediakan pelatihan bagi staf untuk mengidentifikasi dan menanggapi gangguan pendengaran. Alat bantu komunikasi harus tersedia di semua unit.

4) Dorong pasien untuk mengungkapkan kebutuhan

Banyak orang enggan mengakui gangguan pendengaran karena stigma; dorong pasien mengungkapkan kebutuhan mereka dan hargai permintaan mereka.

c. Tambahan Bukti dan Strategi

1) Kesenjangan pelatihan dan strategi komunikasi bagi dokter keluarga:

Survei cross-sectional terhadap dokter keluarga menunjukkan hanya 15,8 % responden mendapatkan pelatihan memadai dalam berkomunikasi dengan pasien lansia dengan gangguan pendengaran, dan dokter dengan tingkat kenyamanan rendah lebih cenderung gagal mengidentifikasi kesalahan komunikasi. Artikel ini menyarankan strategi: menyapa pasien dengan hangat, menentukan metode komunikasi yang disukai, meminimalkan kebisingan dan memastikan penerangan baik, menjaga kontak mata, berbicara dengan nada ekspresif dan menyesuaikan pitch, memberi isyarat ketika topik berubah, memeriksa pemahaman, mengulang atau menyusun ulang informasi, menggunakan perangkat bantu dengar atau tulisan, dan mendorong pasien mengulang kembali informasi kunci.

2) Pengalaman pasien dengan presbiakusis (kehilangan pendengaran karena usia)

Studi kualitatif di Irlandia menemukan bahwa pasien lansia sering salah mendengar dan merasa tenaga kesehatan kurang menyadari gangguan pendengaran mereka serta menggunakan terminologi medis yang

membbingungkan. Strategi yang membantu termasuk mengulang dan meresapi pernyataan, memberikan informasi tertulis, menjelaskan konteks, mengurangi kebisingan lingkungan, memastikan kontinuitas perawatan, memperpanjang waktu konsultasi, serta menggunakan bahasa tubuh positif. Penulis menekankan pentingnya tenaga kesehatan memahami perspektif pasien dan meningkatkan kesadaran tentang presbiakusis.

E. Teknik Komunikasi

Teknik Komunikasi Terapeutik Umum Selain strategi khusus, beberapa teknik komunikasi terapeutik umum dapat diterapkan pada semua situasi:

Tabel 4.2 Teknik Komunikasi

Teknik Komunikasi	Deskripsi dan Manfaat	Sumber Ilmiah
Diam dan Mendengarkan Aktif	Memberikan jeda untuk memungkinkan pasien mengungkapkan pikiran tanpa interupsi; mendengarkan aktif melibatkan kontak mata, anggukan, dan tanggapan yang mencerminkan pemahaman.	Teknik komunikasi terapeutik meliputi diam, mendengarkan aktif, klarifikasi, refleksi, dan sebagainya.
Memberi Pengakuan dan Memvalidasi	Mengakui perasaan pasien ("Saya bisa memahami ini sulit bagi Anda") membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan.	Penelitian menunjukkan perawat menggunakan dukungan emosional untuk membina hubungan yang lebih kuat.
Memberikan Klarifikasi dan Informasi	Memastikan pasien memahami informasi; meminta mereka menjelaskan ulang dan mengoreksi kesalahpahaman.	Komunikasi terapeutik berpusat pada pasien meningkatkan pemahaman dan kepuasan.
Summarizing dan Reflecting	Merangkum percakapan dan memantulkan kembali apa yang dikatakan pasien menunjukkan bahwa tenaga kesehatan mendengarkan dengan cermat.	Studi BMC Nursing menyebutkan teknik merangkum dan refleksi sebagai bagian dari komunikasi terapeutik.
Empati Nonverbal	Ekspresi wajah hangat, nada suara lembut, dan bahasa tubuh terbuka membantu menyampaikan empati bahkan ketika kata-kata terbatas.	Perawat yang menunjukkan isyarat nonverbal empatik lebih berhasil membangun kepercayaan.

F. Aplikasi Komunikasi Terapeutik Pada Masalah Khusus

Komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah khusus memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan keterbatasan fisik, mental, atau usia pasien. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan, mengurangi kecemasan, dan memfasilitasi kesembuhan.

contoh aplikasi komunikasi terapeutik pada beberapa pasien dengan masalah khusus:

1. Pasien dengan Gangguan Pendengaran/Tunarungu

Aplikasi: Menggunakan metode komunikasi non-verbal seperti bahasa isyarat, papan tulis/spidol, atau aplikasi tulisan di ponsel.

Teknik: Berbicara dengan posisi wajah menghadap pasien agar pasien dapat membaca gerak bibir, menggunakan pencahayaan yang cukup, dan kontak mata yang konsisten.

2. Pasien dengan Gangguan Bicara/Tuna Wicara

Aplikasi: Menyediakan papan komunikasi yang berisi gambar, huruf, atau kata-kata kebutuhan dasar (misalnya gambar toilet, minum, atau nyeri).

Teknik: Memberi waktu yang cukup bagi pasien untuk merespons dan menghindari memotong pembicaraan.

3. Pasien dengan Gangguan Jiwa (Halusinasi/Perilaku Khusus)

Aplikasi: Fokus pada realitas dan memfokuskan pembicaraan pada perasaan serta keluhan pasien saat ini.

Teknik: Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong pasien mengekspresikan diri, serta memberikan pengakuan (reinforcement) atas perilaku positif atau kepatuhan minum obat.

4. Anak dengan Kebutuhan Khusus (Tuna Grahita/Autis)

Aplikasi: Tahapan pra-interaksi disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, menggunakan pendekatan bermain, dan melibatkan orang tua.

Teknik: Menggunakan bahasa yang sederhana, konkrit, dan bersikap ramah (atraumatik care).

Prinsip Umum:

Aplikasi ini mencakup empat fase: pra-interaksi, orientasi (perkenalan), kerja (inti komunikasi), dan terminasi (penutup).

G. Penerapan Empat Fase Komunikasi Terapeutik—Pra-Interaksi, Orientasi, Kerja, Dan Terminasi.

Fase komunikasi pada Pasien dengan masalah khusus sangat krusial dalam menangani pasien dengan masalah khusus (seperti pasien agresif, cemas berat, tidak kooperatif, atau pasien terminal). Komunikasi ini terstruktur untuk

membangun kepercayaan, mengurangi kecemasan, dan memfasilitasi pemulihan emosional maupun fisik.

Berikut adalah aplikasi empat fase tersebut:

1. Fase Pra-Interaksi (Persiapan)

Pada fase ini tahap sebelum bertemu pasien, di mana perawat mempersiapkan diri dan merencanakan pendekatan.

Aplikasi pada Masalah Khusus:

Pasien Agresif/Psikosis: Membaca catatan medis untuk memahami pola perilaku, menyiapkan tim pendamping jika diperlukan, dan mengeksplorasi perasaan takut diri sendiri agar tetap tenang.

Pasien Terminal: Memahami diagnosis, memprediksi emosi keluarga, dan menenangkan diri agar bisa memberikan empati.

Tindakan: Mengumpulkan data, menganalisis kekuatan/kelemahan diri, dan membuat rencana pertemuan.

2. Fase Orientasi (Perkenalan)

Tahap perkenalan dan membangun kontrak terapeutik. Keberhasilan tahap ini menentukan keberhasilan interaksi selanjutnya.

Aplikasi pada Masalah Khusus:

Pasien Cemas Berat: Memberikan salam yang tenang, memperkenalkan diri, dan menciptakan lingkungan yang aman.

Pasien Tidak Kooperatif: Menvalidasi identitas, menjelaskan tujuan pertemuan dengan jelas, dan menetapkan kontrak waktu yang singkat.

Tindakan: Salam terapeutik, validasi data, tujuan, dan kontrak.

3. Fase Kerja (Inti Komunikasi)

Tahap inti di mana perawat dan pasien bekerja sama mengatasi masalah.

Aplikasi pada Masalah Khusus:

Pasien Halusinasi: Mendengarkan dengan aktif, membantu pasien mengenali halusinasi, dan mengajarkan cara mengontrolnya (misal: menghardik).

Pasien Kanker/Terminal: Menggunakan teknik active listening, membiarkan pasien mengungkapkan ketakutan, bahkan diam dalam keheningan yang suportif.

Tindakan: Menggali alternatif pemecahan masalah, mendorong pengungkapan perasaan, dan melakukan tindakan keperawatan.

4. Fase Terminasi (Penutup)

Tahap akhir pertemuan, baik sementara maupun akhir.

Aplikasi pada Masalah Khusus:

Pasien dengan Gangguan Jiwa: Mengevaluasi respon pasien (apakah kecemasan berkurang), memberikan pujian atas usaha pasien, dan membuat kontrak pertemuan berikutnya.

Pasien Terminal/Pindah Ruangan: Memberikan kesempatan pasien mengungkapkan perasaan tentang berakhirnya interaksi, mengevaluasi hasil interaksi, dan tindak lanjut.

Tindakan: Evaluasi subjektif dan objektif, rencana tindak lanjut, dan kontrak waktu berikutnya.

Strategi Tambahan untuk Masalah Khusus

1. Sentuhan Profesional: Digunakan pada pasien depresi atau terminal untuk menunjukkan empati.
2. Keheningan (Silence): Sangat efektif pada pasien yang sangat emosional atau berduka, memberikan mereka ruang untuk berpikir.
3. Bahasa Sederhana: Penting untuk pasien dengan penurunan kesadaran atau kognitif.

Secara keseluruhan, komunikasi terapeutik membantu pasien memahami kondisi mereka, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepatuhan perawatan

H. Penutup

Literatur ilmiah menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dan empatik merupakan komponen kunci dalam perawatan klinis. Perawat dan tenaga kesehatan harus membangun hubungan yang mendukung, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan informasi yang jelas, dan menghormati otonomi pasien. Bukti menunjukkan bahwa empati, keterlibatan pasien, dan transparansi meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi kecemasan, mencegah agresi, serta memperkuat kepercayaan dalam situasi klinis yang menantang. Dengan mengimplementasikan strategi komunikasi berbasis penelitian ini, tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan bagi pasien dan keluarga.

Referensi

- Achrekar, M. S., Murthy, V., & Kannan, S. (2020). Are patients satisfied with nurses' communication? A cross-sectional survey. *Journal of Practical and Professional Nursing*, 4(2), 021. <https://doi.org/10.24966/PPN-5681.100021>
- Bertolín-Guillén, J. M. (2024). Cognition, anger self-control and self-management. *Current Trends in Clinical & Medical Sciences*, 3(5), CTCMS.MS.ID.000571. <https://doi.org/10.33552/CTCMS.2024.03.000571>

- Buonanno, P., Marra, A., Iacovazzo, C., Vargas, M., Nappi, S., Squillacioti, F., de Siena, A. U., & Servillo, G. (2023). The PATIENT approach: A new bundle for the management of chronic pain. *Journal of Personalized Medicine*, 13(11), 1551. <https://doi.org/10.3390/jpm13111551>
- Čekanauskaitė, A., Lukošienė, K., Krotova, J., Kersnauskaitė, D., Bachmetjev, B., Airapetian, A., & Jakubauskienė, M.(2025). Confronting patients' refusal to undergo treatment: A cross-sectional study of ethical attitudes and intendedbehaviour among Lithuanian physicians. *Healthcare*, 13(22), 2974. <https://doi.org/10.3390/healthcare13222974>
- Chen, X., Zeng, Y., Jiang, L., Tian, L., Yi, J., He, H., ... & Li, L. (2023). Assessing emergency department nurses' ability to communicate with angry patients and the factors that influence it. *Frontiers in Public Health*, 11, 1098803. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1098803>
- Cooper, G. M., & Donnelly, A. (2023). Generalized anxiety disorder. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559243>
- DeBusschere, A., Lunney, M., Reid, S., Verdin, N., Love, S., Thompson, S., ... & Tonelli, M. (2025). Hospital care does not meet the communication needs of patients with hearing loss: A qualitative study of patient experiences. *PLOS ONE*, 20(10), e0333587. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333587>
- Derksen, F., Bensing, J., & Lagro-Janssen, A. (2013). Effectiveness of empathy in general practice: A systematic review. *British Journal of General Practice*, 63(606), e76–e85. <https://doi.org/10.3399/bjgp13x660814>
- Doughty, H., Deja, E., Young, B., Welters, I., Shepherd, V., Milosevic, S., O'Hara, K., Carman, J., Sankar, V., Thomas-Jones, E., Euden, J., & Woolfall, K. (2026). Enhancing communication with bereaved relatives about emergency and critical care trials (ENHANCE): A mixed-methods study. *BMJ Open*, 16(2), e106677. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-106677>
- Gupta, A. (2015). The importance of good communication in treating patients' pain. *AMA Journal of Ethics*, 17(3), 265–267. <https://doi.org/10.1001/journalofethics.2015.17.3.sect1-1503>
- International Association for the Study of Pain. (2020). IASP terminology: Pain. IASP. <https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/#pain>

- Jansens, J., Faes, K., De Coninck, M., Gilissen, J., & Van Kelst, L. (2024). A qualitative study of bereaved parents and healthcare professionals on perinatal loss. *European Journal of Midwifery*, 8, 194159. <https://doi.org/10.18332/ejm/194159>
- Jastrzab, G., Kerr, S., & Fairbrother, G. (2009). Misinterpretation of the Faces Pain Scale-Revised in adult clinical practice. *Acute Pain*, 11(2), 51–55. <https://doi.org/10.1016/j.acpain.2009.03.001>
- Lu, L. L. M., Henn, P., O'Tuathaigh, C., & Smith, S. (2024). Patient-healthcare provider communication and age-related hearing loss: A qualitative study of patients' perspectives. *Irish Journal of Medical Science*, 193(1), 277–284. <https://doi.org/10.1007/s11845-023-03432-4>
- Mansutti, I., Tomé-Pires, C., Chiappinotto, S., & Palese, A. (2023). Facilitating pain assessment and communication in people with deafness: A systematic review. *BMC Public Health*, 23, 1594. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16535-5>
- Mersha, A., Abera, A., Tesfaye, T., Abera, T., Belay, A., Melaku, T., ... & Wake, S. K. (2023). Therapeutic communication and its associated factors among nurses working in public hospitals of Gamo zone, southern Ethiopia: Application of Hildegard Peplau's nursing theory of interpersonal relations. *BMC Nursing*, 22, 381. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01526-z>
- Miller, L. E., Eldredge, S. A., & Dalton, E. D. (2017). "Pain is what the patient says it is": Nurse-patient communication, information seeking, and pain management. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*, 3 (10), 966–976. <https://doi.org/10.1177/1049909116661815>
- Myhill, B., Bindley, K., DiGiacomo, M., Zhang, L., Dash, M., Gough, I., Aggarwal, G., Mohamudally, A., Stewart, L., Lie, E., Parker, J., Huynh, N., Ritchie, M., Taylor, C., & Lee, J. T. (2025). A qualitative exploration of the impact of healthcare pre- and post-death on bereavement experiences. *Palliative & Supportive Care*, 23, e188. <https://doi.org/10.1017/S1478951525100837>
- Nag, T., Gjestad, R., & Senneseth, M. (2023). Effects of de-escalation training on student nurses' skills and confidence. *Sykepleien Forskning*, 18, e-92716. <https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.92716en>
- Nikolova, S., & Gotani, A. (2025). Exploring empathy, communication, and cultural competence in low back pain care: A comparative cross-sectional study of nurses and physicians in Israel. *Frontiers in Communication*, 10, 1674019. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1674019>

- Ostendorf, J., & Kearns, C. (2021). Grief and loss. In *Open RN: Nursing fundamentals* (Chapter 28). Chippewa Valley Technical College. <https://wtcs.pressbooks.pub/nursingfundamentals/chapter/28-7>
- Park, J.-S., Seo, K.-W., Lee, J. E., Kim, K.-H., & Ahn, J.-A. (2025). Communication needs regarding heart failure trajectory and palliative care between patients and healthcare providers: A cross-sectional study. *PLOS ONE*, 20(1), e0317417. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317417>
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist*, 73(4), 433–450. <https://doi.org/10.1037/amp0000298>
- Sadan, E., Bakal, A., Freud, T., et al. (2025). Can you hear me? Physicians' attitudes and knowledge on the principles of communicating with hearing-impaired older adult. *BMC Primary Care*, 26, 162. <https://doi.org/10.1186/s12875-025-02861-7>
- Simpkin, A. L., & Armstrong, K. A. (2019). Communicating uncertainty: A narrative review and framework for research and clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 34(12), 2691–2699. <https://doi.org/10.1007/s11606-019-04860-8>
- Yasin, M., Arshad, M., Nigar, Z., Tasneem, S. S., & Jabeen, R. (2024). Effectiveness of pre-operative nursing intervention program on anxiety and perceived control program in patient undergoing cardiac surgery. *Biological and Clinical Sciences Research Journal*, 2024(1), 1300. <https://doi.org/10.54112/bcsrj.v2024i1.1300>

BAB V

KOMUNIKASI DENGAN KELUARGA DAN CAREGIVER (FAMILY CONFERENCE, SHARED DECISION-MAKING, EDUKASI, DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL)

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan modern telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada penyakit (*disease-centered care*) menuju pendekatan yang berpusat pada pasien dan keluarga (*patient- and family-centered care*). Dalam pendekatan ini, pasien tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana keluarga dan caregiver memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses perawatan. Keterlibatan keluarga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terapi, pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta stabilitas emosional pasien, terutama pada kondisi penyakit kronis seperti diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular (WHO, 2021).

Penyakit kronis memerlukan manajemen jangka panjang yang kompleks, meliputi perubahan gaya hidup, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keluarga seringkali berperan sebagai *caregiver utama* yang mendampingi pasien dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pengelolaan diet, aktivitas fisik, serta pengawasan penggunaan obat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif keluarga dapat meningkatkan kontrol glikemik pada pasien diabetes serta menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular (Baig et al., 2015).

Meskipun demikian, keberhasilan keterlibatan keluarga sangat bergantung pada kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan terapeutik yang saling percaya (*trust*) dan kolaboratif. Melalui komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat menyampaikan informasi medis secara jelas, memahami kebutuhan serta nilai pasien, dan melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, serta rendahnya kepatuhan terhadap rencana terapi (Street et al., 2009).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, berbagai hambatan komunikasi masih sering ditemukan. Hambatan tersebut meliputi perbedaan latar belakang budaya, tingkat literasi kesehatan yang rendah, keterbatasan waktu konsultasi, serta kurangnya keterampilan komunikasi tenaga kesehatan. Literasi kesehatan yang rendah, misalnya, dapat menyebabkan keluarga kesulitan memahami informasi medis yang kompleks, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang optimal (Nutbeam & Lloyd, 2021). Selain itu, faktor emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan stres juga dapat memengaruhi efektivitas komunikasi, terutama pada pasien dengan penyakit kronis atau kondisi yang mengancam jiwa.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan komunikasi yang terstruktur dan sistematis. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *family conference*, yaitu pertemuan terencana antara tim kesehatan, pasien, dan keluarga untuk membahas kondisi klinis, prognosis, serta rencana perawatan secara komprehensif. *Family conference* memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang terbuka, klarifikasi harapan, serta penyelarasan persepsi antara semua pihak yang terlibat (Hudson et al., 2018).

Selain itu, pendekatan *shared decision-making* (SDM) menjadi semakin penting dalam pelayanan kesehatan modern. SDM merupakan proses kolaboratif di mana tenaga kesehatan dan pasien/keluarga bersama-sama mempertimbangkan berbagai pilihan terapi berdasarkan bukti ilmiah serta preferensi pasien. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien, kualitas keputusan, serta kepatuhan terhadap pengobatan (Siebinga et al., 2022). Edukasi kesehatan juga merupakan komponen penting dalam komunikasi dengan keluarga dan caregiver. Edukasi yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri keluarga dalam merawat pasien. Metode edukasi yang interaktif, berbasis kebutuhan, dan disesuaikan dengan tingkat literasi kesehatan akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku (Glanz et al., 2020).

Di samping itu, dukungan psikososial menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pelayanan kesehatan. Penyakit kronis seringkali berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Pasien dan keluarga dapat mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan emosional, empati, serta pendampingan yang berkelanjutan untuk membantu pasien dan keluarga beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi (Taylor & Stanton, 2020).

Dengan demikian, integrasi pendekatan komunikasi seperti *family conference*, *shared decision-making*, edukasi kesehatan, dan dukungan psikososial merupakan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan keluarga, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat holistik, sesuai dengan nilai dan preferensi pasien, serta mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang melatarbelakangi.

B. Konsep Komunikasi dengan Keluarga dan *Caregiver*

1. Pengertian Komunikasi dalam Pelayanan Kesehatan

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara tenaga kesehatan, pasien, serta keluarga/caregiver yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama terkait kondisi kesehatan, rencana perawatan, serta pengambilan keputusan klinis. Komunikasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga terapeutik, karena mampu membangun hubungan saling percaya, meningkatkan kepatuhan pasien, serta memperbaiki hasil kesehatan (Street et al., 2009). Dalam konteks pelayanan modern yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*), komunikasi melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam sistem perawatan, terutama pada penyakit kronis seperti diabetes melitus yang memerlukan dukungan jangka panjang. Keterlibatan keluarga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan self-management pasien dan hasil kesehatan yang lebih baik (Baig et al., 2015).

2. Prinsip Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan didasarkan pada beberapa prinsip utama (Diniharyanti, 2022), adalah sebagai berikut:

a. Empati

Empati adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan merasakan kondisi emosional pasien dan keluarga. Empati membantu membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kenyamanan pasien, serta memperkuat kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.

b. Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan mencerminkan sikap jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi pasien, diagnosis, dan rencana terapi. Keterbukaan juga mencakup kesiapan tenaga kesehatan untuk menerima pertanyaan dan masukan dari pasien maupun keluarga.

c. Kejelasan informasi (*clarity*)

Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, tanpa penggunaan istilah medis yang kompleks. Kejelasan komunikasi penting untuk menghindari kesalahpahaman serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi.

d. Respek terhadap nilai budaya

Tenaga kesehatan harus menghargai nilai budaya, kepercayaan, dan latar belakang sosial pasien serta keluarga. Sensitivitas budaya sangat penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi dan penerimaan intervensi kesehatan.

e. Partisipasi aktif keluarga

Keluarga dan caregiver perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pemantauan kondisi pasien, serta dukungan emosional. Partisipasi ini terbukti meningkatkan keberhasilan manajemen penyakit kronis dan kualitas hidup pasien.

3. Peran Keluarga dan Caregiver

Peran keluarga dan caregiver dalam pelayanan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis dan kondisi jangka panjang. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendamping pasien, tetapi juga sebagai sistem pendukung utama yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan, kepatuhan terapi, serta pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial pasien. Keterlibatan aktif keluarga terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup serta hasil klinis pasien, sehingga keberadaannya menjadi bagian integral dalam pendekatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien (*patient- and family-centered care*).

Peran keluarga dan caregiver dalam pelayanan kesehatan adalah:

a. Pendukung Emosional

Keluarga berperan sebagai sumber dukungan psikologis utama bagi pasien. Dukungan ini meliputi empati, perhatian, motivasi, serta kehadiran fisik yang memberi rasa aman (Maria et al., 2024).

1) Dukungan emosional terbukti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi pasien.

2) Pada penyakit kronis, keberadaan keluarga membantu pasien lebih adaptif terhadap kondisi penyakitnya.

b. Pengambil Keputusan (*Decision Maker*)

Keluarga memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dalam proses perawatan pasien, khususnya ketika pasien mengalami keterbatasan dalam kapasitas pengambilan keputusan, seperti pada kondisi kritis, lanjut usia (*lansia*), atau gangguan kognitif (Beauchamp & Childress, 2019). Dalam kondisi ini, keluarga bertindak sebagai *substitute decision-maker* yang mewakili kepentingan serta nilai-nilai pasien (Epstein & Turner, 2015). Pengambilan keputusan oleh keluarga umumnya didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu *substituted judgment* (berdasarkan preferensi pasien sebelumnya) dan

best interest (berdasarkan kepentingan terbaik pasien jika preferensi tidak diketahui) (Beauchamp & Childress, 2019).

Ruang lingkup peran pengambil Keputusan:

1) Menentukan pilihan terapi

Keluarga berperan dalam memilih alternatif terapi yang ditawarkan oleh tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, serta kualitas hidup pasien. Proses ini idealnya dilakukan melalui pendekatan *shared decision-making* antara tenaga kesehatan dan keluarga untuk menghasilkan keputusan yang etis dan rasional (Wehking et al., 2024).

2) Menyetujui tindakan medis (*informed consent*)

Dalam praktik klinis, keluarga memberikan persetujuan tindakan medis ketika pasien tidak kompeten secara hukum atau medis. Proses *informed consent* menuntut pemberian informasi yang lengkap mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, dan alternatif terapi sebelum persetujuan diberikan (Kamila et al., 2025)

3) Menentukan perawatan lanjutan atau paliatif

Pada kondisi penyakit kronis atau terminal, keluarga berperan dalam menentukan keberlanjutan terapi, termasuk keputusan untuk beralih ke perawatan paliatif guna meningkatkan kualitas hidup pasien (World Health Organization, 2018).

Aspek Etik dan Hukum

Peran keluarga sebagai pengambil keputusan harus mempertimbangkan prinsip etik, yaitu otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice, yang menjadi dasar dalam praktik pelayanan kesehatan (Beauchamp & Childress, 2019).

c. Pengawas Terapi (Therapy Supervisor)

Keluarga berperan sebagai pengawas terapi dalam memastikan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Peran ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka Panjang (Nurhayati et al., 2026). Keterlibatan keluarga dalam pengawasan terapi terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan (*medication adherence*) dan memperbaiki outcome klinis pasien melalui dukungan langsung dan pengawasan yang berkelanjutan (Harper et al., 2018).

Sebagai pengawas terapi, keluarga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur, mengontrol pola diet dan gaya hidup sehat, serta memantau tanda dan gejala penyakit untuk

mencegah komplikasi lebih lanjut (Baig et al., 2015; World Health Organization, 2018).

Keterlibatan keluarga dalam pengawasan terapi terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan (*medication adherence*) dan memperbaiki outcome klinis pasien melalui dukungan langsung dan pengawasan yang berkelanjutan (Association, 2024). Peran ini menjadi sangat krusial pada penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, dan stroke, karena kondisi tersebut memerlukan pengelolaan terapi jangka panjang serta perubahan gaya hidup yang konsisten untuk mencegah komplikasi (World Health Organization, 2018).

Ruang lingkup peran pengawas terapi (Harper et al., 2018):

- 1) Mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur
- 2) Mengontrol diet dan gaya hidup (aktivitas fisik, pola makan, berhenti merokok)
- 3) Memantau tanda dan gejala penyakit
- 4) Mengawasi kepatuhan terhadap kontrol rutin ke fasilitas kesehatan

d. Penghubung dengan Tenaga Kesehatan (Care Coordinator)

Keluarga berperan sebagai penghubung atau koordinator perawatan (care coordinator) yang menjembatani komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Peran ini menjadi sangat penting terutama pada pasien dengan keterbatasan dalam memahami informasi medis atau dalam mengakses layanan Kesehatan (Hendrawati et al., 2023). Keluarga memiliki peran dalam mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Keluarga berperan dalam menentukan cara atau asuhan yang diperlukan klien di rumah (Rahmi et al., 2025). Sebagai penghubung, keluarga bertugas menyampaikan keluhan pasien secara akurat kepada tenaga kesehatan, memahami serta mengklarifikasi instruksi medis yang diberikan, dan mengatur jadwal kontrol maupun terapi lanjutan agar perawatan berjalan sesuai rencana (World Health Organization, 2018).

Keluarga bertugas menyampaikan keluhan pasien secara akurat kepada tenaga kesehatan, memahami serta mengklarifikasi instruksi medis yang diberikan, dan mengatur jadwal kontrol maupun terapi lanjutan agar perawatan berjalan sesuai rencana (World Health Organization, 2018; Hewner et al., 2021). Selain itu, keterlibatan keluarga dalam koordinasi perawatan terbukti mampu meningkatkan efektivitas komunikasi, mengurangi risiko kesalahan medis, serta memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan (*continuity of care*) (Hewner et al., 2021). Peran keluarga sebagai penghubung juga berkontribusi

dalam meningkatkan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan melalui komunikasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan (Agency for Healthcare Research and Quality, 2022)

Ruang lingkup peran *care coordinator*:

- 1) Menyampaikan keluhan dan kondisi pasien kepada tenaga kesehatan
- 2) Memahami dan mengklarifikasi instruksi medis
- 3) Mengatur jadwal kontrol, terapi, dan rujukan
- 4) Mengkoordinasikan informasi antar tenaga kesehatan

Pentingnya peran ini:

- 1) Mencegah kesalahan komunikasi (*miscommunication*) dalam pelayanan kesehatan
- 2) Meningkatkan kontinuitas pelayanan (*continuity of care*)
- 3) Mengurangi risiko kesalahan medis
- 4) Meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien

C. Family Conference dalam Pelayanan Kesehatan

1. Definisi Family Conference

Family conference atau *family meeting* merupakan suatu pertemuan terstruktur antara tim tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga yang bertujuan untuk membahas kondisi klinis, prognosis, serta rencana perawatan secara kolaboratif. Kegiatan ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan dalam pelayanan Kesehatan (Yu et al., 2024).

Family conference juga dipandang sebagai mekanisme utama dalam pendekatan *patient and family centered care* karena memungkinkan pertukaran informasi, klarifikasi tujuan perawatan, serta penyelarasan nilai antara pasien, keluarga, dan tenaga Kesehatan (Abu-Rish Blakeney et al., 2023).

2. Tujuan Family Conference

Tujuan utama pelaksanaan *family conference* meliputi:

- a. Memberikan informasi yang jelas terkait diagnosis, prognosis, dan terapi
- b. Menyelaraskan tujuan perawatan (*goals of care*) antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan
- c. Mendukung pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*)
- d. Memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada keluarga

Family meeting memungkinkan semua pihak untuk mendiskusikan kondisi pasien secara terbuka serta menyepakati rencana perawatan yang sesuai dengan nilai dan preferensi pasien (Zhang et al., 2025).

3. Komponen Utama Family Conference

Beberapa komponen penting dalam pelaksanaan *family conference* meliputi:

- a. Persiapan (penentuan tujuan, peserta, dan waktu)
- b. Penyampaian informasi medis secara jelas dan empatik
- c. Eksplorasi nilai dan preferensi pasien/keluarga
- d. Diskusi pilihan terapi dan rencana perawatan
- e. Kesepakatan bersama (decision-making)
- f. Dokumentasi hasil pertemuan

Komponen ini penting untuk memastikan bahwa proses komunikasi berjalan efektif dan keputusan yang diambil bersifat komprehensif (Yu et al., 2024).

4. Manfaat Family Conference

Family conference memiliki berbagai manfaat dalam pelayanan kesehatan, antara lain:

- a. Meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga
- b. Mengurangi konflik dan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan
- c. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan
- d. Mengurangi distress psikologis keluarga (ansietas, depresi, PTSD)
- e. Meningkatkan kualitas perawatan terutama pada kondisi terminal

Penelitian menunjukkan bahwa *family meeting* berhubungan dengan peningkatan kualitas perawatan akhir hayat serta penurunan tindakan medis yang tidak perlu (Yu et al., 2024). Selain itu, *family conference* dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis keluarga serta membantu mereka mempersiapkan proses kehilangan (Glajchen et al., 2022).

5. Peran Family Conference

Family conference sangat penting dalam:

- a. Perawatan pasien kritis (ICU)
- b. Penyakit kronis (diabetes, kanker, gagal jantung)
- c. Perawatan paliatif dan end-of-life care

Pendekatan ini mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi antara tim kesehatan dan keluarga, yang terbukti meningkatkan *outcome* klinis serta kualitas hidup pasien (Glajchen et al., 2022). Dalam konteks paliatif, *family meeting* menjadi intervensi utama untuk menyelaraskan tujuan perawatan serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga (Bajt et al., 2025)

6. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun bermanfaat, terdapat beberapa tantangan:

- a. Perbedaan persepsi antara keluarga dan tenaga kesehatan
- b. Keterbatasan waktu dan sumber daya

- c. Hambatan komunikasi (bahasa, budaya, emosi)
- d. Kurangnya pelatihan tenaga kesehatan

Variasi dalam pelaksanaan family meeting masih tinggi antar fasilitas kesehatan, sehingga diperlukan standarisasi dan pelatihan yang lebih baik (Zhang et al., 2025).

D. Shared Decision-Making dalam Pelayanan Kesehatan

1. Definisi Shared Decision-Making (SDM)

Shared Decision-Making (SDM) adalah proses kolaboratif antara tenaga kesehatan dan pasien dalam membuat keputusan terkait perawatan dengan mempertimbangkan bukti ilmiah serta nilai, preferensi, dan kondisi pasien (Barton et al., 2025). Dalam SDM, pasien tidak lagi menjadi objek pasif, tetapi menjadi mitra aktif dalam menentukan pilihan terapi yang paling sesuai dengan kebutuhannya ((Merschel, 2023).

2. Prinsip Dasar Shared Decision-Making

SDM didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Kolaborasi antara pasien dan tenaga kesehatan
- b. Transparansi informasi (risiko, manfaat, alternatif terapi)
- c. Penghormatan terhadap nilai dan preferensi pasien
- d. Partisipasi aktif pasien dalam pengambilan keputusan

Pendekatan ini mengintegrasikan bukti klinis dengan preferensi individu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih personal dan kontekstual (Barton et al., 2025).

3. Tujuan Shared Decision-Making

Tujuan utama SDM meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis
- b. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi
- d. Mengurangi konflik antara pasien dan tenaga kesehatan

SDM juga bertujuan untuk menciptakan perawatan yang sesuai dengan kondisi kehidupan pasien (*care that fits*) (Barton et al., 2025).

4. Proses / Tahapan Shared Decision-Making

Tahapan SDM secara umum meliputi:

- a. Menyampaikan pilihan (*choice talk*)
Tenaga kesehatan menjelaskan bahwa terdapat beberapa pilihan terapi
- b. Memberikan informasi (*option talk*)
Menjelaskan risiko, manfaat, dan alternatif dari setiap pilihan
- c. Mendiskusikan preferensi (*preference talk*)

Menggali nilai, kebutuhan, dan harapan pasien

d. Pengambilan keputusan (*decision talk*)

Menentukan pilihan terbaik secara bersama

Pendekatan ini dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah konsultasi untuk memastikan keterlibatan pasien secara menyeluruh (Excellence., 2021).

5. Manfaat Shared Decision-Making

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa SDM memberikan dampak positif, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- b. Meningkatkan pengalaman dan kepuasan pasien
- c. Meningkatkan kepatuhan pengobatan
- d. Mengoptimalkan outcome klinis

SDM memiliki efek positif terhadap outcome kesehatan dan kualitas layanan Kesehatan. Selain itu, SDM juga dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan dan hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan (Wehking et al., 2024).

6. Peran Keluarga dalam Shared Decision-Making

Keluarga memiliki peran penting dalam SDM, terutama pada pasien dengan kondisi:

- a. Penyakit kronis
- b. Lansia
- c. Gangguan kognitif
- d. Kondisi kritis

Keterlibatan keluarga membantu pasien:

- a. Memahami informasi medis
- b. Mengingat informasi yang diberikan
- c. Menyampaikan preferensi pasien

Keterlibatan keluarga direkomendasikan sebagai bagian dari proses SDM untuk meningkatkan kualitas keputusan (Excellence., 2021).

7. Tantangan Implementasi

Meskipun efektif, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi SDM:

- a. Keterbatasan waktu konsultasi
- b. Rendahnya literasi kesehatan pasien
- c. Kurangnya pelatihan tenaga kesehatan
- d. Perbedaan budaya dan komunikasi

Selain itu, sebagian tenaga kesehatan masih terbiasa dengan model paternalistik sehingga SDM belum optimal diterapkan (Hoque, 2024).

8. Implementasi dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, SDM dapat diterapkan melalui:

- a. Edukasi pasien dan keluarga
- b. Komunikasi terapeutik
- c. Pendampingan dalam memilih terapi
- d. Kolaborasi dengan tim interprofesional

Perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu pasien memahami informasi dan mengekspresikan preferensinya.

E. Edukasi Kesehatan

1. Definisi Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan. Menurut World Health Organization, (2022), edukasi kesehatan merupakan kombinasi pengalaman belajar yang bertujuan meningkatkan kontrol terhadap determinan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Consensus & Education (2022) mendefinisikan edukasi kesehatan sebagai proses sistematis untuk memengaruhi perilaku kesehatan melalui peningkatan pengetahuan dan pengembangan keterampilan hidup sehat.

2. Tujuan Edukasi Kesehatan

Tujuan edukasi kesehatan (World Health Organization, 2022), meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan
- b. Membentuk sikap positif terhadap perilaku sehat
- c. Mengubah perilaku menjadi lebih sehat
- d. Meningkatkan kemandirian dalam menjaga kesehatan
- e. Mencegah penyakit dan komplikasi

Selain itu, Consensus & Education (2022) menyatakan bahwa edukasi kesehatan berfokus pada perubahan perilaku melalui peningkatan pengetahuan, pengembangan sikap, dan keterampilan individu dalam mengambil keputusan kesehatan.

3. Ruang Lingkup Edukasi Kesehatan

Ruang lingkup edukasi kesehatan (Mujiyono, 2019) mencakup:

- a. Promosi kesehatan
- b. Pencegahan penyakit (primer, sekunder, tersier)
- c. Rehabilitasi
- d. Edukasi pada penyakit akut dan kronis
- e. Edukasi berbasis komunitas dan keluarga

4. Prinsip Edukasi Kesehatan

Prinsip utama (Cottrell et al., 2023), yaitu :

- a. Berpusat pada sasaran (*client-centered*)
Prinsip ini menekankan bahwa edukasi harus berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi individu/keluarga. Konsep ini sejalan dengan *patient-centered care* yang menekankan penghormatan terhadap nilai, budaya, dan pilihan pasien
- b. Berdasarkan kebutuhan
Edukasi kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan sasaran (need-based), baik individu, keluarga, maupun masyarakat
- c. Partisipatif
Sasaran harus dilibatkan secara aktif dalam proses edukasi (tidak pasif)
- d. Berkesinambungan
Edukasi kesehatan merupakan proses belajar yang berlangsung terus-menerus, bukan sekali intervensi
- e. Menggunakan komunikasi efektif
Keberhasilan edukasi sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, persuasif, dan sesuai dengan karakteristik sasaran
- f. Mempertimbangkan budaya dan nilai social
Edukasi harus sensitif terhadap budaya, kepercayaan, dan nilai yang dianut masyarakat

5. Metode Edukasi Kesehatan

Metode edukasi kesehatan diklasifikasikan berdasarkan sasaran pendidikan, yaitu:

- a. Metode Individu
 - 1) Konseling
 - 2) Wawancara
 - 3) Edukasi personal (*one-to-one teaching*)Metode ini dilakukan secara langsung antara tenaga kesehatan dan klien sehingga memungkinkan komunikasi dua arah dan penyesuaian dengan kebutuhan individu.
- b. Metode Kelompok
 - 1) Diskusi kelompok
 - 2) Seminar
 - 3) PenyuluhanMetode ini digunakan untuk sasaran kelompok kecil maupun besar, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan melalui interaksi dan partisipasi.

c. Metode Massa

- 1) Media sosial
- 2) Televisi dan radio
- 3) Kampanye kesehatan

Metode ini digunakan untuk menjangkau masyarakat luas melalui media komunikasi dan teknologi.

6. Media Edukasi Kesehatan

Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik sasaran:

- a. Media cetak (leaflet, booklet)
- b. Media audiovisual (video, animasi)
- c. Media digital (aplikasi kesehatan, e-learning)

7. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi

Tenaga kesehatan berperan sebagai:

- a. Edukator
- b. Fasilitator
- c. Motivator
- d. Konselor

Edukasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan outcome pasien.

8. Strategi Efektif Edukasi Kesehatan

- a. Gunakan bahasa sederhana
- b. Terapkan metode teach-back
- c. Libatkan keluarga
- d. Gunakan media visual
- e. Integrasikan teknologi digital

F. Dukungan Psikososial

1. Pengertian Dukungan Psikososial

Dukungan psikososial adalah bantuan yang mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual yang diberikan kepada individu (pasien) dan keluarganya untuk meningkatkan kemampuan coping dalam menghadapi penyakit atau stress (World Health Organization, 2020).

2. Bentuk Dukungan

a. Dukungan emosional

Meliputi empati, perhatian, kasih sayang, dan penerimaan terhadap pasien.

b. Dukungan informasional

Berupa pemberian informasi, edukasi, dan saran yang membantu pasien memahami kondisinya.

c. Dukungan instrumental

Berupa bantuan nyata seperti bantuan finansial, fasilitas, atau tindakan langsung dalam perawatan

3. Peran Tenaga Kesehatan

a. Konseling

Tenaga kesehatan memberikan bimbingan psikologis untuk membantu pasien beradaptasi dengan penyakit.

b. Motivasi

Memberikan dorongan agar pasien patuh terhadap terapi dan memiliki semangat untuk sembuh.

c. Pendampingan

Melibatkan kehadiran tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada pasien dan keluarga.

G. Komunikasi dalam Situasi Sulit (*Difficult Conversations*)

1. Definisi Komunikasi dalam Situasi Sulit

Komunikasi dalam situasi sulit merupakan proses interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga dalam kondisi yang melibatkan emosi tinggi, ketidakpastian, atau berita yang tidak menyenangkan, seperti diagnosis penyakit serius, kondisi terminal, kegagalan terapi, atau kematian. Situasi ini menuntut keterampilan komunikasi yang lebih kompleks, karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengelola respon emosional pasien dan keluarga (Back et al., 2019).

2. Jenis Situasi Sulit dalam Pelayanan Kesehatan

Beberapa kondisi yang termasuk dalam komunikasi sulit antara lain:

- a. Penyampaian diagnosis penyakit berat (kanker, gagal organ)
- b. Penyampaian prognosis buruk
- c. Diskusi perawatan paliatif atau end-of-life care
- d. Penolakan terapi oleh pasien/keluarga
- e. Konflik antara keluarga dan tenaga kesehatan
- f. Kematian pasien

Situasi tersebut seringkali memicu reaksi emosional seperti marah, denial, kecemasan, atau kesedihan mendalam.

3. Prinsip Komunikasi dalam Situasi Sulit

Menurut Vick et al. (2024), dalam menghadapi situasi sulit, tenaga kesehatan perlu memperhatikan prinsip Empati dan validasi emosi. Mengakui perasaan pasien/keluarga tanpa menghakimi.

- a. Kejujuran (truth-telling)

Informasi harus disampaikan secara jujur, namun tetap sensitif.

b. Pendekatan bertahap

Informasi diberikan secara bertahap sesuai kesiapan pasien/keluarga.

c. Bahasa sederhana

Menghindari istilah medis yang kompleks.

d. Dukungan emosional berkelanjutan

Tidak hanya saat penyampaian informasi, tetapi juga setelahnya.

4. Dampak Komunikasi yang Tidak Tepat

Komunikasi yang tidak efektif dalam situasi sulit dapat menyebabkan:

a. Trauma psikologis pada keluarga

b. Ketidakpercayaan terhadap tenaga kesehatan

c. Konflik dalam pengambilan keputusan

d. Penolakan terapi

Sebaliknya, komunikasi yang baik dapat meningkatkan penerimaan kondisi dan kualitas keputusan (Back et al., 2019).

H. Pendekatan Budaya dalam Komunikasi dengan Keluarga

1. Pentingnya Sensitivitas Budaya

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat tinggi, sehingga komunikasi dalam pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan nilai, norma, dan kepercayaan lokal. Budaya memengaruhi cara individu memahami penyakit, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan tenaga kesehatan (Rahmi et al., 2025).

2. Pengaruh Budaya terhadap Pengambilan Keputusan

Dalam beberapa budaya, keputusan kesehatan tidak diambil secara individual, melainkan kolektif oleh keluarga. Hal ini sering ditemukan pada masyarakat Asia, termasuk Indonesia, yaitu: keluarga memiliki peran dominan, keputusan mempertimbangkan nilai sosial dan agama, dan hierarki keluarga memengaruhi keputusan (Mori et al., 2023).

3. Hambatan Komunikasi Berbasis Budaya

Beberapa hambatan yang sering terjadi adalah:

a. Perbedaan bahasa

b. Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional

c. Persepsi terhadap penyakit

d. Sikap terhadap kematian

4. Strategi Komunikasi Sensitif Budaya

Menurut Mori et al. (2023), untuk mengatasi hambatan tersebut, tenaga kesehatan dapat:

- a. Menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami
- b. Menghormati kepercayaan pasien dan keluarga
- c. Melibatkan tokoh keluarga atau agama jika diperlukan
- d. Menghindari sikap menghakimi

Pendekatan ini meningkatkan penerimaan intervensi dan keberhasilan terapi.

I. Evaluasi Efektivitas Komunikasi dengan Keluarga

1. Pentingnya Evaluasi Komunikasi

Evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai apakah komunikasi yang dilakukan telah efektif dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan (Rahmi et al., 2025).

2. Indikator Keberhasilan Komunikasi

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi (Yen & Leasure, 2019), antara lain:

- a. Tingkat pemahaman pasien/keluarga
- b. Kepuasan terhadap pelayanan
- c. Kepatuhan terhadap terapi
- d. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- e. Penurunan konflik

3. Metode Evaluasi

Evaluasi komunikasi dapat dilakukan melalui:

- a. Observasi langsung
Menilai interaksi tenaga kesehatan dengan keluarga
- b. Feedback pasien/keluarga
Melalui wawancara atau kuesioner
- c. Metode *teach-back*
Pasien diminta mengulang informasi
- d. Audit dokumentasi
- e. Menilai kelengkapan catatan komunikasi

4. Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk:

- a. Meningkatkan keterampilan komunikasi tenaga kesehatan
- b. Mengembangkan pelatihan komunikasi
- c. Memperbaiki sistem pelayanan

Evaluasi yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan (Yen & Leasure, 2019).

J. Penutup

1. Kesimpulan

Komunikasi dengan keluarga dan caregiver merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Saran

Perlu peningkatan kompetensi komunikasi tenaga kesehatan dan keterlibatan aktif keluarga.

Referensi

- Abu-Rish Blakeney, E., Baird, J., Beaird, G., Khan, A., Parente, V. M., O'Brien, K. D., Zierler, B. K., O'Leary, K. J., & Weiner, B. J. (2023). How and why might interprofessional patient- and family-centered rounds improve outcomes among healthcare teams and hospitalized patients? A conceptual framework informed by scoping and narrative literature review methods. *Frontiers in Medicine*, 10(October), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1275480>
- Association, A. D. (2024). Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of care in diabetes. *Diabetes Care*, 47(January), S181–S206. <https://doi.org/10.2337/dc25-S009>
- Back, A. L., Fromme, E. K., & Meier, D. E. (2019). Training Clinicians with Communication Skills Needed to Match Medical Treatments to Patient Values. *Journal of the American Geriatrics Society*, 67(S2), S435–S441. <https://doi.org/10.1111/jgs.15709>
- Baig, A. A., Benitez, A., Quinn, M. T., & Burnet, D. L. (2015). Family interventions to improve diabetes outcomes for adults. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1353(1), 89–112. <https://doi.org/10.1111/nyas.12844>
- Bajt, M., Jagodic Klipšteter, L., & Zelko, E. (2025). Barriers and Facilitators of Family Meetings in Primary Palliative Care: Insights From Slovenia. *Zdravstveno Varstvo*, 64(2), 112–120. <https://doi.org/10.2478/sjph-2025-0014>
- Barton, J. L., Niederhausen, M., Tuepker, A., Schmajuk, G., Baker, J., Lovejoy, T. I., Morasco, B. J., Kunneman, M., & Scholl, I. (2025). Implementation of shared decision making in rheumatoid arthritis: study protocol for RAiSeD (Rheumatoid Arthritis Shared Decision Making) stepped wedge, cluster-randomized trial. *Trials*, 26(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13063-025-09015-1>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of Biomedical Ethics. In *Oxford University Press* (8th ed).
- Consensus, N., & Education, for S. H. (2022). National Health Education Standards: Model Guidance for Curriculum and Instruction. In *Encyclopedia of School Health*. <https://doi.org/10.4135/9781452276250.n112>
- Cottrell, R. R. ., Seabert, D., Spear, C., & McKenzie, J. F. . (2023). *Principles of health education and promotion* (Eighth Edi). https://books.google.com/books/about/Principles_of_Health_Education_and_Pro mo.html?id=ACw9EAAAQBAJ
- Diniharyanti, Y. (2022). *Pedoman Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Keperawatan*.

Eclinic.

- Epstein, B., & Turner, M. (2015). The Nursing Code of Ethics: Its Value, Its History | OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing. *The Online Journal of Issues In Nursing*. <https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-20-2015/No2-May-2015/The-Nursing-Code-of-Ethics-Its-Value-Its-History.html#ANA10>
- Excellence., N. I. for H. and C. (2021). *Shared decision making guideline*. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572428/>
- Glajchen, M., Goehring, A., Johns, H., & Portenoy, R. K. (2022). Family Meetings in Palliative Care: Benefits and Barriers. *Current Treatment Options in Oncology*, 23(5), 658–667. <https://doi.org/10.1007/s11864-022-00957-1>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2020). *Health Behavior_ Theory, Research, and Practice* (Fifth Edit).
- Harper, K. J., Osborn, C. Y., & Mayberry, L. S. (2018). Patient-perceived family stigma of type 2 diabetes and its consequences. *Families, Systems and Health*, 36(1), 113–117. <https://doi.org/10.1037/fsh0000316>
- Hendrawati, H., Amira, I., Sumarni, N., Rosidin, U., & Maulana, I. (2023). Peran keluarga dalam merawat orang dengan gangguan jiwa: A scoping review. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(7), 575–588. <https://doi.org/10.33024/hjk.v17i7.12741>
- Hewner, S., Chen, C., Anderson, L., Pasek, L., Anderson, A., & Popejoy, L. (2021). Transitional Care Models for High-Need, High-Cost Adults in the United States: A Scoping Review and Gap Analysis. *Professional Case Management*, 26(2), 82–98. <https://doi.org/10.1097/NCM.0000000000000442>
- Hoque, F. (2024). Shared Decision-Making in Patient Care: Advantages, Barriers and Potential Solutions. *Journal of Brown Hospital Medicine*, 3(4), 13–15. <https://doi.org/10.56305/001c.122787>
- Hudson, P., Thomas, K., Girgis, A., Mitchell, G., Philip, J., Parker, D., Currow, D., Liew, D., Le, B., Maron, J., & Brand, C. (2018). Benefits of Family Meetings for Hospitalized Palliative Care Patients and Their Family Caregivers. *Journal of Pain and Symptom Management*, 56(6).
- Kamila, P., Soekiswati, S., Romadhon, Y. A., Busyra, & Sari, T. P. (2025). Informed Consent pada Pasien Pre-Operasi di Rumah Sakit: Studi Implementasi Kaidah Bioetik Autonomi. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 160–167.

<https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.373>

Maria, K., Widuri, & Islamarida, R. (2024). Peran Keluarga Sebagai Caregiver Pada Pasien Stroke: Studi Literatur. *Jurnal Keperawatan*, 14(1), 1–8.

Merschel, M. (2023). *What is shared decision-making, and how can it help patients*. American Heart Association News.

Mori, M., Lin, C.-P., Cheng, S.-Y., Suh, S.-Y., Takenouchi, S., Ng, R., Chan, H., Kim, S.-H., Chen, P.-J., Yuen, K. K., Fujimori, M., Yamaguchi, T., Hamano, J., Kizawa, Y., Morita, T., & Martina, D. (2023). Communication in Cancer Care in Asia: A Narrative Review. *JCO Global Oncology*, 9, 1–10. <https://doi.org/10.1200/go.22.00266>

Mujiyono. (2019). *Promosi Kesehatan* (Issue 6).

Nurhayati, Ezalina, Putri, V. D., & Hendra, D. (2026). Hubungan Peran Keluarga sebagai Caregiver dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 8(1), 371–376.

Nutbeam, D., & Lloyd, J. E. (2021). Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health. *Annual Review of Public Health*, 42, 159–173. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529>

Organization, W. H. (2018). *Continuity and coordination of care: a practice*.

Quality, A. for H. R. and. (2022). *National Healthcare Quality and Disparities Report*. National Library of Medicine. <https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/research/findings/nhqdrdr/2022-qdr-final-es.pdf>

Rahmi, D., Rikayoni, & Febristi, A. (2025). Study Fenomenologi terhadap Pengalaman Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga dengan Gangguan Jiwa di Rumah. *Nan Tongga Health and Nursing*, 20(1), 11–22.

Siebinga, V. Y., Driever, E. M., Stiggelbout, A. M., & Brand, P. L. P. (2022). Shared decision making, patient-centered communication and patient satisfaction – A cross-sectional analysis. *Patient Education and Counseling*, 105(7), 2145–2150. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.03.012>

Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2009). How does communication heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes. *Patient Education and Counseling*, 74(3), 295–301. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2008.11.015>

Taylor, S. E., & Stanton, A. A. (2020). *Health Psychology*.

- Vick, J. B., Berger, B. T., Ubel, P. A., Cox, C. E., You, H. Bin, Ma, J. E., Haverfield, M. C., Hammill, B. G., Carson, S. S., Hough, C. L., White, D. B., & Ashana, D. C. (2024). Shared Decision-Making Communication and Prognostic Misunderstanding in the ICU. *JAMA Network Open*, 7(10), e2439715. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.39715>
- Wehking, F., Debrouwere, M., Danner, M., Geiger, F., Buenzen, C., Lewejohann, J. C., & Scheibler, F. (2024). Impact of shared decision making on healthcare in recent literature: a scoping review using a novel taxonomy. *Journal of Public Health (Germany)*, 32(12), 2255–2266. <https://doi.org/10.1007/s10389-023-01962-w>
- WHO. (2021). *Annual Report 2021*. <https://doi.org/10.3934/microbiol.2022009>
- World Health Organization. (2018). *Integrating palliative care and symptom relief into primary health care*.
- World Health Organization. (2020). *Mental health and psychosocial support aspects of the COVID-19 response* (pp. 1–4). <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331927/Mental-health-COVID-19-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- World Health Organization. (2022). *Achieving well-being: A global framework for integrating well being into public health*.
- World Health Organization. (2023). *Global Report on Diabetes*. *Isbn*, 978, 88. <https://doi.org/ISBN 978 92 4 156525 7>
- Yen, P. H., & Leasure, A. R. (2019). Use and Effectiveness of the Teach-Back Method in Patient Education and Health Outcomes. *Federal Practitioner: For the Health Care Professionals of the VA, DoD, and PHS*, 36(6), 284–289. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31258322><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC6590951>
- Yu, T. H., Wei, C. J., Wu, W. W., & Lu, F. L. (2024). Does the role of family meetings important at the end-of-life? A retrospective national study in Taiwan. *BMC Palliative Care*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01613-1>
- Zhang, J., Li, Y., Yu, H., Gong, S., & Fei, Y. (2025). Advances in research on palliative care and family meeting: a bibliometric study from 2004 to 2024. *Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s43088-025-00698-8>

BAB VI

KOMUNIKASI KOLABORATIF ANTARPROFESI DAN KESELAMATAN PASIEN (SBAR, HANDOVER, KOMUNIKASI KRITIS, DAN PENCEGAHAN MISKOMUNIKASI)

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan modern berkembang dalam sistem yang semakin kompleks dan terintegrasi. Kompleksitas ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien dengan kondisi multimorbiditas, penggunaan teknologi kesehatan yang semakin canggih, serta keterlibatan berbagai profesi kesehatan dalam satu rangkaian pelayanan. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan tidak lagi bersifat individual, melainkan berbasis tim multidisiplin yang membutuhkan komunikasi yang jelas, akurat, dan berkesinambungan (Reeves et al., 2010).

Kompleksitas sistem pelayanan kesehatan tersebut menghadirkan berbagai tantangan, khususnya pada titik-titik transisi pelayanan seperti pergantian shift, perpindahan pasien antar unit, dan koordinasi antarprofesi. Pada situasi ini, potensi terjadinya kesalahan meningkat, terutama jika komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Laporan global menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien, termasuk kejadian sentinel yang berdampak serius terhadap pasien (Slawomirski & Klazinga, 2022; World Health Organization, 2021b).

Dalam kerangka patient safety, komunikasi berperan sebagai determinan utama dalam menjamin kesinambungan informasi dan ketepatan tindakan klinis. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi informasi, keterlambatan pengambilan keputusan, hingga kesalahan dalam pemberian asuhan. Sebaliknya, komunikasi yang terstruktur dan jelas mampu meningkatkan koordinasi tim serta mendukung pengambilan keputusan yang aman dan berbasis bukti (O'Daniel & Rosenstein, 2008).

Perawat memiliki posisi strategis dalam komunikasi kolaboratif antarprofesi. Sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan secara kontinu, perawat berperan sebagai penghubung utama antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga

mencakup klarifikasi, validasi, dan koordinasi tindakan klinis. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perawat yang efektif berkontribusi dalam meningkatkan komunikasi tim dan kolaborasi antarprofesi (Wianti, Warsini, et al., 2025).

Lebih dari itu, komunikasi dalam praktik keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer informasi, tetapi juga sebagai proses terapeutik dalam hubungan profesional. Komunikasi yang dilakukan dengan empati, keterbukaan, dan saling menghargai akan membangun kepercayaan antarprofesi serta meningkatkan kualitas kerja tim. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi terapeutik yang menempatkan hubungan interpersonal sebagai inti dari praktik keperawatan (Boggs, 2023).

Untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam praktik klinis, berbagai pendekatan komunikasi terstandar telah dikembangkan. Salah satu model yang широко digunakan adalah SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), yang membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara sistematis dan terstruktur. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SBAR berhubungan signifikan dengan peningkatan kualitas handover dalam praktik keperawatan (Handoyo et al., 2022)

Selain SBAR, proses handover atau serah terima pasien merupakan komponen penting dalam menjaga kesinambungan asuhan. Handover yang tidak efektif dapat menyebabkan kehilangan informasi penting dan meningkatkan risiko kesalahan klinis. Oleh karena itu, standarisasi komunikasi dalam proses handover menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan keselamatan pasien (Jimmerson et al., 2020).

Dalam situasi klinis berisiko tinggi, seperti kondisi kegawatdaruratan atau perawatan intensif, komunikasi menjadi semakin krusial. Tekanan waktu, kompleksitas kasus, serta tingginya beban kerja menuntut tenaga kesehatan untuk mampu berkomunikasi secara cepat dan tepat. Kegagalan komunikasi dalam situasi ini dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien (Valdivia de la Fuente et al., 2025).

Miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal, nonverbal, maupun dokumentasi klinis. Faktor penyebabnya melibatkan aspek individu, tim, dan sistem. Pendekatan human factors menekankan bahwa kesalahan komunikasi bukan hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh kegagalan sistem yang lebih luas (Carayon et al., 2014). Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif juga berkontribusi terhadap kejadian needlestick injury pada perawat (Wijayanti et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dalam pelayanan kesehatan juga mengalami transformasi. Sistem informasi kesehatan, rekam medis elektronik, telehealth, serta pemanfaatan kecerdasan buatan mulai digunakan untuk mendukung komunikasi dan koordinasi tim. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan yang berpotensi meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi antarprofesi, meskipun masih terdapat kesenjangan bukti empiris dalam implementasinya (Wianti, Wijayanti, et al., 2025) .

Berdasarkan uraian tersebut, komunikasi kolaboratif antarprofesi merupakan kompetensi esensial dalam praktik keperawatan modern. Komunikasi tidak hanya berperan sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses terapeutik yang membentuk hubungan profesional dan mendukung keselamatan pasien.

Bab ini akan membahas secara komprehensif komunikasi kolaboratif antarprofesi dalam konteks keselamatan pasien, meliputi konsep dasar komunikasi, penerapan SBAR, proses handover, komunikasi dalam situasi kritis, analisis miskomunikasi, serta strategi pencegahan dan transformasi komunikasi di era digital.

B. Landasan Teoretis Komunikasi Kolaboratif Antarprofesi

1. Konsep dan Definisi Komunikasi Antarprofesi

a. Definisi komunikasi kolaboratif

Pelayanan kesehatan modern menuntut integrasi berbagai profesi dalam satu sistem yang kompleks dan berisiko tinggi. Komunikasi kolaboratif antarprofesi dipahami sebagai proses pertukaran informasi yang terstruktur antara tenaga kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang aman dan efektif. Komunikasi tersebut mencakup penyampaian informasi, klarifikasi, serta penyamaan persepsi dalam tim pelayanan kesehatan (Pazar et al., 2024; Reime et al., 2024).

Studi terbaru menunjukkan bahwa komunikasi antarprofesi merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan, karena kegagalan komunikasi masih menjadi penyebab utama kejadian tidak diinginkan di fasilitas kesehatan (Pazar et al., 2024) .Selain itu, komunikasi kolaboratif mencakup interaksi verbal, nonverbal, serta dokumentasi yang saling melengkapi dalam menjaga kesinambungan asuhan. Secara konseptual, komunikasi ini juga dipahami sebagai proses sistemik yang melibatkan pertukaran makna, negosiasi peran, dan koordinasi tindakan dalam tim multidisiplin (Rudberg et al., 2026). Dengan demikian, komunikasi

kolaboratif tidak hanya merupakan keterampilan individu, tetapi juga kompetensi kolektif yang terbentuk dalam sistem pelayanan kesehatan.

b. Komunikasi sebagai proses relasional dan terapeutik dalam praktik keperawatan

Praktik keperawatan menempatkan komunikasi sebagai proses relasional yang memiliki dimensi terapeutik dalam setiap interaksi profesional. Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi yang digunakan secara sadar oleh perawat untuk membangun hubungan saling percaya, memahami kebutuhan pasien, serta mendukung proses penyembuhan secara holistik (Jojan & Carroll, 2025). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik berperan langsung dalam meningkatkan kualitas asuhan dan kepuasan pasien melalui hubungan interpersonal yang efektif (Mersha et al., 2023) .

Komunikasi sebagai proses relasional menekankan pentingnya kualitas hubungan antarindividu dalam pelayanan kesehatan. Hubungan yang dibangun melalui empati, keterbukaan, dan kepercayaan terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi klinis serta memperkuat hubungan perawat–pasien (Högländer et al., 2023) . Penelitian lain menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berhubungan dengan peningkatan perilaku caring dan kualitas interaksi terapeutik dalam praktik keperawatan (Rohayati et al., 2024). Perawat memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi relasional dalam tim kesehatan. Posisi perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien memungkinkan perawat menjadi penghubung utama dalam pertukaran informasi klinis(Reeves et al., 2010b). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan keterampilan komunikasi terapeutik perawat sangat menentukan kualitas interaksi klinis dan keselamatan pasien (Moykari et al., 2023) .

Komunikasi terapeutik juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kohesi tim. Lingkungan kerja yang didukung komunikasi terbuka dan empatik terbukti meningkatkan kepercayaan antar anggota tim serta memperkuat kolaborasi profesional (Foronda et al., 2016). Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa hambatan komunikasi terapeutik dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan hubungan profesional dalam tim kesehatan (Abraham et al., 2024) .

Dimensi terapeutik dalam komunikasi tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga pada tenaga kesehatan. Komunikasi yang efektif dan suportif dapat menurunkan stres kerja serta meningkatkan kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan (McCabe & Timmins, 2013). Penelitian terbaru menegaskan bahwa

komunikasi yang baik dalam tim kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan (Siokal et al., 2023) .

Perbedaan latar belakang profesi dan budaya organisasi sering menjadi tantangan dalam komunikasi relasional antarprofesi. Variasi nilai, persepsi, dan gaya komunikasi dapat menghambat efektivitas interaksi dalam tim kesehatan (Reeves et al., 2010a). Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi berbasis budaya dan empati dapat meningkatkan efektivitas komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan (Lestari et al., 2023).

Perkembangan teknologi kesehatan turut mempengaruhi dinamika komunikasi relasional dalam praktik keperawatan. Penggunaan teknologi digital dalam komunikasi klinis dapat meningkatkan efisiensi pertukaran informasi, tetapi berpotensi mengurangi kedalaman hubungan interpersonal jika tidak diimbangi pendekatan humanistik (De Micco et al., 2025). Penelitian terbaru juga menekankan bahwa keterampilan komunikasi tetap menjadi inti dalam praktik keperawatan meskipun teknologi terus berkembang (Arda & Suprpto, 2023) .

Komunikasi sebagai proses relasional dan terapeutik merupakan fondasi penting dalam praktik keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Komunikasi yang efektif tidak hanya memastikan akurasi informasi, tetapi juga membangun hubungan profesional yang mendukung kerja tim dan kualitas pelayanan (Arnold & Boggs, 2018). Bukti terkini menegaskan bahwa komunikasi terapeutik merupakan komponen kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien (Abraham et al., 2024).

c. Ruang lingkup komunikasi dalam pelayanan kesehatan

Ruang lingkup komunikasi dalam pelayanan kesehatan mencakup seluruh proses pertukaran informasi yang terjadi dalam sistem pelayanan yang kompleks dan multidisiplin. Interaksi tersebut melibatkan tenaga kesehatan, pasien, keluarga, serta sistem pendukung yang saling terintegrasi dalam upaya pemberian asuhan yang aman dan berkualitas. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, dan kesinambungan pelayanan (Mersha et al., 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kompleksitas layanan kesehatan modern menuntut komunikasi yang sistematis dan terstruktur untuk meminimalkan risiko kesalahan klinis (Grant et al., 2025)

Komunikasi dalam praktik klinis terdiri atas komunikasi verbal, nonverbal, dan tertulis yang saling melengkapi dalam proses pelayanan. Komunikasi verbal digunakan dalam diskusi klinis, konsultasi, dan koordinasi antar tenaga

kesehatan. Komunikasi nonverbal memberikan makna tambahan melalui ekspresi, bahasa tubuh, dan sikap profesional dalam interaksi pasien. Dokumentasi klinis sebagai bentuk komunikasi tertulis memiliki peran penting dalam menjamin akurasi informasi dan kesinambungan asuhan (Höglander et al., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas komunikasi verbal dan nonverbal secara signifikan mempengaruhi pengalaman pasien dan hasil pelayanan kesehatan (Abraham et al., 2024).

Ruang lingkup komunikasi juga mencakup komunikasi antarprofesi sebagai inti dari praktik kolaboratif dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi antarprofesi melibatkan pertukaran informasi yang terstruktur antara berbagai tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis. Proses ini membutuhkan kejelasan, ketepatan, serta kesamaan pemahaman untuk menghindari miskomunikasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien (Grant et al., 2025). Studi terkini menunjukkan bahwa komunikasi antarprofesi yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penurunan kejadian tidak diharapkan (Moykari et al., 2023).

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan juga mencakup proses handover yang merupakan bagian penting dari kesinambungan asuhan pasien. Handover melibatkan transfer informasi klinis yang terjadi antar tenaga kesehatan dalam pergantian shift atau perpindahan unit pelayanan. Proses ini membutuhkan komunikasi yang jelas, lengkap, dan terstruktur untuk mencegah kehilangan informasi penting (Abraham et al., 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dalam handover merupakan salah satu penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (Mersha et al., 2023).

Perkembangan teknologi kesehatan memperluas ruang lingkup komunikasi melalui pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan klinis. Penggunaan rekam medis elektronik, telehealth, dan platform komunikasi digital memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Teknologi tersebut meningkatkan aksesibilitas informasi, namun juga menuntut kemampuan adaptasi tenaga kesehatan dalam menjaga kualitas komunikasi (De Micco et al., 2025). Studi terkini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi harus tetap mempertahankan aspek empati dan hubungan terapeutik agar tidak menurunkan kualitas interaksi klinis (Arda & Suprpto, 2023).

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan juga berperan dalam mendukung keselamatan tenaga kesehatan. Komunikasi yang tidak efektif dapat meningkatkan risiko kesalahan prosedur, cedera kerja, serta kejadian tidak diharapkan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan

terstandarisasi mampu meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko insiden (Moykari et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa komunikasi merupakan bagian integral dari sistem keselamatan secara menyeluruh.

Pendekatan human factors dalam keselamatan pasien menempatkan komunikasi sebagai bagian dari sistem yang harus dirancang secara optimal. Sistem komunikasi yang baik akan mendukung kinerja tenaga kesehatan dan meminimalkan kesalahan akibat faktor manusia dalam pelayanan klinis (De Micco et al., 2025). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi komunikasi dalam sistem pelayanan kesehatan menjadi faktor kunci dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Grant et al., 2025)

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek klinis, relasional, dan sistemik. Komunikasi yang efektif tidak hanya memastikan keakuratan informasi, tetapi juga membangun hubungan profesional dan mendukung kerja tim yang kolaboratif. Pendekatan komunikasi yang terstruktur dan berbasis kolaborasi terbukti menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan modern (Abraham et al., 2024).

2. Model dan Teori Kolaborasi Tim Kesehatan

a. Konsep *Interprofessional Collaboration*

Interprofessional Collaboration (IPC) merupakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi untuk bekerja secara terpadu dalam memberikan asuhan kepada pasien. IPC menekankan kerja sama yang terkoordinasi, komunikasi efektif, serta pembagian peran yang jelas antar tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan pelayanan yang optimal (Morgan et al., 2015; Reeves et al., 2010). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi dalam praktik keperawatan menjadi elemen kunci dalam membangun kolaborasi antarprofesi yang efektif dan berkelanjutan (Grant et al., 2025).

IPC tidak hanya berfokus pada kerja bersama, tetapi juga pada proses interaksi dinamis antarprofesi. Setiap profesi memiliki perspektif dan kompetensi yang berbeda sehingga membutuhkan komunikasi yang mampu menyatukan perbedaan tersebut dalam pengambilan keputusan klinis (Moykari et al., 2023). Studi terkini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antarprofesi berhubungan langsung dengan efektivitas kolaborasi dan keselamatan pasien (Abraham et al., 2024; Morgan et al., 2015).

Konsep IPC juga menekankan pentingnya pendekatan patient-centered care sebagai dasar dalam kolaborasi. Pelayanan yang berfokus pada pasien memerlukan integrasi berbagai perspektif klinis dalam satu kesatuan

keputusan yang komprehensif (Grant et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kolaboratif berbasis pasien meningkatkan kualitas hasil klinis dan kepuasan pasien (Jiang et al., 2024; Mersha et al., 2023).

Implementasi IPC memerlukan dukungan sistem organisasi yang kondusif. Budaya organisasi yang terbuka terhadap komunikasi dan kolaborasi akan memperkuat praktik kerja tim dalam pelayanan kesehatan (De Micco et al., 2025). Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi komunikasi dalam sistem digital juga berperan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi antarprofesi (Grant et al., 2025; Marino et al., 2023).

b. Dinamika kerja tim dan koordinasi klinis

Dinamika kerja tim mencerminkan pola interaksi antar anggota tim dalam menjalankan tugas klinis secara kolaboratif. Tim kesehatan terdiri dari berbagai profesi dengan latar belakang berbeda sehingga memerlukan koordinasi yang efektif untuk memastikan kesinambungan pelayanan (Reeves et al., 2010a). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kinerja tim kesehatan (Grant et al., 2025; Rosen et al., 2018)

Koordinasi klinis merupakan proses penyelarasan tindakan antar anggota tim dalam memberikan asuhan kepada pasien. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pasien (Moykari et al., 2023). Bukti empiris menunjukkan bahwa kegagalan koordinasi seringkali berakar pada miskomunikasi yang terjadi dalam tim kesehatan (Abraham et al., 2024; Rosen et al., 2018)

Dinamika kerja tim juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepercayaan, kepemimpinan, dan kohesi tim. Kepercayaan antar anggota tim meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi serta mempermudah pengambilan keputusan klinis (Grant et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa tim dengan kohesi yang baik memiliki kemampuan koordinasi yang lebih efektif dalam pelayanan kesehatan ((Mersha et al., 2023; Rosen et al., 2018).

Tekanan kerja dan kompleksitas sistem pelayanan dapat mempengaruhi dinamika tim dan kualitas komunikasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan jika tidak diimbangi dengan sistem komunikasi yang baik (De Micco et al., 2025). Studi terbaru menunjukkan bahwa penguatan komunikasi tim melalui pelatihan dan standarisasi dapat meningkatkan koordinasi klinis dan keselamatan pasien (Grant et al., 2025; Reeves et al., 2010a)

c. Komunikasi sebagai fondasi hubungan profesional

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan profesional dalam pelayanan kesehatan. Hubungan profesional terbentuk melalui interaksi yang didasarkan pada kepercayaan, saling menghargai, dan keterbukaan antar tenaga kesehatan (Reeves et al., 2010a). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi keperawatan memiliki peran strategis dalam membentuk hubungan profesional yang mendukung keselamatan pasien (Grant et al., 2025; Jiang et al., 2024).

Hubungan profesional tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek relasional seperti empati dan pemahaman antar individu. Komunikasi empatik memungkinkan tenaga kesehatan memahami perspektif rekan kerja dan pasien secara lebih komprehensif (Höglander et al., 2023). Bukti empiris menunjukkan bahwa komunikasi yang empatik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman pasien (Abraham et al., 2024). Komunikasi juga berperan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien. Lingkungan kerja yang mendorong komunikasi terbuka akan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi kesalahan (Grant et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa budaya komunikasi yang kuat berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Jiang et al., 2024; Mersha et al., 2023).

Perkembangan teknologi kesehatan menghadirkan tantangan dalam mempertahankan kualitas hubungan profesional. Komunikasi digital dapat meningkatkan efisiensi, tetapi berpotensi mengurangi kedalaman interaksi interpersonal jika tidak dikelola dengan baik (De Micco et al., 2025). Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam komunikasi harus tetap mempertahankan nilai empati dan profesionalisme dalam praktik keperawatan (Arda & Suprpto, 2023; Marino et al., 2023).

Komunikasi sebagai fondasi hubungan profesional menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis, tetapi juga oleh kualitas interaksi antar tenaga kesehatan. Komunikasi yang efektif akan memperkuat kolaborasi tim dan meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan (Grant et al., 2025).

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi

a. Hierarki profesi

Hierarki profesi merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Struktur organisasi yang bersifat hierarkis menempatkan profesi tertentu pada posisi dominan sehingga

membatasi keterbukaan komunikasi antar anggota tim, terutama dalam situasi klinis yang kompleks (Grant et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan tenaga kesehatan dengan posisi lebih rendah cenderung menahan informasi penting yang berkaitan dengan kondisi pasien, sehingga meningkatkan risiko miskomunikasi dan berdampak pada keselamatan pasien (Jiang et al., 2024; World Health Organization, 2021).

Hierarki profesi juga mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam tim kesehatan. Dominasi profesi tertentu dalam proses klinis dapat menghambat kontribusi anggota tim lainnya, sehingga informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan menjadi tidak komprehensif (Grant et al., 2025). Keterbatasan komunikasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan dan berpotensi menurunkan keselamatan pasien apabila tidak didukung oleh sistem komunikasi yang terbuka dan kolaboratif (Howick et al., 2024).

Hubungan antara hierarki dan komunikasi menunjukkan bahwa semakin kaku struktur organisasi, semakin rendah tingkat keterbukaan komunikasi dalam tim kesehatan. Pendekatan sistem keselamatan pasien menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan partisipatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2021a). Upaya ini memungkinkan setiap anggota tim memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan informasi klinis secara tepat dan akurat (Jiang et al., 2024).

b. Budaya organisasi

Budaya organisasi memegang peranan penting dalam membentuk pola komunikasi dalam pelayanan kesehatan melalui nilai, norma, dan praktik yang berlaku dalam institusi. Organisasi yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi efektif antar tenaga kesehatan (Grant et al., 2025). Lingkungan tersebut memungkinkan pertukaran informasi yang lebih jujur dan akurat sehingga meningkatkan kualitas kolaborasi dalam tim (Jiang et al., 2024).

Budaya keselamatan (safety culture) menjadi elemen kunci dalam organisasi kesehatan karena menekankan pentingnya komunikasi terbuka, pelaporan insiden, serta pembelajaran dari kesalahan yang terjadi dalam praktik klinis (World Health Organization, 2021). Organisasi dengan budaya keselamatan yang kuat terbukti memiliki kualitas komunikasi yang lebih baik dan risiko insiden yang lebih rendah dibandingkan organisasi dengan budaya yang lemah (Howick et al., 2024).

Nilai organisasi yang menekankan kerja sama dan saling menghargai akan memperkuat hubungan profesional dalam tim kesehatan. Interaksi yang positif

antar tenaga kesehatan meningkatkan kualitas komunikasi dan memperkuat koordinasi dalam pelayanan pasien (Grant et al., 2025). Budaya organisasi yang suportif juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja tim dan keselamatan pasien secara keseluruhan (Jiang et al., 2024).

c. Beban kerja tekanan sistem

Beban kerja yang tinggi merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi kualitas komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kondisi kelelahan fisik dan mental akibat beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menyampaikan dan menerima informasi secara akurat (Grant et al., 2025). Perspektif human factors menunjukkan bahwa kelelahan dan tekanan kerja merupakan bagian dari sistem yang dapat mempengaruhi performa komunikasi dan meningkatkan risiko kesalahan klinis (Carayon et al., 2014).

Tekanan sistem seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompleksitas pelayanan memperburuk efektivitas komunikasi dalam tim kesehatan. Tenaga kesehatan sering kali harus mengambil keputusan secara cepat dalam kondisi yang penuh tekanan sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan interpretasi informasi (Howick et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak optimal merupakan bagian dari kegagalan sistem yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2021b).

Beban kerja yang tinggi juga dapat mengurangi kualitas interaksi interpersonal dalam tim kesehatan. Fokus pada penyelesaian tugas menyebabkan komunikasi menjadi lebih singkat dan kurang mendalam, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hubungan profesional (Grant et al., 2025). Pengelolaan beban kerja yang efektif sebagai bagian dari pendekatan sistem diperlukan untuk menjaga efektivitas komunikasi dan kualitas pelayanan kesehatan (Carayon et al., 2014).

d. Dimensi psikologis dan empati dalam komunikasi

Dimensi psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kondisi emosional, tingkat stres, serta beban kognitif tenaga kesehatan mempengaruhi cara individu dalam memproses dan menyampaikan informasi (Grant et al., 2025). Perspektif human factors menegaskan bahwa faktor psikologis merupakan bagian dari sistem kerja yang dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan keselamatan pasien (Carayon et al., 2014).

Empati merupakan komponen penting dalam komunikasi yang berperan dalam membangun hubungan profesional dan terapeutik. Kemampuan memahami perspektif pasien dan rekan kerja memungkinkan terciptanya

komunikasi yang lebih efektif dan bermakna dalam pelayanan kesehatan (Grant et al., 2025). Komunikasi yang empatik juga berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien melalui penyampaian informasi yang lebih jelas, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Howick et al., 2024).

Dimensi psikologis juga mempengaruhi dinamika komunikasi dalam tim kesehatan melalui faktor kepercayaan diri dan persepsi interpersonal. Individu dengan kepercayaan diri rendah cenderung kurang aktif dalam komunikasi, sedangkan dominasi individu tertentu dapat menghambat partisipasi anggota tim lainnya (Jiang et al., 2024). Kondisi ini mempengaruhi keseimbangan komunikasi dalam tim dan berdampak pada efektivitas kolaborasi dalam pelayanan kesehatan (Grant et al., 2025).

Empati dalam komunikasi antar tenaga kesehatan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung kolaborasi tim. Pendekatan yang menempatkan komunikasi sebagai bagian dari sistem keselamatan pasien menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang saling menghargai dan mendukung (World Health Organization, 2021b). Penguatan empati sebagai bagian dari kompetensi komunikasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan (Carayon et al., 2014).

C. SBAR sebagai model standarisasi komunikasi klinis

1. Konsep dan Komponen SBAR

a. Pengertian *SBAR Communication*

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) merupakan model komunikasi terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan kejelasan, ketepatan, dan efisiensi pertukaran informasi dalam pelayanan kesehatan. Model ini diadaptasi dari praktik komunikasi pada industri berisiko tinggi dan kemudian diimplementasikan dalam konteks klinis untuk mengurangi kesalahan komunikasi yang berdampak pada keselamatan pasien (Fliegenschmidt et al., 2023). Dalam praktik modern, SBAR menjadi pendekatan yang direkomendasikan untuk menstandarkan komunikasi antar tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan (Institute for Healthcare Improvement, 2021).

SBAR membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi klinis secara sistematis, ringkas, dan terarah. Struktur ini meminimalkan kehilangan informasi penting serta mengurangi ambiguitas dalam komunikasi klinis (Kosim & Saimi, 2025; Mathal et al., 2025). Penggunaan SBAR terbukti meningkatkan kualitas komunikasi dan memperkuat keselamatan pasien

melalui penyampaian informasi yang konsisten dan mudah dipahami (Kosim & Saimi, 2025; Shinta & Bunga, 2024). Temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi SBAR berkontribusi pada penurunan kesalahan komunikasi serta peningkatan budaya keselamatan dalam organisasi pelayanan kesehatan (Shinta & Bunga, 2024).

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, penggunaan SBAR juga menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis tenaga kesehatan serta efisiensi komunikasi dalam praktik klinis (Ainun Shafira & Dhamanti, 2023). Penerapan SBAR pada proses handover terbukti meningkatkan kualitas transfer informasi pasien dan mengurangi potensi kesalahan dalam kesinambungan asuhan (Handoyo et al., 2022).

SBAR tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari proses kognitif dalam pengambilan keputusan klinis. Tenaga kesehatan didorong untuk menyusun informasi berdasarkan prioritas klinis sebelum menyampaikannya kepada tim (Jiang et al., 2024). Pendekatan ini memperkuat komunikasi sebagai bagian dari sistem keselamatan pasien yang berorientasi pada pencegahan kesalahan (World Health Organization, 2021).

b. Struktur SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Struktur SBAR terdiri dari empat komponen utama yang membentuk alur komunikasi klinis yang sistematis. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan lengkap, jelas, dan dapat ditindaklanjuti.

Situation (S) menggambarkan kondisi terkini pasien secara singkat dan spesifik. Penyampaian situasi yang jelas membantu penerima informasi memahami urgensi masalah klinis secara cepat dan tepat (Fliegenschmidt et al., 2023). Kejelasan informasi pada tahap ini berperan dalam mempercepat respon klinis dan mengurangi risiko kesalahan interpretasi (Howick et al., 2024).

Background (B) berisi informasi pendukung yang relevan, seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, serta intervensi yang telah dilakukan. Informasi ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh (Müller et al., 2018). Penyampaian latar belakang yang terstruktur membantu meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan klinis (Jiang et al., 2024).

Assessment (A) merupakan hasil penilaian klinis tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien berdasarkan data yang tersedia. Tahap ini mencerminkan kemampuan analisis dan penalaran klinis dalam mengidentifikasi masalah pasien (Grant et al., 2025). Proses ini menunjukkan bahwa SBAR tidak hanya

bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mendukung keputusan klinis (Howick et al., 2024).

Recommendation (R) berisi saran atau tindakan yang direkomendasikan untuk menangani kondisi pasien. Penyampaian rekomendasi yang jelas dan spesifik meningkatkan koordinasi tim dan mempercepat pengambilan keputusan klinis (World Health Organization, 2021b). Secara keseluruhan, kerangka kerja SBAR adalah alat yang berharga dalam mengurangi variabilitas komunikasi, meningkatkan keselamatan pasien, dan meningkatkan kualitas pemberian layanan kesehatan (Kosim & Saimi, 2025; Pazar et al., 2024).

c. SBAR sebagai pendekatan sistematis dalam komunikasi klinis

SBAR merupakan pendekatan sistematis dalam komunikasi klinis yang menyediakan kerangka kerja terstandarisasi dalam penyampaian informasi. Standarisasi ini penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks, di mana variasi komunikasi dapat menjadi sumber kesalahan klinis (World Health Organization, 2021b). Penggunaan SBAR membantu mengurangi variasi tersebut dengan menyediakan format komunikasi yang konsisten (Jiang et al., 2024).

Pendekatan SBAR juga mendukung prinsip human factors dalam keselamatan pasien. Struktur komunikasi yang jelas membantu mengurangi beban kognitif tenaga kesehatan, terutama dalam situasi dengan tekanan tinggi dan beban kerja yang besar (Binaj et al., 2025). Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi secara lebih efisien dan akurat (Grant et al., 2025).

Pengembangan kompetensi komunikasi melalui pelatihan berbasis SBAR juga menunjukkan hasil yang positif. Program simulasi berbasis SBAR terbukti meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi antarprofesi, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi klinis (Yun et al., 2023). Dengan demikian, SBAR tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi klinis.

2. Implementasi SBAR dalam Praktik Klinis

a. Aplikasi dalam komunikasi antarprofesi

SBAR digunakan secara luas dalam komunikasi antarprofesi untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi antar tenaga kesehatan. Komunikasi yang terstruktur membantu mengurangi perbedaan persepsi dan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan klinis (Grant et al., 2025). Penggunaan SBAR memungkinkan setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi pasien (Howick et al., 2024).

Efektivitas komunikasi antarprofesi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan dalam tim kesehatan. Kepemimpinan transformasional dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan komunikasi, memperkuat kolaborasi tim, serta menurunkan kesalahan medis melalui keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis (Wianti, Warsini, et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SBAR akan lebih optimal apabila didukung oleh kepemimpinan yang mendorong komunikasi terbuka dan kolaboratif. Perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi dalam komunikasi antarprofesi. Pemanfaatan kecerdasan buatan berbasis chatbot menunjukkan potensi dalam membantu menyelesaikan konflik komunikasi serta meningkatkan koordinasi dalam pelayanan pasien dengan kondisi kompleks (Wianti, Warsini, et al., 2025). Integrasi teknologi ini memperluas peran komunikasi dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

b. Integrasi SBAR dalam alur pelayanan klinis

Integrasi SBAR dalam alur pelayanan klinis bertujuan untuk memastikan komunikasi yang konsisten dan terstandarisasi dalam setiap tahap pelayanan. SBAR dapat digunakan dalam berbagai situasi klinis, termasuk handover, konsultasi, dan kondisi darurat (Hassan Elmi, 2025; Institute for Healthcare Improvement, 2021). Penggunaan SBAR dalam handover terbukti meningkatkan kualitas komunikasi dan mengurangi risiko kesalahan dalam transfer informasi pasien (Handoyo et al., 2022; Waqar khan et al., 2025).

Integrasi SBAR dengan sistem informasi kesehatan, seperti Electronic Health Records, memungkinkan dokumentasi komunikasi yang lebih sistematis dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan (Alnaji & Alkhaldi, 2024; Campisi et al., 2024; Wianti, Warsini, et al., 2025). Pendekatan ini meningkatkan akurasi informasi serta mendukung kesinambungan asuhan pasien.

Pendekatan sistem dalam implementasi SBAR menekankan bahwa komunikasi merupakan bagian integral dari keselamatan pasien. Sistem yang mendukung komunikasi terstruktur terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan risiko kesalahan klinis (Kosim & Saimi, 2025; Soed et al., 2025; World Health Organization, 2021b). Hal ini menunjukkan bahwa SBAR merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

c. Peran komunikasi terapeutik dalam penyampaian SBAR

Komunikasi terapeutik berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan SBAR dalam praktik klinis. Penyampaian SBAR yang tidak memperhatikan aspek relasional berpotensi menjadi komunikasi yang kaku dan kurang efektif. Integrasi komunikasi terapeutik memungkinkan penyampaian informasi dilakukan dengan empati, kejelasan, dan sensitivitas

terhadap kondisi pasien maupun tim kesehatan (Grant et al., 2025; Khalid & Lani, 2024).

Hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghargai mendukung efektivitas komunikasi dalam tim kesehatan (Howick et al., 2024). Komunikasi yang empatik membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh anggota tim (Jiang et al., 2024).

Aspek keselamatan pasien juga berkaitan dengan kualitas komunikasi interpersonal. Pengetahuan tenaga kesehatan terhadap risiko, seperti kejadian *needlestick injury*, menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berperan dalam pencegahan insiden keselamatan kerja dan pasien (Wijayanti et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa komunikasi memiliki dampak luas, tidak hanya pada koordinasi klinis, tetapi juga pada keselamatan tenaga kesehatan.

3. Evidence Efektivitas SBAR

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) telah diakui secara luas sebagai alat komunikasi terstruktur yang efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi klinis, khususnya dalam proses serah terima keperawatan dan komunikasi antarprofesi. Penggunaan SBAR memungkinkan tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara sistematis, sehingga meningkatkan kejelasan komunikasi, mengurangi ambiguitas, dan meminimalkan kesalahan dalam pertukaran informasi klinis (Yun et al., 2023). Struktur komunikasi yang jelas juga membantu tenaga kesehatan dalam mengorganisasi informasi berdasarkan prioritas klinis, sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SBAR secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kualitas komunikasi dalam praktik klinis. Tinjauan pelingkupan menunjukkan bahwa SBAR secara signifikan meningkatkan kejelasan komunikasi, mengurangi kesalahan dalam proses *handover*, serta memperkuat kerja tim di antara tenaga kesehatan (Soed et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan tinjauan literatur yang menyatakan bahwa SBAR mampu meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi, mengurangi miskomunikasi, serta meningkatkan kepuasan pasien, terutama pada setting dengan kompleksitas tinggi seperti perawatan bedah dan paliatif (Fadilah & Hidayat, 2024). Studi kuasi-eksperimental juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas *handover* perawat setelah implementasi SBAR, yang ditandai dengan peningkatan skor komunikasi pasca intervensi (Hidayat & Fadilah, 2024).

Peningkatan kualitas komunikasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan pasien. Komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan global ((World Health Organization, 2021b). Implementasi SBAR membantu memastikan bahwa informasi klinis disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih aman. Studi cross-sectional menunjukkan adanya hubungan signifikan antara komunikasi SBAR yang efektif dengan peningkatan keselamatan pasien, yang menegaskan pentingnya penerapan SBAR secara konsisten dalam praktik klinis (Gultom & Karlina, 2025). Selain itu, tinjauan sistematis yang membandingkan SBAR dengan kerangka komunikasi lainnya menunjukkan bahwa SBAR sangat efektif dalam meningkatkan kejelasan komunikasi serta mengurangi kesalahan dalam proses serah terima, terutama pada setting dengan tingkat ketajaman klinis yang tinggi (Hidalgo Tapia et al., 2025).

Efektivitas SBAR menjadi semakin penting ketika diintegrasikan dalam proses handover sebagai bagian dari kesinambungan asuhan pasien. Handover merupakan titik kritis yang sangat rentan terhadap kehilangan informasi, sehingga membutuhkan komunikasi yang terstruktur dan sistematis. Penggunaan SBAR terbukti meningkatkan kualitas transfer informasi pasien serta mengurangi risiko kesalahan komunikasi selama proses handover (Alizadeh-risani et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Anda yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penggunaan komunikasi SBAR dan kualitas pelaksanaan handover di ruang rawat inap (Handoyo et al., 2022). Integrasi ini menegaskan bahwa SBAR tidak hanya berperan dalam meningkatkan komunikasi, tetapi juga dalam menjaga kontinuitas asuhan (continuity of care) secara optimal.

Selain meningkatkan kualitas komunikasi dan keselamatan pasien, SBAR juga berkontribusi dalam memperkuat koordinasi tim dan aspek kognitif dalam praktik klinis. Struktur SBAR membantu tenaga kesehatan menyusun informasi secara sistematis, sehingga meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Studi di unit perawatan intensif menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam persepsi dan praktik komunikasi setelah pelatihan SBAR, yang ditandai dengan peningkatan penggunaan SBAR secara konsisten dalam praktik keperawatan (Murphy et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa SBAR tidak hanya berdampak pada aspek teknis komunikasi, tetapi juga pada kualitas interaksi profesional dalam tim kesehatan.

Meskipun demikian, implementasi SBAR tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam praktik klinis. Beberapa studi menunjukkan bahwa SBAR terkadang dianggap terlalu kaku dalam situasi darurat serta belum diadopsi

secara konsisten di lingkungan dengan beban kerja tinggi (Fadilah & Hidayat, 2024). Variasi dalam penerapan serta kurangnya pelatihan berkelanjutan dapat menyebabkan SBAR hanya digunakan sebagai formalitas tanpa memberikan dampak optimal terhadap kualitas komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas SBAR sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi, budaya kerja, serta komitmen tenaga kesehatan dalam menerapkan komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, evidence menunjukkan bahwa SBAR merupakan intervensi komunikasi berbasis bukti yang efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi klinis, memperkuat kolaborasi antarprofesi, serta berkontribusi signifikan terhadap keselamatan pasien. Integrasi SBAR dalam praktik klinis, khususnya dalam proses handover, menjadi strategi penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Keterbatasan Implementasi SBAR

a. Hambatan struktural dan budaya

Secara struktural, implementasi SBAR sering terkendala oleh variasi dan kurangnya standardisasi dalam praktik serah terima pasien di berbagai unit pelayanan kesehatan. Ketidakkonsistenan ini membuat penerapan SBAR tidak berjalan seragam antar unit maupun antar institusi. Kondisi ini semakin kompleks pada fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya, di mana kebijakan yang belum kuat dan program pelatihan yang tidak spesifik menyebabkan implementasi SBAR menjadi tidak konsisten (Hassan Elmi, 2025; Yoon & Lee, 2023). Selain itu, hambatan struktural juga berkaitan dengan beban kerja tinggi, keterbatasan waktu, serta interupsi selama proses handover yang sering terjadi dalam praktik klinik sehari-hari (Haliq & AlShammari, 2025; Yari et al., 2026).

Dari aspek budaya organisasi, keberhasilan implementasi SBAR sangat bergantung pada adanya pergeseran budaya menuju komunikasi terstruktur dan orientasi keselamatan pasien. Namun, perubahan ini tidak mudah dicapai karena masih kuatnya praktik kerja yang sudah mengakar serta adanya resistensi terhadap perubahan dalam organisasi layanan kesehatan (Chien et al., 2024; Fliegenschmidt et al., 2023). Dengan demikian, SBAR tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan sistem yang terstandarisasi dan budaya keselamatan pasien yang kuat serta konsisten di seluruh level organisasi.

b. SBAR sebagai formalitas vs praktik nyata

Salah satu keterbatasan utama SBAR adalah kecenderungan implementasinya yang bergeser menjadi formalitas administratif, bukan sebagai alat komunikasi klinis yang bermakna. Dalam beberapa konteks, SBAR hanya digunakan

sebagai checklist untuk memenuhi tuntutan dokumentasi, tanpa keterlibatan kognitif yang mendalam dari tenaga kesehatan (Soed et al., 2025). Fenomena ini menyebabkan SBAR kehilangan esensi utamanya sebagai alat bantu berpikir klinis yang terstruktur. Alih-alih meningkatkan kualitas komunikasi secara substansial, SBAR sering hanya memperbaiki aspek bentuk (format) tanpa menjamin kualitas isi komunikasi klinis.

Selain itu, studi menunjukkan bahwa meskipun pelatihan SBAR dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri tenaga kesehatan, tanpa evaluasi dan penguatan yang berkelanjutan, penerapan SBAR dalam praktik nyata cenderung menurun (Shinta & Bunga, 2024; Shrivastava et al., 2025). Dengan kata lain, SBAR berisiko mengalami “adopsi simbolik”, yaitu diterapkan secara formal tetapi tidak benar-benar digunakan sebagai alat pengambilan keputusan klinis dalam praktik sehari-hari.

c. Kesenjangan antara teori dan praktik

Secara teoritis, SBAR terbukti mampu meningkatkan efektivitas komunikasi klinis, memperjelas alur informasi, serta meningkatkan keselamatan pasien. Hal ini terlihat dari berbagai studi pelatihan yang menunjukkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan self-efficacy tenaga kesehatan setelah implementasi SBAR (Ahmed et al., 2025; Mousaeinejad et al., 2025; Yoon & Lee, 2023).

Namun, dalam praktik klinis sehari-hari, implementasi SBAR sering tidak konsisten. Terdapat kesenjangan nyata antara hasil positif pada setting pelatihan dengan penerapan di lingkungan kerja nyata. Meskipun tingkat kepuasan dan niat penggunaan SBAR tinggi pada fase pelatihan, implementasi aktual di lapangan tetap menunjukkan variasi dan inkonsistensi (Toumi et al., 2024).

Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain kurangnya pelatihan berkelanjutan, minimnya sistem evaluasi dan penguatan, serta tidak adanya dukungan organisasi yang konsisten. Oleh karena itu, keberhasilan SBAR sangat dipengaruhi oleh adanya supervisi, audit, serta komitmen kepemimpinan dalam organisasi pelayanan kesehatan (Fliegenschmidt et al., 2023; Kosim & Saimi, 2025).

Selain itu, tinjauan sistematis menunjukkan bahwa meskipun SBAR dapat meningkatkan kualitas komunikasi, bukti terhadap dampaknya pada outcome klinis masih terbatas dan belum sepenuhnya kuat, sehingga implementasinya perlu dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, bukan intervensi tunggal (X. Liu et al., 2023; Pazar et al., 2024).

D. Handover dan Continuity of Care

1. Konsep dan Tujuan Handover

Secara konseptual, handover adalah proses transfer informasi klinis sekaligus transfer akuntabilitas dan tanggung jawab atas sebagian atau seluruh asuhan pasien dari satu profesional kepada profesional lain. Definisi ini penting karena menegaskan bahwa handover bukan sekadar “menyampaikan laporan”, tetapi juga memastikan bahwa penerima handover memahami apa yang sedang terjadi pada pasien, apa yang telah dilakukan, apa yang belum selesai, dan risiko apa yang harus diantisipasi berikutnya. de Lange et al., (2024) menegaskan bahwa handover mencakup perpindahan tanggung jawab profesional, sedangkan Galli et al., (2025) mendeskripsikannya sebagai metode formal berbagi informasi di antara tenaga kesehatan. Dengan demikian, handover adalah titik temu antara komunikasi klinis, koordinasi tim, dan kesinambungan asuhan.

Dalam perspektif continuity of care, handover yang baik menjamin bahwa perawatan pasien tetap berlanjut secara logis, aman, dan kontekstual meskipun terjadi pergantian sif, perpindahan unit, atau perpindahan antarprofesi. de Lange et al., (2024) menunjukkan bahwa handover yang berpusat pada pasien memiliki atribut yang jelas, yaitu terstruktur, memuat transfer informasi verbal dan tertulis, berlangsung secara antarprofesi, melibatkan pasien dan/atau keluarga bila relevan, dilakukan di dekat pasien, serta berlangsung tanpa interupsi. Artinya, continuity of care tidak cukup dijaga hanya dengan dokumentasi, tetapi juga membutuhkan komunikasi langsung yang memungkinkan klarifikasi, konfirmasi, dan koreksi informasi secara real time.

Tujuan utama handover karena itu adalah memastikan kesinambungan keputusan dan tindakan klinis, meminimalkan kehilangan informasi, memperjelas tanggung jawab profesional, dan meningkatkan situational awareness tim penerima. Rapid review dari Agency for Healthcare Research and Quality menempatkan handoff sebagai salah satu “weak link” dalam rantai perawatan pasien rawat inap dan menekankan bahwa protokol yang terstruktur dibutuhkan untuk mengurangi kesalahan yang timbul saat transisi tanggung jawab. Dalam konteks praktik keperawatan, tujuan ini juga mencakup menjamin bahwa masalah keperawatan, respons pasien, tugas yang belum tuntas, kebutuhan pemantauan lanjut, dan potensi bahaya segera dipahami oleh perawat penerima sehingga asuhan tidak terputus pada saat pergantian sif atau perpindahan unit (Galli et al., 2025; Shekelle et al., 2025).

2. Metode dan Model Handover

Jenis handover dapat dibedakan menurut konteks transisinya. Pertama, ada within-unit handover, yaitu serah terima dalam unit yang sama, lazimnya terjadi

pada pergantian sif. Kedua, ada between-unit handover, yaitu serah terima saat pasien berpindah dari satu level atau jenis layanan ke layanan lain, misalnya dari ICU ke bangsal, dari ruang operasi ke ICU, atau dari instalasi gawat darurat ke rawat inap. Ketiga, ada handover pada antarmuka pra-rumah sakit ke rumah sakit, misalnya dari paramedis ambulans ke perawat dan dokter IGD. Rapid review AHRQ menekankan bahwa within-unit dan between-unit handoff memiliki karakteristik yang berbeda: yang pertama terutama dipicu oleh batas waktu sif, sedangkan yang kedua dipicu oleh perubahan kebutuhan klinis pasien yang menuntut tim dan mode perawatan yang berbeda. (de Lange et al., 2024) juga menekankan bahwa handover pra-rumah sakit ke IGD merupakan proses antarprofesi yang krusial karena sering kali hanya ada satu kesempatan untuk menyampaikan informasi secara lengkap.

Dari sisi metode, handover dapat dilakukan secara lisan, tertulis, bedside, elektronik, atau kombinasi dari semuanya. Literatur terbaru justru menunjukkan bahwa kombinasi verbal dan dokumenter lebih aman daripada bergantung pada satu saluran saja. Lazzari (2024) dalam tinjauan sistematis menyimpulkan bahwa penerapan ISBAR pada handover verbal dan elektronik meningkatkan keterampilan komunikasi antarprofesi, kepercayaan diri tenaga kesehatan, dan kualitas transfer informasi klinis; penggunaan electronic patient records bahkan dapat mempertinggi efikasi handover. Studi kuasi-eksperimental Tataei et al (2023) juga menunjukkan bahwa sistem handover keperawatan elektronik meningkatkan kualitas dan efisiensi serah terima, mengurangi kemungkinan kesalahan klinis, menghemat waktu handover, dan meningkatkan keselamatan pasien dibanding metode berbasis kertas. Dengan demikian, metode handover sebaiknya dipilih bukan berdasarkan kebiasaan semata, tetapi berdasarkan kemampuan metode tersebut untuk membuat informasi menjadi lengkap, mudah diverifikasi, dan dapat ditindaklanjuti (Lee & Jang, 2021).

Metode bedside handover mendapat perhatian besar karena paling dekat dengan prinsip person-centred care. Maher et al (2025) melaporkan bahwa handover yang melibatkan pasien atau keluarga memberikan dampak positif terhadap kepuasan, keterlibatan, otonomi pasien, dan efektivitas pertukaran informasi, meskipun implementasinya menghadapi hambatan seperti beban kognitif, kebutuhan waktu, dan penurunan kepatuhan dari waktu ke waktu. Daicampi et al (2025) juga menunjukkan bahwa bedside handover berasosiasi dengan peningkatan persepsi keselamatan, kepuasan, penurunan kecemasan, dan keterlibatan aktif pasien. Namun, bukti kualitatif menunjukkan bahwa kehadiran pasien di sisi tempat tidur tidak otomatis membuat handover menjadi partisipatif; tanpa strategi komunikasi yang sengaja melibatkan pasien,

percakapan tetap dapat didominasi perawat, pasien merasa diabaikan, dan penggunaan jargon medis justru menurunkan makna continuity of care dari sudut pandang pasien (Anshasi & Almayasi, 2024; Cruchinho et al., 2025)

Penting pula dicatat bahwa tidak ada satu model yang mutlak unggul untuk semua setting. Alizadeh-risani et al., (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks IGD, model handover yang dimodifikasi dapat menghasilkan mutu handover dan persepsi perawat yang lebih baik daripada SBAR klasik, terutama karena model tersebut menambahkan checklist, fokus yang lebih kuat pada aspek asuhan keperawatan, dan perpaduan bentuk lisan serta template tertulis. Standardisasi harus dipahami sebagai proses adaptasi yang berbasis konteks klinis, bukan sekadar menyalin satu mnemonic ke semua unit layanan (Alizadeh-risani et al., 2024).

3. Risiko dalam Proses Handover

Risiko terbesar pada handover adalah hilangnya informasi yang secara klinis penting tepat pada saat tanggung jawab dipindahkan. Dalam rangkuman AHRQ atas data The Joint Commission, kegagalan komunikasi di rumah sakit Amerika Serikat berkontribusi setidaknya pada 30% klaim malapraktik dan lebih dari 1.700 kematian dalam lima tahun, sehingga perbaikan handoff telah lama ditempatkan sebagai sasaran keselamatan pasien. Angka tersebut memang tidak identik dengan praktik keperawatan saja, tetapi maknanya sangat relevan: saat komunikasi antarprofesi dan antarsif gagal, kesalahan tidak biasanya muncul sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian kegagalan yang saling memperkuat hingga menimbulkan adverse event (Shekelle et al., 2025).

Bukti yang lebih khusus dari tinjauan sistematis dan meta-analisis (Yeom et al., 2026) memperlihatkan bahwa bentuk kesalahan handoff keperawatan yang paling sering adalah information omission. Dalam meta-analisis enam studi, proporsi gabungan terjadinya jenis kesalahan handoff mencapai sekitar 88%, walaupun dengan heterogenitas yang tinggi. Faktor penyebab terbagi dalam empat kategori besar, yaitu kompleksitas proses handoff, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individual. Implikasi temuan ini sangat penting bagi keperawatan: kualitas handover tidak hanya tergantung pada kompetensi perawat individu, tetapi juga pada desain sistem kerja, beban unit, kondisi lingkungan fisik, format dokumentasi, budaya bertanya, dan disiplin standar komunikasi (Yeom et al., 2026).

Pada situasi gawat darurat, risiko ini semakin besar. Galli et al (2025) menggambarkan IGD sebagai lingkungan dengan rapid patient turnover, keputusan cepat, pola kedatangan pasien yang berubah-ubah, serta beban kerja yang sulit diprediksi; semua karakteristik tersebut meningkatkan peluang

handover menjadi tidak lengkap. Sejalan dengan itu, (Haliq & AlShammari, 2025) menemukan bahwa dalam setting kegawatdaruratan, paramedis lebih sering mengalami interupsi saat handover, sedangkan perawat lebih sadar bahwa pengukuran tanda vital penting dapat terlewat. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa kedua kelompok memandang kerangka terstruktur seperti ISBAR bernilai untuk memperbaiki komunikasi dan keselamatan pasien. Dengan kata lain, situasi yang menuntut kecepatan justru bukan alasan untuk mengurangi struktur, melainkan alasan untuk memperkuatnya (Galli et al., 2025)

Dampak klinis dari proses handover yang buruk melampaui sekadar miskomunikasi. Yeom et al (2026) menunjukkan bahwa handoff error dapat menyebabkan keterlambatan pergantian sif, berkurangnya waktu asuhan langsung, munculnya tugas tambahan yang tidak terduga, meningkatnya beban kerja, dan terganggunya hubungan profesional di antara perawat maupun antara perawat dengan pasien. (Galli et al., 2025) menambahkan bahwa ketidaklengkapan dan ketidakakuratan informasi pada handover berpotensi memicu penundaan tatalaksana, penilaian yang keliru, dan hasil pasien yang lebih buruk. Oleh karena itu, risiko dalam handover harus dipahami sebagai risiko sistemik yang memengaruhi mutu klinis, efisiensi kerja, dan pengalaman pasien secara bersamaan (Yeom et al., 2026)

4. Handover Berkualitas sebagai Upaya Pencegahan Insiden

Berdasarkan sintesis literatur mutakhir, handover berkualitas mempunyai beberapa ciri inti. Pertama, isinya terstruktur dan berfokus pada informasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan narasi yang panjang namun tidak prioritatif. Kedua, ia memadukan transfer verbal dengan dukungan tertulis atau elektronik. Ketiga, ia secara eksplisit memindahkan tanggung jawab klinis kepada penerima. Keempat, ia memberi ruang klarifikasi, pertanyaan, dan konfirmasi kembali. Kelima, bila setting memungkinkan, ia melibatkan pasien dan/atau keluarga dan diakhiri dengan safety check pada kondisi pasien, lingkungan, dan alat. de Lange et al (2024) merumuskan atribut handover yang aman sebagai struktur, transfer verbal dan tertulis, proses antarprofesi, keterlibatan pasien/keluarga, pelaksanaan di bedside, dan berlangsung tanpa interupsi. Sementara itu, Ghosh et al. (2025) menjelaskan operasional bedside handover melalui lima langkah: persiapan staf dan dokumen, pengenalan perawat, pertukaran informasi, pelibatan pasien, dan pengecekan keselamatan di akhir proses (de Lange et al., 2024).

Dari sisi alat standar, bukti paling kuat saat ini menunjukkan bahwa struktur benar-benar penting, tetapi pilihan alat perlu disesuaikan dengan konteks. Rapid review AHRQ tahun 2025 menyimpulkan bahwa I-PASS kemungkinan besar memperbaiki luaran klinis pasien dengan tingkat kepastian sedang, sedangkan SBAR

mungkin memperbaiki luaran klinis, tetapi tingkat kepastian buktinya lebih rendah. Temuan ini menunjukkan dua hal. Pertama, mnemonic yang terstruktur memang lebih baik daripada handover yang sepenuhnya informal. Kedua, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh nama alat, melainkan juga oleh fidelitas penggunaan, pelatihan, dan strategi implementasi yang menyertainya. Dalam konteks tertentu, adaptasi lokal bahkan dapat lebih efektif daripada penggunaan SBAR klasik secara kaku, seperti terlihat pada penelitian (Alizadeh-risani et al., 2024) di IGD.

Bukti intervensional mutakhir semakin menguatkan argumen tersebut. Galli et al., (2025) menemukan bahwa penerapan kerangka standar berbasis ISBAR di IGD meningkatkan skor median penilaian mutu handover dari 77,8% sebelum intervensi menjadi 84,6% sesudah intervensi. Pinto et al (2025) menunjukkan bahwa penggunaan panduan SBAR pada keperawatan paliatif secara bermakna meningkatkan kualitas handover, menurunkan medication error, dan meniadakan adverse events setelah implementasi. Ahmed et al (2025) juga melaporkan bahwa pelatihan bedside handover meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan perawat secara bermakna, sedangkan (Choi et al., 2024) dalam tinjauan sistematis menekankan bahwa program pendidikan handover yang efektif umumnya memadukan ceramah singkat dengan praktik aktif seperti demonstrasi, role-play, dan umpan balik. Artinya, handover berkualitas lahir dari kombinasi antara alat yang terstandar dan proses belajar yang sengaja dirancang.

Transformasi mutu handover juga semakin ditopang oleh dokumentasi digital. (Lazzari, 2024) menegaskan bahwa integrasi verbal dan elektronik memperbaiki kualitas transfer informasi, komunikasi antarprofesi, dan rasa percaya diri tenaga kesehatan. Tataei et al (2023) memperlihatkan bahwa handover elektronik dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi serah terima sekaligus meningkatkan keselamatan pasien di ICU. Sebagai penguat konteks Indonesia, studi observasional lokal menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara komunikasi SBAR yang efektif dan kualitas pelaksanaan handover di ruang rawat inap sehingga temuan internasional tersebut memiliki resonansi praktik yang nyata pada setting rumah sakit nasional (Handoyo et al., 2022)

Dengan demikian, handover berkualitas perlu diposisikan sebagai patient safety barrier yang aktif, bukan sebagai kebiasaan serah-terima pasif. Mutu handover terbaik muncul ketika organisasi membangun format yang terstandar namun adaptif, menyediakan pelatihan berulang, mengurangi interupsi, mendukung dokumentasi elektronik, serta menumbuhkan budaya klarifikasi dan akuntabilitas. Dalam kerangka continuity of care, handover yang baik memastikan bahwa pasien tidak “memulai dari nol” setiap kali terjadi pergantian tenaga, tetapi

dibawa maju secara aman melalui alur informasi, keputusan, dan tanggung jawab yang konsisten dari satu titik layanan ke titik berikutnya (de Lange et al., 2024; Shekelle et al., 2025; Yeom et al., 2026).

E. Komunikasi Kritis dalam Situasi High-Risk

1. Karakteristik Situasi Klinis Kritis

Situasi klinis kritis dicirikan oleh tiga unsur utama: ketidakstabilan fisiologis, perubahan kondisi yang cepat, dan konsekuensi tinggi bila respons terlambat atau tidak tepat. Di IGD, karakter ini diperberat oleh variabilitas arus pasien, keterbatasan sumber daya yang berubah dari menit ke menit, dan kebutuhan adaptasi cepat terhadap pasien dengan trauma, syok, sepsis, atau henti jantung. Di ICU, kompleksitas muncul dari kebutuhan keputusan harian mengenai ventilasi, vasopresor, sedasi, cairan, dan organ support lain pada pasien dengan trajectory klinis yang sangat dinamis. Dengan kata lain, high-risk communication selalu terjadi di lingkungan yang bukan hanya "sibuk," tetapi juga ambigu, multiprofesional, dan rentan terhadap prioritas yang saling bersaing (Heart Association, 2025; Matsumoto et al., 2025; World Health Organization, 2021b).

Karakter penting lain adalah uncertainty. Dalam praktik kritis, informasi jarang datang lengkap pada awal kejadian. Perawat dan klinisi harus menggabungkan data objektif, perubahan tanda vital, respons terhadap intervensi, intuisi klinis, pengalaman, dan masukan anggota tim lain. Sintesis literatur dari konteks keperawatan gawat darurat menunjukkan bahwa pengambilan keputusan klinis berlangsung melalui rangkaian mengenali cue, menganalisis cue, memprioritaskan hipotesis, menyusun solusi, bertindak, lalu mengevaluasi hasil; proses ini semakin kompleks ketika dipengaruhi oleh pengalaman, kolaborasi tim, teknologi, dan dukungan sistem (Saharuddin et al., 2025)

Contoh praktisnya adalah pasien trauma multipel yang baru tiba di IGD: tim harus secara simultan membagi peran airway, sirkulasi, medication, pencatatan, imaging, dan komunikasi dengan spesialis. Pada situasi seperti ini, informasi yang terlambat 30–60 detik misalnya perubahan saturasi, tekanan darah, atau kegagalan akses intravena dapat menggeser seluruh prioritas tindakan. Karena itu, resusitasi modern menuntut role clarity, komunikasi terarah, dan re-evaluasi cepat melalui huddle singkat ketika rencana harus diubah (Heart Association, 2025; Sung & Hsu, 2025)

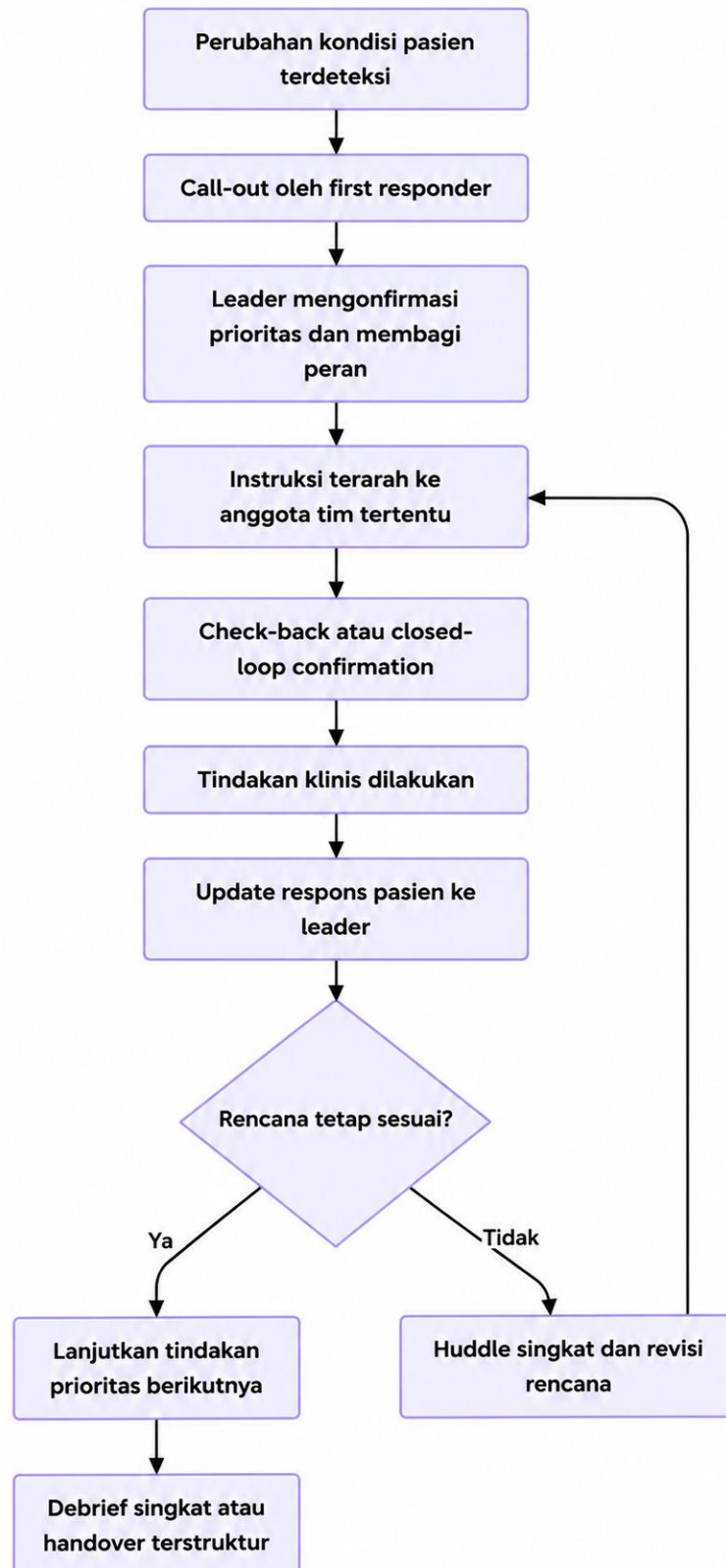
2. Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Pengambilan keputusan klinis dapat didefinisikan sebagai proses kognitif dan kolaboratif untuk menilai masalah pasien, menafsirkan data, memilih

prioritas, menjalankan intervensi, dan mengevaluasi respons secara cepat serta aman. Definisi ini penting karena pada situasi high-risk, keputusan jarang murni individual; ia dibentuk oleh faktor manusia, faktor tim, faktor sistem, dan faktor pasien. Tinjauan sistematis tentang pengambilan keputusan multidisiplin di ICU menunjukkan bahwa keputusan organ support sangat dipengaruhi empat domain tersebut, sehingga kualitas keputusan tidak dapat dipisahkan dari kualitas komunikasi antarprofesi (Matsumoto et al., 2025; Saharuddin et al., 2025)

Peran komunikasi dalam keputusan cepat dan akurat terutama ada pada tiga fungsi. Pertama, komunikasi menyatukan potongan data yang tersebar pada anggota tim yang berbeda. Kedua, komunikasi menciptakan shared mental model tentang “apa yang sedang terjadi, siapa melakukan apa, dan apa prioritas berikutnya.” Ketiga, komunikasi memungkinkan koreksi kesalahan secara real time melalui check-back, klarifikasi, dan speak-up. Dalam kerangka TeamSTEPPS, situation monitoring dan shared mental model adalah prasyarat keputusan cepat yang aman; tanpa itu, tim mudah jatuh pada asumsi yang tidak dibagikan, duplikasi tindakan, atau keterlambatan eskalasi (Agency for Healthcare Research and Quality., 2023; World Health Organization, 2021b)

Pada tingkat diagnostik, WHO menekankan bahwa keselamatan diagnosis memburuk ketika ada kegagalan komunikasi, beban kerja berat, teamwork yang tidak efektif, fatigue, stress, dan bias kognitif. Artinya, akurasi keputusan klinis dalam situasi kritis tidak hanya tergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga pada kualitas komunikasi yang menghubungkan observasi klinis dengan tindakan tim. (World Health Organization, 2021b).



Gambar 6.1 Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Klinis

3. Faktor Risiko Miskomunikasi pada Situasi Kritis

Sumber utama miskomunikasi pada kondisi kritis adalah tekanan waktu dan beban kerja. WHO menyebut heavy workloads dan ineffective teamwork sebagai faktor sistemik yang memicu error diagnostik, sedangkan data sentinel dari The Joint Commission menunjukkan kontribusi berulang dari komunikasi kritis yang tidak tersampaikan, handoff yang tidak memadai, task saturation, task fixation, serta absennya shared understanding dalam kejadian serius. Pada ICU, mental workload perawat juga tinggi; meta-analisis melaporkan pooled mean mental workload 68,07 dan mengidentifikasi faktor demografis, pekerjaan, dan psikologis sebagai penentunya (Teng et al., 2024; The Joint Commission., 2025; World Health Organization, 2021b)

Faktor kedua adalah cognitive load dan stress. Dalam situasi kritis, anggota tim sering harus memproses beberapa sumber informasi sekaligus: monitor, instruksi verbal, respons pasien, catatan obat, alarm, dan tuntutan keluarga. Beban ini membuat perhatian menyempit, meningkatkan risiko kehilangan konteks, dan mendorong reliance pada shortcut mental atau bias. Kegagalan komunikasi karena stress tidak selalu berbentuk “diam”; sering justru muncul sebagai pesan yang terlalu singkat, tidak ditujukan ke orang tertentu, atau tidak divalidasi kembali (WHO, 2024; AHRQ, 2023; The Joint Commission, 2025).

Faktor ketiga adalah perceptual dan interpretation errors. Perbedaan pengalaman, latar profesi, dan sudut pandang dapat memperkaya keputusan—tetapi tanpa mekanisme berbagi informasi, perbedaan itu berubah menjadi fragmentasi. AHRQ menekankan bahwa shared mental model tidak tercipta otomatis; ia harus dibangun lewat pemantauan situasi, SBAR, call-out, check-back, brief, huddle, dan debrief. Dengan kata lain, banyak miskomunikasi bukan karena informasi tidak ada, tetapi karena informasi tidak dikonversi menjadi makna bersama (Agency for Healthcare Research and Quality., 2023).

Tabel 6.1 Faktor Risiko Miskomunikasi pada Situasi Kritis

Faktor risiko utama	Manifestasi di lapangan	Dampak potensial	Strategi yang relevan	mitigasi paling relevan
Tekanan waktu dan workload	pesan dipercepat, handoff terpotong, prioritas berubah cepat	keterlambatan tindakan, missed task	role assignment, huddle singkat, escalation script, prioritas 5-menit	

Beban kognitif dan stress	task fixation, multitasking, lupa menutup loop	instruksi hilang, tindakan tidak selesai	closed-loop, one speaker at a time, cognitive aids, repeat-back
Interupsi dan distraksi	alarm, pertanyaan simultan, dokumentasi saat resusitasi	kehilangan situational awareness	protected communication moments, runner/scribe, no-interruption zones
Hierarki dan takut speak-up	keraguan mengoreksi senior, isu keselamatan tidak diangkat	keterlambatan koreksi error	CUS/two-challenge rule, psychological safety, kepemimpinan terbuka
Error persepsi/interpretasi	tim punya "versi" klinis berbeda	diagnosis/prioritas tidak selaras	shared mental model, call-out data kunci, synthesis by receiver

4. Strategi Komunikasi Efektif pada Kondisi High-Risk

Strategi yang paling kuat adalah menggabungkan protokol mikro untuk komunikasi real time dengan protokol makro untuk eskalasi dan handoff. Pada level mikro, closed-loop communication paling sesuai untuk tindakan detik-ke-detik karena memaksa tiga langkah: pesan dikirim, diterima dan diulang, lalu dikonfirmasi kembali. Analisis mixed-methods pada simulasi kegawatdaruratan kamar operasi menunjukkan bahwa closed-loop yang digabung dengan directed communication berhubungan dengan completion rate 100%, dibanding 81% ketika satu atau keduanya tidak digunakan; masalah utamanya bukan efektivitas, melainkan frekuensi penggunaan yang masih rendah (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023b; Lee et al., 2025)

Pada level eskalasi, SBAR/ISBAR berguna untuk struktur singkat ketika perawat harus menghubungi dokter, rapid response team, atau konsultan. Namun, SBAR tidak cukup bila dipakai sendirian dalam resusitasi yang sangat dinamis; ia perlu digabung dengan call-out, read-back, dan penegasan tindakan berikutnya. Untuk handoff yang lebih komprehensif, review AHRQ menemukan low-certainty evidence untuk SBAR tetapi moderate-certainty evidence untuk I-PASS dalam memperbaiki outcome keselamatan pada within-unit transitions. Karena itu, praktik yang paling rasional adalah memakai SBAR/ISBAR untuk escalation call, kemudian I-PASS atau modifikasinya untuk handover yang lebih

lengkap (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023b; Shekelle et al., 2025).

Tabel 6.2 Strategi komunikasi efektif pada kondisi High-Risk

Protokol	Komponen inti	Kekuatan bukti	Setting khas	Kelebihan	Keterbatasan
Closed-loop + call-out + check-back	instruksi terarah, repeat-back, verifikasi akhir	kuat untuk outcome proses tim; sangat sesuai untuk high-acuity real time	resusitasi, pemberian obat, prosedur emergensi	cepat, jelas, akuntabel	perlu disiplin verbal dan budaya tim
SBAR/ISBAR	situation, background, assessment, recommendation/identify	bermanfaat, tetapi bukti klinis lebih lemah dibanding I-PASS untuk transition outcomes	escalation call, konsultasi, rapid response	ringkas, mudah diajarkan	bisa terlalu sempit bila kondisi berubah sangat cepat
I-PASS/modifikasi I-PASS	illness severity, patient summary, action list, contingency, synthesis	sedang; paling kuat di antara handoff tools yang direview AHRQ	shift handover, within-unit/ICU handoff	komprehensif, mengurangi omission	kurang praktis untuk perintah detik-ke-detik
Brief-huddle-debrief	penyelarasan awal, revisi rencana, refleksi pascakejadian	guideline-supported dan konsisten memperbaiki situational awareness	pra-kedatangan trauma, high-risk inpatient, post-code	memperbarui shared mental model	sering terhambat waktu dan kepemimpinan

Koordinasi tim berbasis trust tidak berarti komunikasi menjadi informal; justru trust yang sehat memungkinkan komunikasi menjadi lebih langsung, korektif, dan aman. AHRQ menempatkan mutual support sebagai inti teamwork, termasuk task assistance, feedback, advocacy, assertion, dan two-challenge rule.

The Joint Commission pada 2026 juga menekankan bahwa psychological safety esensial bagi teamwork, komunikasi, dan patient safety. Bukti empiris mendukung arah ini: studi trauma team menemukan bahwa team shared experience dan transactive memory system berhubungan dengan perpendekan length of stay rumah sakit 3,3 hari dan ICU 1,9 hari. Artinya, tim yang saling mengenal kompetensi satu sama lain, berbagi pengetahuan, dan berani saling mengoreksi lebih mungkin berkoordinasi dengan presisi tinggi (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023b; Argote et al., 2025; Joint Commission, 2026)

Bukti implementasi juga makin konsisten. Di National Cheng Kung University mirza (Albar et al., 2025; Mirzaei et al., 2025; Sung & Hsu, 2025) Hospital, latihan interprofesional berbasis simulasi meningkatkan leadership communication dan menyoroti bahwa kelemahan yang masih menetap biasanya adalah task delegation yang tidak jelas, keterlambatan mengenali perubahan kondisi, serta penggunaan call-out dan check-back yang tidak konsisten. Di Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital, debriefing pascasimulasi trauma meningkatkan skor performa tim secara bermakna. Pada level pendidikan pasien safety untuk ICU dan IGD, metode case-based learning, refleksi, dan kuliah semuanya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik, dengan keunggulan pada sikap dan praktik untuk case-based learning (Sung & Hsu, 2025; Albar et al., 2025; Mirzaei et al., 2025).

Secara praktis, adaptasi protokol untuk kondisi emergensi dapat dirumuskan sebagai berikut: I-SBAR-E—Identify and immediate concern, Situation now, Background ringkas yang relevan, Assessment termasuk respons terhadap intervensi, Recommendation/request yang spesifik, dan Explicit read-back/next step. Bentuk ini bukan protokol resmi baru, melainkan sintesis operasional dari SBAR, directed communication, dan closed-loop agar lebih kompatibel dengan resusitasi (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023b; Heart Association, 2025; Shekelle et al., 2025).

Implikasi Pendidikan dan Implementasi

Program pelatihan untuk komunikasi kritis sebaiknya tidak berhenti pada “sosialisasi format,” tetapi menargetkan perilaku yang dapat diukur. Review terkini di setting gawat darurat menyarankan agar evaluasi difokuskan pada indikator yang sensitif terhadap mekanisme perubahan, seperti jumlah complete closed-loop exchanges, prioritization errors, dan time to critical actions, idealnya dengan observasi video dan debriefing terstruktur. Temuan dari simulasi interprofesional di high-acuity settings juga menunjukkan bahwa komunikasi, leadership, dan situational awareness adalah area yang paling sering perlu penguatan berulang (Sung & Hsu, 2025; Y. K. Zhang et al., 2026).

Tabel 6.3 Implikasi pendidikan dan implementasi

Sasaran pembelajaran	Outcome terukur	Metode evaluasi
Menggunakan closed-loop, call-out, dan check-back secara konsisten	persentase instruksi yang ditutup dengan verifikasi	audit video, checklist perilaku
Menyampaikan eskalasi dengan SBAR/ISBAR dalam ≤30 detik	kelengkapan elemen dan kejelasan request	OSCE/simulasi
Membangun shared mental model saat kondisi berubah	frekuensi huddle, kejelasan peran, kesesuaian rencana tim	TEAM/T-NOTECHS, observasi fasilitator
Melakukan speak-up secara aman	penggunaan CUS/two-challenge rule saat risiko muncul	simulasi dengan skenario hierarchy gradient
Melaksanakan hot dan cold debriefing	proporsi event yang didebrief, isu sistem yang ditindaklanjuti	dashboard mutu, action log

Hambatan implementasi umumnya meliputi hierarki profesi, tingginya turnover, crowding, variasi kompetensi, tidak adanya waktu debrief, dan kecenderungan tim kembali ke kebiasaan lama ketika tekanan meningkat. Solusi yang paling realistis adalah memilih sedikit protokol inti, melatihnya secara interprofesional, menempelkan cue visual di area kritis, mengaudit perilaku komunikasi secara berkala, dan memastikan pimpinan klinis aktif menciptakan psychological safety (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023b; Joint Commission, 2026; Shekelle et al., 2025).

F. Miskomunikasi sebagai Akar Insiden Keselamatan Pasien

1. Konsep dan Bentuk Miskomunikasi dalam Pelayanan Kesehatan

Secara operasional, miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai kegagalan transfer makna yang menyebabkan informasi pasien menjadi hilang, tertunda, kabur, salah ditafsirkan, atau tidak ditindaklanjuti pada saat dibutuhkan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat multidimensional. Dalam kajian nursing handoff, omission of information muncul sebagai bentuk error yang paling sering. Pada studi pengalaman perawat saat handover, gap komunikasi juga tampak melalui poor documentation dan penggunaan bahasa yang tidak lazim. Kerangka analitik yang dikembangkan Bender dan kolega bahkan mengidentifikasi sembilan tipe error komunikasi, yang

menegaskan bahwa miskomunikasi adalah spektrum kegagalan, bukan satu kejadian sederhana (Atinga et al., 2024; Bender et al., 2025; Yeom et al., 2026).

Dalam konteks keperawatan, bentuk-bentuk miskomunikasi yang paling relevan meliputi informasi penting yang terlewat selama handover, penggunaan singkatan dan jargon yang membuka ruang ambiguitas, ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan dokumentasi, interupsi yang memotong alur serah terima, diamnya anggota tim ketika seharusnya melakukan speaking up, serta hambatan bahasa yang membuat pasien atau keluarga tidak memahami instruksi dan risiko klinis. Review tentang distractors dan interruptions pada nurse-to-nurse handoff menunjukkan bahwa interupsi merupakan penghalang komunikasi yang dapat berujung pada medical errors. Review tentang speaking up menambahkan bahwa banyak tenaga kesehatan ragu menyampaikan keberatan karena perbedaan posisi, relasi, dan rasa aman untuk berbicara. Pada sisi pasien, penggunaan medical jargon dan dominasi percakapan oleh tenaga kesehatan juga dapat membuat pasien merasa diabaikan atau tersisih dari proses handover (Ghosh et al., 2025; Parry et al., 2023; Schulson et al., 2025; van Dongen et al., 2024; Vanderzwan et al., 2023).

Dari sudut pandang substansi, bentuk-bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga lapisan. Pertama, distorsi isi, yaitu ketika data klinis penting tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak relevan dengan kondisi pasien. Kedua, distorsi medium, yaitu ketika pesan dikaburkan oleh singkatan, jargon, dokumentasi buruk, atau sistem komunikasi yang tidak seragam. Ketiga, distorsi relasional, yaitu ketika pesan sebenarnya tersedia tetapi tidak diangkat, tidak diklarifikasi, atau tidak ditanggapi karena hierarki, konflik, atau budaya kerja yang menekan suara korektif. Pengelompokan ini penting untuk buku referensi karena menegaskan bahwa miskomunikasi tidak hanya terjadi pada isi pesan, tetapi juga pada cara pesan dibawa dan pada relasi yang menentukan apakah pesan tersebut boleh, berani, dan sempat disampaikan (L. Gleeson et al., 2023; van Dongen et al., 2024; Yeom et al., 2026).

2. Analisis Penyebab Miskomunikasi

Analisis penyebab miskomunikasi harus bergerak dari level individu ke level sistem. Review van Dongen et al. membagi determinan speaking up ke dalam empat kategori: individual, relational, contextual, dan organisational. Pada level individual, faktor seperti profesi, persepsi, emosi, pengalaman, kemampuan komunikasi, dan rasa percaya diri menentukan apakah seseorang menyampaikan informasi secara lengkap dan tepat waktu. Pada level relational, hambatan utama

berupa perbedaan peran, hierarki, dan kekhawatiran merusak hubungan kerja. Pada level contextual, sifat masalah keselamatan, tingkat urgensi, dan persepsi risiko pada momen tertentu mempengaruhi keberanian untuk mengklarifikasi atau mengoreksi. Pada level organisational, budaya keselamatan, dukungan pimpinan, protokol, open communication, dan sistem pelaporan menentukan mutu komunikasi sehari-hari. (van Dongen et al., 2024)

Temuan lapangan (Atinga et al (2024). memperjelas bagaimana penyebab itu bekerja dalam praktik. Mereka mengelompokkan pendorong gap komunikasi ke dalam faktor attitudinal seperti poor work ethics, konflik interpersonal, dokumentasi yang buruk, dan penggunaan bahasa yang tidak konvensional; faktor organisational seperti beban kerja tinggi, keterbatasan pelatihan, dan ketiadaan prosedur handover formal; serta faktor cultural seperti stereotip dan prasangka yang menghambat interaksi inklusif antar-shift. Dengan demikian, miskomunikasi sering kali bukan hasil satu aktor yang lalai, tetapi hasil akumulasi tekanan kerja, desain proses yang lemah, dan norma tim yang tidak cukup mendukung klarifikasi dua arah (Atinga et al., 2024).

Pada proses handover keperawatan, interupsi dan distraksi merupakan penyebab yang sangat konkret. Handover terjadi pada titik transisi yang padat tugas, sarat informasi, dan rentan terganggu oleh pertanyaan lain, kebutuhan pasien yang mendadak, suara lingkungan, atau aktivitas unit yang simultan (Vanderzwan et al (2023) menegaskan bahwa distractors dan interruptions adalah penghalang efektif bagi handoff yang aman dan dapat berujung pada medical errors yang sebenarnya dapat dicegah. Di sisi lain, Parry et al. menunjukkan bahwa penggunaan singkatan yang berlebihan juga menurunkan kejelasan komunikasi klinis dan dapat mengompromikan keselamatan pasien. Artinya, bahkan ketika tenaga kesehatan bermaksud berkomunikasi cepat, kecepatan yang tidak disertai standardisasi justru memperbesar risiko (Parry et al., 2023; Vanderzwan et al., 2023).

Analisis penyebab juga harus memasukkan pasien dan keluarga sebagai simpul komunikasi aktif, bukan sekadar penerima informasi. Studi kualitatif Ghosh et al. menunjukkan bahwa keterlibatan pasien dan keluarga dalam bedside handover masih sering terhambat oleh ketidaktahuan mengenai hak untuk berpartisipasi, waktu handover yang tidak ramah keluarga, pendekatan perawat, rasa takut bertanya, dan praktik handover yang tidak selalu benar-benar berlangsung di sisi tempat tidur pasien. Ketika pasien tidak diberi ruang untuk mengonfirmasi, mengoreksi, atau menambah informasi, sistem kehilangan lapisan verifikasi penting yang seharusnya dapat mencegah error (Ghosh et al., 2025).

3. Dampak Miskomunikasi terhadap keselamatan Pasien

Dampak miskomunikasi terhadap outcome pasien kini dapat dijelaskan lebih kuat secara kuantitatif. Keshtkar et al (2025) menemukan bahwa komunikasi yang buruk merupakan satu-satunya penyebab pada median 13,2% insiden keselamatan pasien dan menjadi faktor kontributor pada median 24,0% insiden. Temuan ini sangat penting secara argumentatif karena menempatkan komunikasi bukan sebagai unsur administratif tambahan, melainkan sebagai determinan klinis inti dari keselamatan pasien. Dengan kata lain, perbaikan komunikasi adalah intervensi keselamatan pasien yang bersifat primer, bukan sekunder (Keshtkar et al., 2025).

Pada level klinis, konsekuensi yang paling konsisten adalah diagnostic errors, treatment errors, komplikasi, dan perpanjangan lama rawat. Atinga et al. menunjukkan bahwa gap komunikasi antar-shift dapat menghasilkan diagnostic and treatment errors, komplikasi, dan hospitalisasi yang lebih panjang. Pada kelompok pasien dengan hambatan bahasa, (Schulson et al., 2025) melaporkan peningkatan risiko pada communication-sensitive safety events, khususnya medication-related adverse events dan peristiwa terkait persalinan pervaginam. Temuan ini menunjukkan bahwa miskomunikasi tidak selalu bermanifestasi sebagai satu “kejadian besar”; sering kali ia muncul sebagai rangkaian deviasi kecil yang saling bertumpuk sampai menyebabkan outcome klinis yang buruk (Atinga et al., 2024; Schulson et al., 2025).

Khusus pada handover perawat, bukti terbaru memperlihatkan betapa besarnya ruang risiko yang masih tersisa. Yeom et al. menemukan bahwa omission of information adalah jenis handoff error yang paling sering, dan meta-analisis mereka menghasilkan pooled proportion error sekitar 88% pada studi yang dapat digabungkan. Sejalan dengan itu, survei Kaliraman dan Watson pada 688 perawat rumah sakit menunjukkan bahwa lebih dari 1 dari 4 perawat menyatakan informasi penting sering terlewat saat shift change; hanya 6,3% yang menyatakan handoff yang mereka terima selalu akurat, lengkap, dan relevan dengan kondisi pasien, dan hanya 6,4% yang menyatakan pasien selalu dilibatkan. Data ini menegaskan bahwa handover bermutu rendah dapat menormalkan laporan yang “cukup” padahal tidak aman (Kaliraman & Watson, 2025; Yeom et al., 2026).

Sebaliknya, ketika komunikasi diperbaiki melalui bedside handover yang baik, outcome bergerak ke arah yang lebih aman. Daicampi et al. melaporkan bahwa bedside handover berkaitan dengan meningkatnya perceived safety, kepuasan pasien, penurunan kecemasan, pengurangan durasi handover, berkurangnya shift overtime, dan menurunnya nurse call requests. Temuan ini

penting karena memperlihatkan sisi sebaliknya: nilai komunikasi tidak hanya terlihat ketika insiden telah terjadi, tetapi juga ketika pengalaman pasien, koordinasi kerja, dan efisiensi organisasi membaik akibat pencegahan miskomunikasi sejak awal (Daicampi et al., 2025).

4. Integrasi Studi Empiris

Eksplorasi chatbot AI dalam menyelesaikan konflik interprofesional dalam pengaturan perawatan kesehatan mengungkapkan kesenjangan penelitian yang signifikan, seperti yang disorot oleh Wianti, Wijayanti, et al., yang mencatat tidak adanya model AI yang dirancang khusus untuk mediasi konflik klinis. Kesenjangan ini dikuatkan oleh penelitian yang menekankan perlunya alat kolaborasi AI yang disesuaikan dengan lingkungan perawatan kesehatan (Haring et al., 2023). Sementara AI telah diterapkan secara efektif dalam berbagai domain seperti keterlibatan pasien dan pendidikan, perannya dalam resolusi konflik masih belum berkembang (Altamimi et al., 2023). Literatur saat ini menunjukkan bahwa teknik AI, termasuk pemrosesan bahasa alami dan analisis sentimen, telah digunakan untuk deteksi konflik prediktif dan sistem negosiasi yang dimediasi AI, tetapi aplikasi ini terutama difokuskan pada konteks organisasi dan interpersonal daripada pengaturan klinis (Au Yeung et al., 2023). Potensi AI dalam meningkatkan komunikasi antarprofesional diakui, tetapi implementasi praktis dibatasi oleh tantangan seperti bias algoritmik dan kebutuhan akan kerangka etis (J. Zhang & Zhang, 2023). Chatbots AI, meskipun maju dalam kemampuan pemrosesan bahasa alami, belum siap untuk penggunaan klinis karena keterbatasan dalam memahami konteks medis yang kompleks dan masalah etika (Au Yeung et al., 2023; J. Zhang & Zhang, 2023). Selain itu, integrasi AI dalam perawatan kesehatan harus mengatasi masalah kualitas data, transparansi algoritma, dan implikasi etis dari pengambilan keputusan AI untuk memastikan kepercayaan dan efektivitas. Terlepas dari tantangan ini, AI menjanjikan untuk meningkatkan pemberian perawatan kesehatan dengan mendukung pengambilan keputusan klinis dan mengurangi bias kognitif, asalkan dokter dilatih secara memadai untuk menafsirkan keluaran AI dan mengadvokasi keselamatan pasien (Brown et al., 2023). Oleh karena itu, sementara chatbot AI memiliki potensi untuk memediasi konflik antarprofesional, kemajuan signifikan dalam desain AI, tata kelola etis, dan implementasi praktis diperlukan untuk mewujudkan potensi ini dalam pengaturan perawatan kesehatan (Altamimi et al., 2023; Haring et al., 2023; J. Zhang & Zhang, 2023).

G. Strategi Pencegahan Miskomunikasi dan Penguatan Sistem

1. Standardisasi Komunikasi Klinis

Standardisasi komunikasi klinis adalah penggunaan format atau urutan pesan yang disepakati agar informasi penting tidak terlewat, urutan berpikir klinis menjadi konsisten, dan penerima pesan dapat segera mengenali prioritas tindakan. Dalam kerangka TeamSTEPPS, SBAR diposisikan sebagai alat komunikasi terstruktur untuk isu yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera, sedangkan I-PASS diposisikan sebagai alat handoff terstruktur yang makin banyak menjadi pilihan utama untuk transisi pasien. AHRQ juga menekankan bahwa handoff harus memindahkan informasi, otoritas, tanggung jawab, derajat ketidakpastian, dan rencana kontinjensi, serta harus diakhiri dengan pengakuan penerima bahwa tanggung jawab telah diterima (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023c).

Secara evidensial, protokol tidak memiliki kekuatan bukti yang sama. Rapid review (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023b) menyimpulkan bahwa SBAR mungkin memperbaiki luaran klinis, tetapi kepastian buktinya rendah; sebaliknya I-PASS mungkin besar memperbaiki luaran klinis dengan kepastian bukti moderat. Review yang sama juga menunjukkan isu implementasi penting: peningkatan fidelity SBAR yang besar lebih sering tampak pada setting kelas, sedangkan di setting klinis peningkatannya cenderung kecil hingga sedang. Dengan kata lain, manfaat format terstruktur sangat bergantung pada pelatihan, penguatan, observasi, dan monitoring fidelity, bukan hanya pada distribusi formulir atau poster mnemonic (Agency for Healthcare Research and Quality, 2024).

Di layanan gawat darurat dan area dengan alur cepat, protokol yang diadaptasi terhadap konteks sering lebih efektif daripada penggunaan SBAR generik secara kaku. Studi kuasi-eksperimental di IGD menunjukkan model handover modifikasi berbasis checklist mengungguli SBAR pada transfer informasi, shared understanding, working atmosphere, kualitas handover, dan persepsi perawat terhadap handover. Pada transfer pra-rumah sakit ke IGD, uji implementasi ISOBAR (COPTER trial) meningkatkan efisiensi transfer informasi, retensi informasi oleh dokter dan perawat, serta menurunkan kebutuhan pertanyaan setelah handover. Ini menunjukkan bahwa standardisasi yang baik harus tetap kontekstual, terutama pada unit yang sangat cepat, interupsi tinggi, dan kaya informasi seperti ED/ICU (Alizadeh-risani et al., 2024).

Temuan lokal Indonesia juga mendukung arah yang sama. Dalam studi (Handoyo et al., 2022) penggunaan komunikasi efektif SBAR berhubungan positif dengan kualitas pelaksanaan handover pada konteks rawat inap. Walau bukti ini

tidak sekuat review sistematik multisenter, ia penting sebagai penguat relevansi kontekstual di lingkungan praktik Indonesia.

Tabel 6.4 Perbandingan protokol komunikasi klinis terstruktur

Protokol	Komponen inti	Kekuatan bukti	Setting tipikal
SBAR	Situation, Background, Assessment, Recommendation/Request	Rendah–sedang untuk outcome klinis; lebih kuat untuk kejelasan komunikasi	Eskalasi klinis, panggilan ke dokter, situasi deteriorasi
I-PASS	Illness severity, Patient summary, Action list, Situation awareness/contingency, Synthesis by receiver	Moderat untuk outcome klinis menurut AHRQ	Handoff intra-rumah sakit, terutama rawat inap
ISBAR/ISOBAR	Identification + SBAR; sering ditambah read-back	Sedang untuk outcome proses handover	EMS–ED, ICU, area akut
PASS-BAR	Patient, Assessment, Situation, Safety concerns, Background, Action, Recommendation	Sedang untuk outcome pendidikan/performa	Orientasi perawat baru, handoff keperawatan
Closed-loop/check-back	Pesan–konfirmasi penerimaan–verifikasi akhir	Kuat untuk keakuratan pesan; indirect untuk outcome klinis	Resusitasi, obat high-alert, tindakan kritis
Brief–huddle–debrief	Perencanaan awal, penyesuaian saat berjalan, refleksi pasca-kejadian	Baik untuk koordinasi tim dan pembelajaran	Unit akut, kamar operasi, ED, ICU

Secara implementatif, rumah sakit sebaiknya tidak mencoba “satu format untuk semua situasi.” Pendekatan yang lebih aman adalah: SBAR/ISBAR untuk eskalasi kondisi, I-PASS atau protokol handoff lokal untuk pergantian shift/transisi unit, closed-loop untuk order dan tindakan kritis, serta brief–huddle–debrief untuk koordinasi tim dinamis. Inilah bentuk standardisasi yang fleksibel tetapi tetap disiplin (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023c).

2. Penguatan Kompetensi Komunikasi Tenaga Kesehatan

Bukti kompetensi komunikasi antarprofesi membaik paling konsisten ketika pelatihan memadukan mnemonic terstruktur, demonstrasi, praktik aktif, simulasi, dan umpan balik individual. Review sistematis tentang pendidikan handover menemukan bahwa program yang efektif umumnya memasukkan kesempatan praktik, demonstrasi, dan feedback; review lain tentang program simulasi berbasis SBAR menunjukkan manfaat paling konsisten pada communication clarity, meskipun hasil pada self-efficacy, critical thinking, dan patient safety attitudes masih bervariasi (Choi et al., 2024).

Untuk keperawatan, simulasi lebih unggul bila dibandingkan pembelajaran pasif atau case-based learning semata. Pada perawat baru, program PASS-BAR berbasis simulasi tidak menunjukkan keunggulan segera setelah intervensi, tetapi dua minggu kemudian lebih efektif daripada case-based learning dalam meningkatkan handoff competency dan handover performance competency. Dalam studi lain, kombinasi SBAR + mini-CEX meningkatkan kemampuan komunikasi klinis, kemampuan berpikir klinis, mini-CEX rating, dan kepuasan belajar pada mahasiswa profesi keperawatan. Review sistematis tahun 2026 tentang interprofessional simulation juga menunjukkan perbaikan teamwork, role clarity, komunikasi, perilaku terstruktur seperti SBAR dan closed-loop, serta peningkatan self-confidence, leadership, dan safety climate, walaupun efek pada stres, workload, dan perubahan sikap belum seragam (Lim & Kang, 2024).

Pada skenario akut, kualitas latihan harus meniru tekanan nyata. Studi menunjukkan perbaikan signifikan pada leadership communication, namun audit kualitatif masih menemukan masalah delegasi tugas yang kabur, keterlambatan pengenalan perubahan kondisi pasien, dan penggunaan call-out/check-back yang belum konsisten. Temuan ini penting: pelatihan komunikasi tidak boleh berhenti pada "isi pesan," tetapi harus mencakup leadership, situational awareness, role clarity, dan mutual support (Sung & Hsu, 2025).

Refleksi terstruktur juga bernilai sebagai penguat kompetensi. Pada perawat IGD, reflective thinking berhubungan dengan patient safety competency dan efeknya dimediasi oleh patient safety culture; scoping review tahun 2025 juga menunjukkan bahwa praktik reflektif mendukung pengembangan kompetensi klinis, self-awareness, dan transisi ke praktik. Karena itu, debriefing pasca-simulasi dan refleksi pasca-kejadian kritis perlu diposisikan sebagai bagian dari kurikulum komunikasi, bukan aktivitas tambahan yang opsional (Park & Roh, 2024).

Tujuan pembelajaran yang disarankan adalah agar peserta mampu:

- a. menyampaikan handover/eskalasi dengan kelengkapan isi $\geq 90\%$;
- b. menggunakan closed-loop pada seluruh pesan kritis;

- c. mengklarifikasi tanggung jawab, ownership, dan rencana kontinjensi;
- d. melakukan speak-up secara profesional ketika menemukan risiko; dan
- e. melakukan refleksi singkat pasca-insiden atau pasca-simulasi untuk mengidentifikasi gap tim.

Tujuan-tujuan ini merupakan inferensi implementatif dari pola intervensi yang efektif pada review sistematik dan studi simulasi akut (Choi et al., 2024).

Tabel 6.5 Domain kompetensi, metode pelatihan, dan luaran terukur

Domain kompetensi	Metode pelatihan utama	Instrumen/asesmen yang disarankan	Luaran terukur
Komunikasi terstruktur	Workshop SBAR/ISBAR/I-PASS + role play	Checklist kelengkapan isi, audit handoff	% item lengkap, omission rate
Closed-loop dan read-back	Simulasi akut, drill order kritis	Observasi langsung, checklist closed-loop	% pesan kritis dengan read-back
Handoff antarprofesi	Simulasi pergantian shift/transisi unit	mini-CEX/handoff-CEX, observasi bedside	Skor performa handoff, self-efficacy
Situational awareness	Simulasi dengan deterioration cues	TEAM atau Team Performance Observation Tool	Eskalasi tepat waktu, identifikasi risiko
Speak-up dan psikologis aman	Debrief, scripted advocacy, latihan CUS/escalation	Survei communication openness/psychological safety	Speak-up rate, perceived safety
Refleksi dan pembelajaran tim	Debrief terstruktur, reflective writing singkat	Rubrik refleksi, action log	Kualitas refleksi, action completion rate

Secara kurikuler, pola yang paling rasional untuk rumah sakit adalah: orientasi awal, simulasi ulang berkala, audit observasional singkat di unit, dan debrief pasca-insiden/pasca-simulasi. Sebagai rekomendasi operasional, rumah sakit dapat menerapkan pelatihan dasar saat orientasi, booster triwulanan, serta micro-drills pada unit berisiko tinggi. Ini merupakan rekomendasi inferensial yang didasarkan pada fakta bahwa efek terbaik muncul ketika komunikasi dilatih berulang, diamati, dan diberi umpan balik (Choi et al., 2024).

3. Budaya Keselamatan dalam Organisasi kesehatan

Budaya keselamatan pasien adalah sejauh mana nilai, keyakinan, norma, dan perilaku dalam organisasi mendukung keselamatan pasien. AHRQ menegaskan bahwa budaya ini terukur melalui apa yang “dihargai, didukung, diharapkan, dan

diterima” dalam organisasi, dengan domain inti meliputi komunikasi tentang error, communication openness, organizational learning, teamwork, support dari manajer, staffing, dan work pace. WHO menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas sistem, sementara The Joint Commission menuntut pimpinan untuk mengukur budaya keselamatan secara berkala, memiliki code of conduct, dan menangani perilaku intimidatif (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023d).

Data AHRQ 2024 memberi sinyal yang sangat relevan untuk pencegahan miskomunikasi. Pada benchmark rumah sakit yang berpartisipasi, communication openness rata-rata berada pada 77%, tetapi handoffs and information exchange hanya 65%, response to error 64%, dan staffing and work pace 55%. Secara operasional, ini berarti organisasi sering merasa “cukup terbuka untuk berbicara,” tetapi masih lemah dalam transisi informasi, respons adil terhadap kesalahan, dan pengendalian beban kerja—tiga area yang langsung berkontribusi pada miskomunikasi (SOPS User Network, 2024).

Dari perspektif sentinel event, pola ini konsisten. Review tahunan The Joint Commission untuk 2024 menunjukkan bahwa faktor kontributor yang berulang meliputi lack of shared understanding, no or inadequate communication of critical information, vague or unclear roles and responsibilities, task fixation, dan task saturation/cognitive load. Ini menunjukkan bahwa miskomunikasi jarang berdiri sendiri; ia biasanya berkelindan dengan struktur tim yang kabur, tekanan kerja, dan kegagalan membentuk shared mental model (The Joint Commission., 2025).

Dimensi psikologis sangat penting, tetapi tidak boleh disederhanakan. Review sistematis-naratif Montgomery dkk. (2025) menemukan hubungan yang kompleks antara psychological safety dan patient safety: beberapa studi menunjukkan hubungan positif yang nyata, tetapi tingkat pelaporan error yang tinggi juga dapat berarti psychological safety yang lebih baik, bukan kinerja yang lebih buruk. Dengan kata lain, peningkatan laporan near miss pada fase awal intervensi dapat menjadi tanda budaya belajar yang membaik, bukan kegagalan program. Penyelidikan kualitatif Zajac dkk. (2025) juga menegaskan bahwa teamwork berkualitas tinggi bertumpu pada psychological safety, terutama agar staf berani mengangkat kekhawatiran tanpa takut dipermalukan atau dibalas (Montgomery et al., 2025).

Karena itu, strategi membangun speak-up culture perlu bersifat struktural: respons non-punitif terhadap error, umpan balik tertutup dari insiden ke perbaikan, leadership walk rounds, daily safety huddles, dan perlindungan dari perilaku intimidatif. WHO juga menekankan bahwa sistem pelaporan dan

pembelajaran hanya akan berfungsi bila staf titik layanan terlindungi dari blame dan retribution serta dilibatkan dalam tindak lanjut perbaikan (Kumah, 2025).

4. Peran Kepemimpinan dalam Komunikasi Tim

Kepemimpinan adalah pengungkit sistem yang membuat protokol komunikasi benar-benar digunakan. Review sistematis terbaru menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, terutama transformational, ethical, dan dalam beberapa studi juga transactional leadership, berasosiasi positif dengan teamwork, komunikasi, organizational learning, feedback, dan persepsi keselamatan. Review tersebut juga menegaskan bahwa faktor penguat meliputi organizational commitment, pendidikan/pelatihan, job resources, work engagement, dan mentorship (Althobaiti, 2026).

Pada level unit, dampak kepemimpinan terlihat pada praktik sehari-hari. Studi Hamdan dkk. (2024) menunjukkan bahwa transformational leadership berasosiasi positif dengan nursing safety practices, dengan patient safety culture berperan sebagai mediator. Dalam unit gawat darurat, Labrague (2024) juga melaporkan bahwa persepsi terhadap transformational leadership berhubungan dengan lebih sedikit adverse patient events yang dilaporkan dan kualitas asuhan yang lebih baik. Secara konseptual, ini berarti pemimpin yang jelas, suportif, dan mudah diakses meningkatkan keberanian staf untuk bertanya, mengklarifikasi, dan mengeskalasi risiko (Hamdan et al., 2024).

Peran konkret pemimpin bukan sekadar “memberi motivasi.” Pemimpin perlu: menetapkan format komunikasi baku; menyediakan protected time untuk handover, brief, dan huddle; memastikan staffing memadai; melindungi staf yang melakukan speak-up; menjalankan audit komunikasi; serta memberi umpan balik yang cepat dan non-punitif. Joint Commission secara eksplisit menekankan kewajiban pimpinan untuk mengukur budaya keselamatan, mengembangkan visi dan tujuan keselamatan, serta menegakkan code of conduct yang menahan perilaku intimidatif.

Dalam konteks keperawatan Indonesia, poin ini penting karena banyak kegagalan komunikasi bukan disebabkan ketidaktahuan format, melainkan karena tidak tersedianya ruang aman dan waktu operasional untuk menjalankannya. Karena itu, kepala ruangan dan manajer keperawatan harus dipahami sebagai “desainer lingkungan komunikasi,” bukan hanya pengawas kepatuhan administratif (*National Performance Goal #2: Culture of Safety / Joint Commission*, n.d.).

Alat operasional dan evaluasi

Template SBAR + checklist keperawatan

Identitas: nama petugas, unit, pasien, waktu handover/eskalasi, penerima pesan.

Situation: masalah utama saat ini; tingkat urgensi; perubahan terbesar sejak evaluasi terakhir.

Background: diagnosis kerja, alergi, code status, terapi aktif, alat/akses invasif, obat high-alert, hasil pemeriksaan penting.

Assessment: tanda vital dan tren, skor EWS/NEWS bila digunakan, nyeri, status neurologis/respirasi/hemodinamik, risiko jatuh/ulkus tekan/infeksi, hal yang paling dikhawatirkan.

Recommendation/Request: tindakan yang diminta, target waktu, siapa penanggung jawab, contingency plan bila kondisi memburuk, pemeriksaan/obat yang masih tertunda.

Checklist penutup: read-back dilakukan; ownership jelas; pending task dicatat; risiko kritis disebut ulang; keluarga/pasien concern penting sudah disampaikan.

Outline skenario simulasi singkat

Kasus: pasien sepsis di bangsal memburuk 30 menit sebelum pergantian shift.

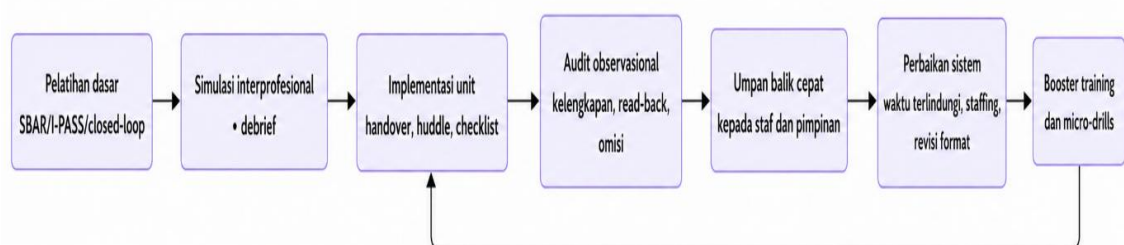
Peserta: perawat primer, charge nurse, dokter jaga, apoteker.

Trigger: NEWS meningkat, kultur belum diambil, antibiotik high-alert belum diberikan, keluarga cemas.

Perilaku yang diharapkan: eskalasi SBAR, closed-loop pada order kritis, huddle singkat, klarifikasi ownership, dokumentasi ringkas.

Debrief fokus pada: kelengkapan isi, kejelasan prioritas, read-back, speak-up, dan shared mental model.

Proses implementasi yang disarankan adalah siklus pelatihan–implementasi–audit–umpan balik berikut. Siklus ini konsisten dengan pendekatan TeamSTEPPS, debrief AHRQ, dan action planning berbasis SOPS (Agency for Healthcare Research and Quality, 2023a).



Gambar 6.1

Indikator audit dan KPI yang disarankan dapat dibuat ringkas namun bermakna: persentase handover dengan seluruh elemen inti lengkap; persentase

pesan kritis dengan read-back; jumlah omission item kritis per 100 handover ketepatan waktu eskalasi pasien memburuk; kepatuhan huddle harian; skor TeamSTEPPS T-TPQ/observational tool; skor AHRQ SOPS untuk communication openness, handoffs and information exchange, response to error, dan staffing/work pace; serta jumlah laporan near miss yang diikuti umpan balik/perbaikan tertutup. KPI ini sebaiknya dipantau bulanan pada level unit dan dilaporkan triwulanan pada level organisasi (for Healthcare Research, n.d.).

Rubrik penilaian sederhana untuk pelatihan dapat menggunakan empat domain: kelengkapan isi, prioritas klinis, closed-loop/read-back, dan ownership–contingency planning; masing-masing dinilai 1–4 dari “tidak tampak” sampai “konsisten dan mandiri.” Pendekatan ini sejalan dengan penggunaan observasi langsung, TEAM, dan mini-CEX pada studi pelatihan akut (Sung & Hsu, 2025).

H. Transformasi Komunikasi Klinis di Era Digital

1. Perkembangan Teknologi dalam Komunikasi Kesehatan

Health Information Systems (HIS) adalah payung sistem digital yang menangkap, menyimpan, mengolah, dan menukar data klinis maupun administratif untuk mendukung layanan pasien, perencanaan sumber daya, dan manajemen kesehatan populasi. Di dalam payung HIS, Electronic Medical Records (EMR) berfungsi lebih sempit sebagai inti dokumentasi klinis pasien—tempat catatan asesmen, order, hasil pemeriksaan, terapi, dan tindak lanjut direkam serta diakses tim. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa arsitektur HIS bergerak ke model modular, service-based, dan microservices, sedangkan interoperabilitas makin bergantung pada kontrak data yang stabil agar pertukaran informasi tidak berhenti pada level “bisa dikirim” tetapi juga “bisa dipahami dan dipakai” oleh profesi lain (Casanova et al., 2025; Gazzarata et al., 2024).

Dalam konteks interoperabilitas, HL7 menyediakan kerangka standar pertukaran informasi kesehatan, sedangkan FHIR memecah data menjadi “resources” yang dapat dipertukarkan melalui RESTful API dalam format yang lebih fleksibel dan dapat dibaca mesin. Secara praktis, ini penting untuk komunikasi antarprofesi karena data laboratorium, obat, problem list, discharge summary, maupun care plan dapat ditarik ke sistem lain tanpa pengetikan ulang, sehingga mengurangi data silos dan memperbaiki shared situational awareness tim (Nan & Xu, 2023).

Digitalisasi juga mengubah dinamika komunikasi tim. Scoping review tentang interaksi antarprofesi yang didukung teknologi menunjukkan bahwa rekam bersama, shared care plans, dan kanal digital memperbaiki kecepatan,

kejelasan, dan kontinuitas komunikasi, bahkan dalam beberapa konteks membantu “meratakan” hierarki karena semua profesi melihat sumber informasi yang sama. Namun, manfaat ini cepat hilang ketika sistem tidak sesuai alur kerja, tidak cukup jelas, atau terlalu menambah klik dan beban dokumentasi (Sauter et al., 2025).

Meski demikian, EMR tidak otomatis identik dengan keselamatan. Studi kualitatif pada tenaga kesehatan menunjukkan EHR sering dipersepsi sebagai “pedang bermata dua”: memudahkan akses informasi dan keselamatan, tetapi juga menambah beban administratif, technostress, dan gangguan dinamika tim. Survei nasional dokter pada 2025 bahkan melaporkan lebih dari separuh responden tidak merasa EMR mereka meningkatkan keselamatan pasien, dengan penilaian usability rata-rata hanya sekitar separuh skor maksimum. Di sisi lain, risiko kebocoran data menambah dimensi keselamatan baru, yakni potensi identity theft, extortion, dan hilangnya kepercayaan pasien terhadap sistem (Looi et al., 2024; Provenzano et al., 2024).

Tabel 6.6 Perbandingan HIS dan EMR dalam komunikasi klinis

Aspek	HIS	EMR
Cakupan	Ekosistem luas: klinis, administratif, finansial, pelaporan, koordinasi layanan	Sub-sistem inti untuk dokumentasi dan akses data pasien
Arsitektur dominan	Modular, service-based, microservices, cloud/distributed ecosystem	Sering menjadi “hub” dokumentasi dalam HIS atau platform EHR
Peran dalam komunikasi tim	Memungkinkan shared dashboards, care coordination, rujukan, discharge planning, dan pertukaran data lintas unit	Menyediakan sumber data klinis yang sama untuk dokter, perawat, farmasis, dan profesi lain
Manfaat utama	Kontinuitas asuhan, integrasi proses, efisiensi organisasi, visibilitas lintas profesi	Akses cepat ke riwayat pasien, legibilitas, standardisasi dokumentasi, dukungan keputusan
Risiko utama	Fragmentasi antarplatform, biaya integrasi, celah keamanan, interoperabilitas semu	Usability buruk, technostress, beban dokumentasi, alert overload, kebocoran data

Aspek	HIS	EMR
Best practice implementasi	Open standards, governance lintas unit, desain modular, evaluasi berkelanjutan	User-centered design, workflow fit, pelatihan bertahap, super-user, audit keselamatan

Secara implementatif, praktik terbaik yang paling konsisten dalam literatur adalah: keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal, komunikasi perubahan yang kuat, pelatihan yang waktunya tepat, dukungan teknis berkelanjutan, evaluasi usability, penggunaan open standards, dan penyelarasan sistem dengan alur kerja nyata. Dengan kata lain, mutu komunikasi digital lebih ditentukan oleh desain sosioteknis daripada oleh kecanggihan software semata (Finnegan & Mountford, 2025).

2. Telehealth dan Komunikasi Virtual

Telehealth mencakup beberapa modalitas: video sinkron, telepon, portal pasien, pesan teks asinkron, e-consult antarklinisi, serta pemantauan jarak jauh yang terhubung ke sistem klinis. Dari sudut komunikasi, kekuatan utama telehealth terletak pada akses, kecepatan, dan kontinuitas. Ia memungkinkan tindak lanjut lebih dekat, mengurangi waktu tunggu dan perjalanan, serta mendukung koordinasi lintas titik layanan saat pasien berpindah dari rumah ke klinik atau rumah sakit (Sauter et al., 2025).

Namun, komunikasi non-tatap muka memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Studi kualitatif pada konsultasi virtual di layanan primer menunjukkan tantangan berupa gangguan mutual understanding, kesulitan menangkap nuansa, dan kebutuhan tailoring sesuai jenis pasien serta konteks masalah. Narrative review tentang nonverbal behavior juga menegaskan bahwa peran tatapan, ekspresi wajah, gesture, head movement, proxemics, dan postur belum tergantikan sepenuhnya dalam telehealth; justru aspek-aspek inilah yang sering menopang empati, kepercayaan, dan keselamatan ketika klinisi menilai ketidakpastian (Alboksmaty et al., 2026; Duffy & Benotsch, 2025)

Di sisi lain, telehealth tidak selalu lebih “dingin”. Studi pilot pada layanan primer menemukan skor empati dan komunikasi sensitif budaya yang sebanding antara telemedicine dan kunjungan langsung. Artinya, problem utama bukan sekadar medianya, melainkan apakah klinisi mampu mengadaptasi perilaku komunikasinya: berbicara lebih eksplisit, memberi jeda, memeriksa pemahaman, dan menggunakan teach-back serta safety-netting ketika informasi klinis masih belum lengkap. (Subramanya et al., 2024)

Konteks Indonesia menunjukkan dinamika yang serupa. Studi kualitatif tentang integrated patient progress notes di rumah sakit pendidikan Sumatera Barat memperlihatkan bahwa dokumentasi digital berpotensi menjadi alat kolaborasi antarprofesi dalam discharge planning, tetapi efektivitasnya dibatasi oleh standardisasi yang belum konsisten, aksesibilitas, kejelasan dokumentasi, literasi digital, dan dukungan organisasi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi virtual dan dokumentasi digital tidak bisa dipisahkan dari budaya tim dan kapasitas institusi (Delima et al., 2026).

Tabel 6.7 Modalitas telehealth, peluang, dan tantangan komunikasi

Modalitas	Peluang utama	Tantangan komunikasi
Video sinkron	Mendekati tatap muka; mendukung follow-up, edukasi, dan konferensi multidisiplin	Kualitas audio/video, kelelahan layar, nonverbal tetap terbatas
Telepon/audio	Cepat, murah, berguna untuk triase atau follow-up singkat	Tidak ada visual; lebih rawan miskomunikasi dan ambiguity
Portal pasien/pesan asinkron	Fleksibel, terdokumentasi, memudahkan koordinasi lintas waktu	Delay respons, risiko salah tafsir, emotional tone sulit terbaca
e-Consult antarklinisi	Mempercepat konsultasi spesialis, menurunkan hambatan geografis	Ringkasan data bisa tidak lengkap; risiko overreliance pada teks
Remote monitoring	Memperkuat continuity of care dan deteksi dini	Data overload, konteks pasien terbatas, perlunya respons protokol jelas

3. Artificial Intelligence dalam Komunikasi Antarprofesi

Dalam praktik klinis, AI mulai memasuki komunikasi antarprofesi melalui empat jalur utama: koordinasi alur kerja, dukungan keputusan klinis, peringkasan/drafting dokumentasi, dan chatbots/conversational agents. Bukti real-world yang relatif paling menjanjikan datang dari platform AI-MDT untuk kanker paru di rumah sakit tersier di Tiongkok (Delima et al., 2026). Platform ini mengintegrasikan otomasi persiapan kasus, decision support berbasis evidence, dan bantuan diagnostik; setelah implementasi, volume konsultasi meningkat,

waktu pakar berkurang, dan efisiensi rapat MDT membaik dibanding MDT tradisional. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada pada diskusi minimal lima spesialis senior dan review klinisi utama, sehingga model yang terbukti bukan “AI menggantikan tim”, melainkan “AI memperkuat tim”. (Y. Liu et al., 2026)

Pada area pelatihan komunikasi antarprofesi, mixed-method study pada mahasiswa keperawatan menunjukkan bahwa AI-enabled virtual reality simulation meningkatkan pengetahuan komunikasi dan self-efficacy komunikasi interprofesional, serta dinilai feasible dan acceptable. Temuan ini penting bagi pendidikan keperawatan karena menunjukkan bahwa AI dapat dipakai untuk membangun kesiapan komunikasi sebelum masuk setting high-risk yang sebenarnya. Tetapi bukti ini masih berada pada fase pendidikan/simulasi, belum pada outcome klinis pasien (Liaw et al., 2023).

Bila melihat praktik lapangan yang lebih luas, adopsi GenAI oleh dokter sudah bergerak cepat. Survei GP di Inggris menunjukkan penggunaan GenAI dalam praktik klinis meningkat dari 20% pada 2024 menjadi 25% pada 2025. Penggunaan yang paling sering adalah drafting dokumentasi pascakonsultasi, dukungan differential diagnosis, opsi terapi, dan rujukan; mayoritas pengguna merasa alat ini menurunkan beban kerja, tetapi sebagian besar juga melaporkan ketiadaan pelatihan formal dan kurangnya kebijakan kerja yang jelas. Studi kualitatif lanjutan memperlihatkan bahwa klinisi melihat nilai GenAI terutama pada tugas administratif dan penalaran awal, sembari tetap mengkhawatirkan akurasi, privasi, bias, dan regulasi (C. Blease, Garcia Sanchez, et al., 2025; C. Blease, Hagström, et al., 2025; C. R. Blease et al., 2024).

Pada conversational agents, systematic review dan meta-analysis menemukan bahwa communication competence misalnya empati, personalization, contingency, open-ended questions, explanation, dan partnership berdampak kecil hingga sedang pada evaluasi pengguna dan luaran psikologis, tetapi belum menunjukkan bukti kuat terhadap health outcomes. Ini berarti kualitas “cara AI berkomunikasi” memang penting, namun belum cukup untuk menyatakan bahwa chatbot otomatis memperbaiki hasil klinis atau kolaborasi tim (Qin et al., 2025).

Bukti untuk dokumentasi dan pesan klinis juga menggambarkan pola yang serupa: menjanjikan tetapi belum matang. Studi mixed-method di gawat darurat anak menunjukkan ChatGPT dapat mempersingkat waktu penulisan ringkasan klinis sekitar 40% pada kasus yang kompleks dan mendapat penilaian baik untuk handoff terstruktur, tetapi sampelnya kecil dan masih proof-of-concept. Studi real-world audit log pada sistem kesehatan besar di New York menunjukkan penggunaan draft respons yang dibuat GenAI terhadap pesan pasien hanya

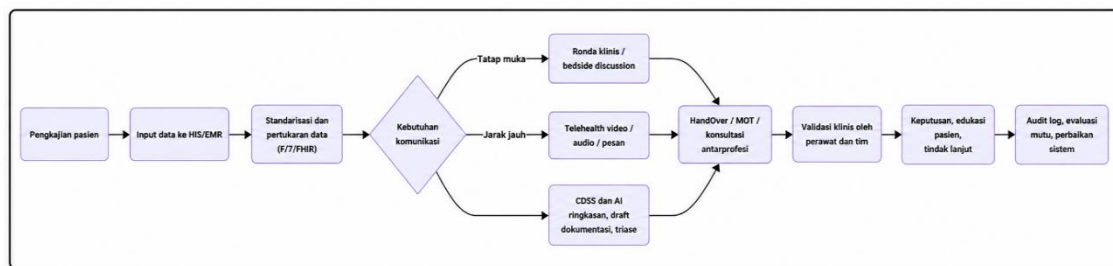
sekitar 19,4%, meski ada penurunan waktu penyelesaian pesan sekitar 6,76%; artinya, manfaat sangat bergantung pada kualitas draft dan kecocokan dengan workflow. Sementara itu, scoping review tentang handover rawat inap secara eksplisit menyatakan belum ada implementasi klinis AI yang berhasil dilaporkan untuk memperbaiki handover (Barak-Corren et al., 2024; Mandal et al., 2025).

Chatbot juga bisa berfungsi sebagai pendamping keputusan pada kasus kompleks, tetapi belum layak menjadi sumber tunggal. Studi komparatif pada pasien bedah mulut kompleks melaporkan sebagian besar respons chatbot berkualitas tinggi dan cukup akurat, namun peneliti tetap menekankan keterbatasan klinis, risiko bias data pelatihan, dan perlunya validasi profesional. Karena itu, posisi yang paling rasional untuk keperawatan saat ini adalah memandang AI sebagai alat bantu konseptual, bukan otoritas komunikasi klinis (Şişman & Acar, 2025).

Tabel 6.8 AI untuk komunikasi antarprofesi dan komunikasi klinis: jenis alat, tingkat bukti, dan keterbatasan

Jenis alat AI	Fungsi komunikasi	Tingkat bukti mutakhir	Keterbatasan utama
AI-enabled virtual simulation	Melatih handover, komunikasi kritis, dan koordinasi tim	Mixed-method study pendidikan	Belum menunjukkan outcome pasien; konteks simulasi
AI-MDT platform	Menyiapkan kasus, memberi evidence-based recommendations, mendukung rapat MDT	Implementasi real-world sebelum-sesudah, single center	Generalisasi terbatas; perlu validasi lintas institusi
GenAI summarization/drafting	Menyusun summary, handoff draft, pesan klinis	Proof-of-concept dan observational studies	Utilisasi rendah; risiko hallucination; masih perlu review manusia
Clinical chatbot untuk decision support	Menjawab pertanyaan klinis kompleks	Comparative study	Akurasi tidak konsisten; tidak layak sebagai sumber tunggal
Health conversational agents	Mendukung interaksi berbasis empati/personalization	Systematic review & meta-analysis	Efek pada health outcomes belum kuat

Jenis alat AI	Fungsi komunikasi	Tingkat bukti mutakhir	Keterbatasan utama
AI untuk handover rawat inap	Potensial merangkum data lintas profesi	Scoping review	Belum ada implementasi klinis AI yang berhasil dilaporkan



Alur ini menegaskan bahwa alat digital idealnya masuk sebagai enabler di setiap simpul kerja dokumentasi, pertukaran data, konsultasi, handover, dan evaluasi mutu tetapi simpul validasi manusia tetap menjadi pengaman terakhir keselamatan pasien.

4. Tantangan Etik dan Humanisasi Komunikasi Digital

Empat isu etik paling sentral adalah persetujuan dan transparansi, bias algoritmik, akuntabilitas klinis, dan tata kelola data. Studi kualitatif tentang integrasi AI ke praktik klinis menunjukkan bahwa pertanyaan dokter sehari-hari berpusat pada AI scribes, privasi dan keamanan data, consent pasien, kepemilikan data, ketidakjelasan regulasi, tanggung jawab medikolegal, dan kekhawatiran akan akurasi serta bias. Review etika AI di layanan kesehatan juga merekomendasikan cybersecurity yang kuat, sistem consent yang transparan, pilot dalam workflow nyata, dan desain yang berpusat pada manusia untuk mencegah AI menjadi beban baru (Mostafapour et al., 2026; Oleribe et al., 2025).

Humanisasi komunikasi digital menuntut lebih dari sekadar “nada sopan.” Konsep digital empathy dalam keperawatan menekankan autentisitas, pembentukan trust, efektivitas komunikasi, emotional engagement, adaptability, technological proficiency, dan cultural sensitivity. Pada praktiknya, ini berarti perawat perlu menata kehadiran virtual secara sengaja: menyebut nama pasien, menjelaskan keterbatasan media, memeriksa pemahaman, mengakui emosi, dan tetap membuka jalan ke interaksi tatap muka ketika medium digital tidak lagi memadai (Abou Hashish, 2025).

Karena itu, strategi humanisasi terbaik adalah *hybridization with safeguards*: AI dan *telehealth* dipakai untuk mempercepat, memperjelas, dan mendokumentasikan komunikasi; sedangkan penilaian kompleks, *disclosure of uncertainty*, negosiasi keputusan, dan relasi terapeutik dipastikan tetap memiliki komponen manusia yang kuat. Bukti tentang *nonverbal cues*, empati *telemedicine*, dan keterbatasan tool digital menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas jangkauan pelayanan, tetapi belum mampu menggantikan kualitas relasional yang dibangun melalui kehadiran klinis, suara manusia, timing, dan kepekaan etik profesional (Duffy & Benotsch, 2025; Subramanya et al., 2024).

Pedoman praktis untuk perawat

Agar implementasi komunikasi digital aman sekaligus tetap empatik, perawat dapat menggunakan pedoman berikut.

- a. Gunakan hanya platform yang terintegrasi dengan HIS/EMR resmi institusi; hindari memasukkan data pasien ke chatbot publik yang tidak berada dalam governance organisasi (Finnegan & Mountford, 2025).
- b. Pastikan identitas pasien, lokasi, privasi ruang, dan persetujuan terhadap penggunaan *telehealth* atau alat AI dijelaskan di awal interaksi (Mostafapour et al., 2026)
- c. Dokumentasikan keterbatasan komunikasi virtual, termasuk bila pemeriksaan fisik tidak lengkap atau ada keraguan klinis yang memerlukan tatap muka (Alboksmaty et al., 2026).
- d. Terapkan digital empathy: sapaan personal, bahasa sederhana, jeda untuk respons, kamera sejajar mata, validasi emosi, dan teach-back di akhir percakapan (Abou Hashish, 2025).
- e. Perlakukan output AI sebagai draft atau second reader, bukan keputusan final; lakukan verifikasi klinis sebelum disimpan, dikirim, atau digunakan untuk handover (Şişman & Acar, 2025).
- f. Pada komunikasi antarprofesi, gunakan template terstandar dan shared record agar semua profesi merujuk pada sumber data yang sama (Nan & Xu, 2023).
- g. Laporkan insiden usability, alert fatigue, missing data, dan near miss sebagai bagian dari patient safety reporting, karena risiko digital sering muncul dari desain sistem, bukan semata dari kompetensi individu (Schwappach et al., 2025).
- h. Dorong pelatihan berkala, simulasi, dan kehadiran super-user/unit champion agar transformasi digital tidak menambah miskomunikasi baru (Finnegan & Mountford, 2025).

I. Penutup

Komunikasi kolaboratif antarprofesi merupakan elemen fundamental dalam menjamin keselamatan pasien di sistem pelayanan kesehatan modern yang kompleks. Keterlibatan berbagai tenaga kesehatan dalam satu rangkaian asuhan menuntut adanya pertukaran informasi yang jelas, terstruktur, dan berkesinambungan. Berbagai bukti menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien, terutama pada titik-titik kritis seperti handover, pengambilan keputusan klinis, dan situasi kegawatdaruratan. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam menjaga kesinambungan asuhan dan mencegah kesalahan klinis.

Dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan secara umum, komunikasi harus dipahami sebagai kompetensi yang bersifat ganda, yaitu kompetensi klinis dan relasional. Sebagai kompetensi klinis, komunikasi menuntut kemampuan menyampaikan informasi secara sistematis, akurat, dan berbasis prioritas, seperti melalui pendekatan SBAR. Sementara itu, sebagai kompetensi relasional, komunikasi mencakup aspek empati, keterbukaan, dan kemampuan membangun hubungan profesional yang saling percaya antar tenaga kesehatan maupun dengan pasien. Integrasi kedua aspek ini menjadi kunci dalam menciptakan kerja tim yang efektif, meningkatkan kualitas interaksi, serta mendukung pengambilan keputusan yang aman dan tepat.

Ke depan, pengembangan praktik komunikasi dalam pelayanan kesehatan perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi tim, pemanfaatan teknologi, serta humanisasi layanan. Kolaborasi antarprofesi harus terus diperkuat melalui budaya komunikasi terbuka dan partisipatif. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti rekam medis elektronik, telehealth, dan kecerdasan buatan memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi komunikasi. Namun, transformasi ini harus tetap diimbangi dengan pendekatan humanistik agar nilai empati, hubungan interpersonal, dan komunikasi terapeutik tidak hilang. Dengan demikian, komunikasi kolaboratif tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Referensi

- Abou Hashish, E. A. (2025). Compassion through technology: Digital empathy concept analysis and implications in nursing. *Digital Health*, 11. <https://doi.org/10.1177/20552076251326221>
- Abraham, S. A., Nsatimba, F., Agyare, D. F., Agyeiwaa, J., Opoku-Danso, R., Ninnoni, J. P., Doe, P. F., Kuffour, B. O., Anumel, B. K., Berchie, G. O., Boso, C. M., Druye, A. A., Okantey, C., Owusu, G., Obeng, P., Amoadu, M., & Commey, I. T. (2024). Barriers and outcomes of therapeutic communication between nurses and patients in Africa: a scoping review. *BMC Nursing* 2024 23:1, 23(1), 362-. <https://doi.org/10.1186/S12912-024-02038-0>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023). Section 2: Explanation of Key Concepts and Tools | Agency for Healthcare Research and Quality. <https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/curriculum/situation/tools/index.html>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023a). TeamSTEPPS 3.0 . 2023. <https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/index.html>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023b). Tool: Closed-Loop Communication | Agency for Healthcare Research and Quality. 2025. <https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/curriculum/communication/tools/loop.html>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023c). Tool: SBAR. 2023. <https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/curriculum/communication/tools/sbar.html>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023d). What Is Patient Safety Culture? . 2023. <https://www.ahrq.gov/sops/about/patient-safety-culture.html>
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2024). Making Healthcare Safer IV_Rapid Review: Use of Structured Handoff Protocols for Intrahospital Within-Unit Transitions.
- Ahmed, W. E., Fakhry, S. F., & Mohamed Badran, F. M. (2025). Bedside handover training and its effects on nurses' knowledge and compliance. *BMC Nursing* 2025 24:1, 24(1), 1472-. <https://doi.org/10.1186/S12912-025-04075-9>
- Ainun Shafira, R., & Dhamanti, I. (2023). A Literature Review: Implementation of SBAR Communication in The Implementation of Patient Safety in Hospital in Indonesia (Study in Indonesia. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 441–452. <https://doi.org/10.20473/MGK.V12I1.2023.441-452>
- Albar, I. A., Linuwih, S., Menaldi, S. W., & Findyartini, A. (2025). Role of Debriefing in Trauma Simulation Training to Improve Trauma Team Performance in Emergency Department ARTICLE INFO. *Journal*, 17(4), 117.

<https://doi.org/10.21315/eimj2025.17.4.8>

- Alboksmaty, A., Lunova, T., Darzi, A., & Neves, A.-L. (2026). Communication Challenges and Mitigation Strategies in Primary Care Virtual Consultations: Qualitative Study. *Journal of Medical Internet Research*, 28(1), e79399–e79399. <https://doi.org/10.2196/79399>
- Alizadeh-risani, A., Mohammadkhah, F., Pourhabib, A., Fotokian, Z., & Khatooni, M. (2024). Comparison of the SBAR method and modified handover model on handover quality and nurse perception in the emergency department: a quasi-experimental study. *BMC Nursing* 2024 23:1, 23(1), 585-. <https://doi.org/10.1186/S12912-024-02266-4>
- Alnaji, I. A. J., & Alkhaldi, A. S. M. (2024). The Integral Role of Nursing Informatics in Enhancing Patient Outcomes through the Integration of Health Information Systems in Clinical Practice: Review. *Saudi Journal of Medicine and Public Health*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.64483/JMPH-15>
- Altamimi, I., Altamimi, A., Alhumimidi, A. S., Altamimi, A., & Temsah, M.-H. (2023). Artificial Intelligence (AI) Chatbots in Medicine: A Supplement, Not a Substitute. *Cureus*, 15(6), 40922. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.40922>
- Althobaiti, F. M. (2026). The effects of leadership on patient safety culture in health care: a systematic review. *BMC Nursing* 2025 25:1, 25(1), 125-. <https://doi.org/10.1186/S12912-025-04263-7>
- Anshasi, H., & Almayasi, Z. A. (2024). Perceptions of Patients and Nurses about Bedside Nursing Handover: A Qualitative Systematic Review and Meta-Synthesis. *Nursing Research and Practice*, 2024(1), 3208747. <https://doi.org/10.1155/2024/3208747>
- Arda, D., & Suprpto, S. (2023). Therapeutic Communication Skills of Nursing Students in Clinical Practice. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 346–352. <https://doi.org/10.35816/JISKH.V12I2.1088>
- Argote, L., Guo, J., Haan, K.-W., Rosengart, M. R., Teng, C. Y., & Kahn, J. M. (2025). Transactive Memory Systems and Hospital Trauma Team Performance: Shared Experience in Action Teams. *Organization Science* (Providence, R.I.). <https://doi.org/10.1287/ORSC.2024.19022>
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2018). *Interpersonal Relationships - 8th Edition*. In Elsevier. Elsevier. <https://shop.elsevier.com/books/interpersonal-relationships/arnold/978-0-323-54480-1>
- Atinga, R. A., Gmaligan, M. N., Ayawine, A., & Yambah, J. K. (2024). "It's the patient that suffers from poor communication": Analyzing communication gaps and associated consequences in handover events from nurses' experiences. *SSM - Qualitative Research in Health*, 6.

<https://doi.org/10.1016/J.SSMQR.2024.100482>

- Au Yeung, J., Kraljevic, Z., Luintel, A., Balston, A., Idowu, E., Dobson, R. J., & Teo, J. T. (2023). AI chatbots not yet ready for clinical use. *Frontiers in Digital Health*, 5. <https://doi.org/10.3389/FDGTH.2023.1161098>
- Barak-Corren, Y., Wolf, R., Rozenblum, R., Creedon, J. K., Lipsett, S. C., Lyons, T. W., Michelson, K. A., Miller, K. A., Shapiro, D. J., Reis, B. Y., & Fine, A. M. (2024). Harnessing the Power of Generative AI for Clinical Summaries: Perspectives From Emergency Physicians. *Annals of Emergency Medicine*, 84(2), 128–138. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38483426/>
- Bender, J. A., Thiagarajan, S., Morrish, W., Mims, M., & Yackel, E. E. (2025). A Framework for the Analysis of Communication Errors in Health Care. *Journal of Patient Safety*, 21(2), 69–81. <https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000001303>
- Binaj, D., Babić, S., & Ješić, V. (2025). SBAR metoda kao alat za unapređenje timske suradnje i sigurnosti pacijenata u zdravstvenoj skrbi. *Sestrinski Glasnik*, 30(3), 163–167. <https://doi.org/10.11608/SGNJ.30.3.3>
- Blease, C., Garcia Sanchez, C., Locher, C., McMillan, B., Gaab, J., & Torous, J. (2025). Generative Artificial Intelligence in Primary Care: Qualitative Study of UK General Practitioners' Views. *Journal of Medical Internet Research*, 27(1). <https://doi.org/10.2196/74428>
- Blease, C., Hagström, J., Sanchez, C. G., Kharko, A., McMillan, B., Gaab, J., Brulin, E., Locher, C., Hägglund, M., Riggare, S., & Mandl, K. D. (2025). General practitioners' adoption of generative artificial intelligence in clinical practice in the UK: An updated online survey. *Digital Health*, 11. <https://doi.org/10.1177/20552076251394287>
- Blease, C. R., Locher, C., Gaab, J., Hägglund, M., & Mandl, K. D. (2024). Generative artificial intelligence in primary care: an online survey of UK general practitioners. *BMJ Health & Care Informatics*, 31(1). <https://doi.org/10.1136/BMJHCI-2024-101102>
- Boggs, K. Underman. (2023). *Interpersonal relationships : professional communication skills for nurses.* Saunders. https://books.google.com/books/about/Interpersonal_Relationships_E_Book.html?hl=id&id=RYZsEAAAQBAJ
- Brown, C., Nazeer, R., Gibbs, A., Le Page, P., & Mitchell, A. R. (2023). Breaking Bias: The Role of Artificial Intelligence in Improving Clinical Decision-Making. *Cureus*, 15. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.36415>
- Campisi, L., Hügler, T., & Fedeli, M. (2024). Electronic health record : challenges and possibilities. *Revue Médicale Suisse*, 20(865), 550–553. <https://doi.org/10.53738/REVMED.2024.20.865.550>

- Carayon, P., Wetterneck, T. B., Rivera-Rodriguez, A. J., Hundt, A. S., Hoonakker, P., Holden, R., & Gurses, A. P. (2014). Human factors systems approach to healthcare quality and patient safety. *Applied Ergonomics*, 45(1), 14–25. <https://doi.org/10.1016/J.APERGO.2013.04.023>
- Casanova, R., Villa-Garzon, F. A., & Branch-Bedoya, J. W. (2025). Architectural patterns for health information systems: a systematic review. *Frontiers in Digital Health*, 7, 1694839. <https://doi.org/10.3389/FDGTH.2025.1694839/FULL>
- Chien, L. J., Slade, D., Goncharov, L., Taylor, J., Dahm, M. R., Brady, B., McMahon, J., Raine, S. E., & Thornton, A. (2024). Implementing a ward-level intervention to improve nursing handover communication with a focus on bedside handover—A qualitative study. *Journal of Clinical Nursing*, 33(7), 2688–2706. <https://doi.org/10.1111/JOCN.17107>
- Choi, J. Y., Byun, M., & Kim, E. J. (2024). Educational interventions for improving nursing shift handovers: A systematic review. *Nurse Education in Practice*, 74, 103846. <https://doi.org/10.1016/J.NEPR.2023.103846>
- Cruchinho, P., Teixeira, G., Lucas, P., Gaspar, F., & López-Franco, M. D. (2025). Patient Participation During Nursing Bedside Handover: A State-of-the-Art Review. *Nursing Reports* 2025, Vol. 15, 15(12). <https://doi.org/10.3390/NURSREP15120438>
- Daicampi, C., Veronese, M., & Cesaro, E. (2025). Impact of Bedside Handover on Patient Perceptions and Hospital Organizational Outcomes: A Systematic Review. *Journal of Nursing Management*, 2025(1), 3803491. <https://doi.org/10.1155/JONM/3803491>
- de Lange, S., Heyns, T., & Filmlalter, C. (2024). A concept analysis of person-centred handover practices: The meaning in emergency departments. *International Emergency Nursing*, 74, 101446. <https://doi.org/10.1016/J.IENJ.2024.101446>
- De Micco, F., Di Palma, G., Ferorelli, D., De Benedictis, A., Tomassini, L., Tambone, V., Cingolani, M., & Scendoni, R. (2025). Artificial intelligence in healthcare: transforming patient safety with intelligent systems—A systematic review. *Frontiers in Medicine*, 11, 1522554. <https://doi.org/10.3389/FMED.2024.1522554>
- Delima, M., Aljaberi, M. A., & Dioso, R. I. (2026). Nurses' Experiences of Interprofessional Collaboration in Digitally Supported Hospital Discharge Planning: Qualitative Study. *JMIR Nursing*, 9(1), e81961. <https://doi.org/10.2196/81961>
- Duffy, C. M. C., & Benotsch, E. G. (2025). Nonverbal behavior in telehealth visits: A narrative review. *Patient Education and Counseling*, 132. <https://doi.org/10.1016/J.PEC.2024.108600>
- Fadilah, A., & Hidayat, M. S. (2024). Pengaruh Metode Komunikasi SBAR terhadap

- Kepuasan Pasien: Literature Review. Deleted Journal, 3(01).
<https://doi.org/10.31941/PN.V3I01.5183>
- Finnegan, H., & Mountford, N. (2025). 25 Years of Electronic Health Record Implementation Processes: Scoping Review. *J Med Internet Res* 2025;27:E60077 <https://www.jmir.org/2025/1/E60077>, 27(1), e60077.
<https://doi.org/10.2196/60077>
- Fliegenschmidt, J., Merkel, M. J., von Dossow, V., & Zwißler, B. (2023). [Structured patient handover in high-risk areas: Evidence and recommendations for the practical implementation]. *Die Anaesthesiologie*, 72(3), 183–188.
<https://doi.org/10.1007/S00101-022-01249-X>
- for Healthcare Research, A. (n.d.). TeamSTEPPS Team Performance Observation Tool 1 = Very Poor comment if 1 or 2. 2 = Poor 3 = Acceptable 4 = Good 5 = Excellent.
- Foronda, C., MacWilliams, B., & McArthur, E. (2016). Interprofessional communication in healthcare: An integrative review. *Nurse Education in Practice*, 19, 36–40.
<https://doi.org/10.1016/J.NEPR.2016.04.005>
- Galli, A., Andreoli, E., Fabienne, , Pallua, Y., Silvestri, I., Manenti, A., Dignani, L., Contucci, S., & Menditto, V. G. (2025). Improvement of nursing handover in emergency department: a prospective observational cohort study. *Discover Health Systems* 2025 4:1, 4(1), 3-. <https://doi.org/10.1007/S44250-025-00180-3>
- Gazzarata, R., Almeida, J., Lindsköld, L., Cangiolli, G., Gaeta, E., Fico, G., & Chronaki, C. E. (2024). HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7 FHIR) in digital healthcare ecosystems for chronic disease management: Scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 189.
<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105507>
- Ghosh, M., O'Connell, B., Nguyen, H. T., Coventry, L., Towell-Barnard, A., Gallagher, O., Gullick, K., Gent, L., & Saunders, R. (2025). Patient and Family Involvement in Nursing Bedside Handover: A Qualitative Descriptive Study of Consumer Perceptions of Nursing Care. *Nursing Reports (Pavia, Italy)*, 15(2).
<https://doi.org/10.3390/NURSREP15020051>
- Grant, J. B., Jones, J., Candrian, C., Oman, K. S., & Reed, S. M. (2025). The role of nursing communication: A critical interpretive synthesis. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 9, 100373.
<https://doi.org/10.1016/J.IJNSA.2025.100373>
- Gultom, R. W. W., & Karlina, D. (2025). Hubungan Komunikasi Efektif SBAR Dengan Keselamatan Pasien Dan Penatalaksanaan Lanjut Untuk Meningkatkan Pelayanan Di RSUD Mitra Sejati Tahun 2025. *Vitamedica.*, 3(3), 367–373.
<https://doi.org/10.62027/VITAMEDICA.V3I3.481>
- Haliq, S. Al, & AlShammari, T. (2025). Communication handover barriers among nurses

- and paramedics in emergency care settings. *BMC Nursing* 2025 24:1, 24(1), 634-. <https://doi.org/10.1186/S12912-025-03286-4>
- Hamdan, M., Jaaffar, A. H., Khraisat, O., Issa, M. R., & Jarrar, M. (2024). The Association of Transformational Leadership on Safety Practices Among Nurses: The Mediating Role of Patient Safety Culture. *Risk Management and Healthcare Policy*, 17, 1687. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S458505>
- Handoyo, D., Wijayanti, & Handayani, T. (2022). Hubungan Penggunaan Komunikasi Efektif SBAR Terhadap Kualitas Pelaksanaan Handover Di Ruang Rawat Inap RS JIH Solo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 1(2), 148–159. <https://doi.org/10.55606/JURRIKE.V1I2.1985>
- Haring, M., Freigang, F., Gersch, M., & Amelung, V. (2023). Tensions between the Professions: How Integrated Care Can Benefit from Better Understanding and Managing Conflicting Perspectives and Demands. *International Journal of Integrated Care*, 23(2). <https://doi.org/10.5334/IJIC.7570>
- Hassan Elmi, A. (2025). Communication handover barriers among nurses and paramedics in emergency care settings: A call for structured interprofessional solutions. *Journal of Nursing Reports in Clinical Practice*, 4(1), 63–65. <https://doi.org/10.32598/JNRCP.2505.1275>
- Heart Association, A. (2025). Highlights of the 2025 American Heart Association's Guidelines for CPR and ECC.
- Hidalgo Tapia, E. C., León Yosa, J., Olalla García, M. H., Clavijo Morocho, N. J., & Sanmartín Calle, Y. A. (2025). Effectiveness of Nursing Documentation Frameworks (SBAR, SOAP, and PIE) in Enhancing Clinical Handoffs and Patient Safety. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.89957>
- Hidayat, M. S., & Fadilah, A. (2024). Komunikasi SBAR untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Handover oleh Perawat Pelaksana. *Deleted Journal*, 3(01). <https://doi.org/10.31941/PN.V3I01.5144>
- Höglander, J., Holmström, I. K., Lövenmark, A., Van Dulmen, S., Eide, H., & Sundler, A. J. (2023). Registered nurse–patient communication research: An integrative review for future directions in nursing research. *Journal of Advanced Nursing*, 79(2), 539–562. <https://doi.org/10.1111/JAN.15548;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Howick, J., Bennett-Weston, A., Solomon, J., Nockels, K., Bostock, J., & Keshtkar, L. (2024). How does communication affect patient safety? Protocol for a systematic review and logic model. *BMJ Open*, 14(5), e085312. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2024-085312>
- Institute for Healthcare Improvement. (2021). SBAR Tool: Situation-Background-Assessment-Recommendation | Institute for Healthcare Improvement.

<https://www.ihl.org/library/tools/sbar-tool-situation-background-assessment-recommendation>

- Jiang, Y., Cai, Y., Zhang, X., & Wang, C. (2024). Interprofessional education interventions for healthcare professionals to improve patient safety: a scoping review. *Medical Education Online*, 29(1). <https://doi.org/10.1080/10872981.2024.2391631>
- Jimmerson, J., Wright, P., Cowan, P. A., King-Jones, T., Beverly, C. J., & Curran, G. (2020). Bedside shift report: Nurses opinions based on their experiences. *Nursing Open*, 8(3), 1393. <https://doi.org/10.1002/NOP2.755>
- Joint Commission. (2026). Joint Commission News - April 2026 . 2026. <https://www.jointcommission.org/en-us/knowledge-library/newsletters/jc-news/april-2026>
- Jojan, L., & Carroll, K. (2025). Peplau's Theory of Interpersonal Relations: Scholarly Practice. *Nursing Science Quarterly*, 38(1), 27–30. <https://doi.org/10.1177/08943184241291544>
- Kaliraman, V., & Watson, J. L. (2025). Quantifying acute care nurses' experiences of patient handoffs during shift change: a cross-sectional study. *BMC Nursing*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/S12912-025-03802-6>
- Keshtkar, L., Bennett-Weston, A., Khan, A. S., Mohan, S., Jones, M., Nockels, K., Gunn, S., Armstrong, N., Bostock, J., & Howick, J. (2025). Impacts of Communication Type and Quality on Patient Safety Incidents: A Systematic Review. *Annals of Internal Medicine*, 178(5), 687–700. <https://doi.org/10.7326/ANNALS-24-02904>
- Khalid, I., & Lani, O. P. (2024). Communication as Physical Health Therapy. *Alfuad*, 8(1), 61–61. <https://doi.org/10.31958/JSK.V8I1.11109>
- Kosim, N., & Saimi, S. (2025). Enhancing patient safety outcomes through SBAR communication: A systematic review. *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, 8(7), 843–857. <https://doi.org/10.33024/MINH.V8I7.1046>
- Kumah, A. (2025). Adverse event reporting and patient safety: the role of a just culture. *Frontiers in Health Services*, 5, 1581516. <https://doi.org/10.3389/FRHS.2025.1581516/TEXT>
- L. Gleeson, L., O'Brien, G. L., O'Mahony, D., & Byrne, S. (2023). Interprofessional communication in the hospital setting : a systematic review of the qualitative literature. *Journal of Interprofessional Care*, 37(2), 203–213. <https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2028746>
- Lazzari, C. (2024). Implementing the Verbal and Electronic Handover in General and Psychiatric Nursing Using the Introduction, Situation, Background, Assessment,

- and Recommendation Framework: A Systematic Review. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 29(1), 23–32. https://doi.org/10.4103/IJNMR.IJNMR_24_23
- Lee, H., & Jang, S. J. (2021). Effects of flipped-learning-based simulation for nursing students: a retrospective survey. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(5), 1263–1273. <https://doi.org/10.1111/INM.12885>
- Lee, H., Merry, A. F., Woodward-Krohn, R., & Weller, J. M. (2025). Use and effectiveness of directed, closed-loop communication in the operating theatre: mixed methods analysis of simulated clinical emergencies. *British Journal of Anaesthesia*, 135(5), 1279–1285. <https://doi.org/10.1016/J.BJA.2025.05.015>
- Lestari, F. V. A., Rachmawaty, R., & Hariati, S. (2023). Komunikasi Terapeutik Perawat Melalui Pendekatan Budaya. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 2843–2854. <https://doi.org/10.31539/JOTING.V5I2.6834>
- Liaw, S. Y., Tan, J. Z., Lim, S., Zhou, W., Yap, J., Ratan, R., Ooi, S. L., Wong, S. J., Seah, B., & Chua, W. L. (2023). Artificial intelligence in virtual reality simulation for interprofessional communication training: Mixed method study. *Nurse Education Today*, 122. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105718>
- Lim, J., & Kang, Y. (2024). Comparing the impact of PASS-BAR handoff education for new nurses between simulation-based and case-based approaches: A quasi-experimental design. *Nurse Education in Practice*, 79, 104036. <https://doi.org/10.1016/J.NEPR.2024.104036>
- Liu, X., Ma, M., Qu, C., Liu, C., & Yin, Y. (2023). Practical Progress of SBAR Communication Model-Related Teaching in Clinical Teaching. *Journal of Clinical and Nursing Research*, 7(1), 7–14. <https://doi.org/10.26689/JCNR.V7I1.4688>
- Liu, Y., Wang, F., Wang, P., Zhou, Z., Wang, H., Li, J., Qiu, Y., Wang, H., & Miao, S. (2026). AI-MDT: an automatic and intelligent multidisciplinary team consultations platform for lung cancer diagnosis. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology*, 152(1), 32. <https://doi.org/10.1007/S00432-025-06413-5>
- Looi, J. C. L., Allison, S., Bastiampillai, T., Maguire, P. A., Kisely, S., & Looi, R. C. H. (2024). Mitigating the consequences of electronic health record data breaches for patients and healthcare workers. *Australian Health Review : A Publication of the Australian Hospital Association*, 48(1), 4–7. <https://doi.org/10.1071/AH23258>
- Maher, A., Hsu, H., Ebrahim, M. E. B. M., Vukasovic, M., & Coggins, A. (2025). Implementation of bedside handover that includes patients or carers in hospital settings: A systematic review. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 31(6), e14223. <https://doi.org/10.1111/JEP.14223>; JOURNAL: JOURNAL:13652753; ISSUE: ISSUE: DOI

- Mandal, S., Wiesenfeld, B. M., Szerencsy, A. C., Small, W. R., Major, V., Richardson, S., Schoenthaler, A., Mann, D., & Nov, O. (2025). Utilization of Generative AI-drafted Responses for Managing Patient-Provider Communication. *Npj Digital Medicine* 2025 8:1, 8(1), 591-. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01972-w>
- Marino, F., Alby, F., Zuccheromaglio, C., & Fatigante, M. (2023). Digital technology in medical visits: a critical review of its impact on doctor-patient communication. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1226225. <https://doi.org/10.3389/FPSYT.2023.1226225/TEXT>
- Mathal, M., Luis, U. N., Erniansyah, N., Anisa, S. N., Syakira, D. F., & Hardianti, R. (2025). Pengaruh komunikasi sbar terhadap perawatan kolaboratif antarprofesi dan dampaknya pada kesembuhan pasien: literature review. *EMPIRIS : Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 2(4), 744–750. <https://doi.org/10.62335/EMPIRIS.V2I4.2093>
- Matsumoto, K., Fazzini, B., Malcolm, H., Eldridge, J., Puthuchear, Z., Osman, M., & Stephens, T. J. (2025). Factors influencing multidisciplinary clinical decision-making in the critical care unit: a systematic review and mixed-methods meta-synthesis. *BJA Open*, 16, 100488. <https://doi.org/10.1016/J.BJAO.2025.100488>
- McCabe, C., & Timmins, F. (2013). *Communication Skills for Nursing Practice*. Palgrave Macmillan. https://books.google.co.id/books?id=j_pGEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Mersha, A., Abera, A., Tesfaye, T., Abera, T., Belay, A., Melaku, T., Shiferaw, M., Shibiru, S., Estifanos, W., & Wake, S. K. (2023). Therapeutic communication and its associated factors among nurses working in public hospitals of Gamo zone, southern Ethiopia: application of Hildegard Peplau's nursing theory of interpersonal relations. *BMC Nursing* 2023 22:1, 22(1), 381-. <https://doi.org/10.1186/S12912-023-01526-Z>
- Mirzaei, S., Keshmiri, F., Norouzinia, R., Mirjalili, N., Baghshahi, N., & Gholinataj Jelodar, M. (2025). The effect of interactive learning methods and reflection on nurses' learning in patient safety at the ICU and Emergency department. *BMC Health Services Research*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/S12913-025-12320-9>
- Montgomery, A., Chalili, V., Lainidi, O., Mouratidis, C., Maliousis, I., Paitaridou, K., & Leary, A. (2025). Psychological safety and patient safety: A systematic and narrative review. *PLoS ONE*, 20(4 April). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322215>
- Morgan, S., Pullon, S., & McKinlay, E. (2015). Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: An integrative literature review. *International Journal of Nursing Studies*, 52(7), 1217–1230.

<https://doi.org/10.1016/J.IJNURSTU.2015.03.008>

- Mostafapour, M., Fortier, J., Pacheco, K., Murray, H., & Garber, G. (2026). Legal and Ethical Challenges in Integrating AI Into Clinical Practice: Qualitative Study of Physicians' Real-World Experiences. *JMIR AI*, 5(1), e82351. <https://doi.org/10.2196/82351>
- Mousaeinejad, N., Charmduzi, F., Khosravi, S., Khosravi, K., Jafarnejad, S., Mahyapourlori, Z., Moayedfard, A., & Marashi, S. M. (2025). Effectiveness of ISBAR Protocol Implementation by Emergency Medicine Residents in Pediatric Handovers; A Pre-post Intervention Study. *Archives of Academic Emergency Medicine*, 13(1), e75. <https://doi.org/10.22037/AAEM.V13I1.2835>
- Moykari, M. J., Sinaga, M. R., Sakke', V., Patrisia, I., & Sinaga, C. R. A. (2023). Nurses' knowledge and therapeutic communication in hospital. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 76(5). <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0617>
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2018-022202>
- Murphy, M., Engel, J. R., McGugan, L., McKenzie, R., Thompson, J. A., & Turner, K. M. (2022). Implementing a Standardized Communication Tool in an Intensive Care Unit. *Critical Care Nurse*, 42 3(3), 56–64. <https://doi.org/10.4037/CCN2022154>
- Nan, J., & Xu, L.-Q. (2023). Designing Interoperable Health Care Services Based on Fast Healthcare Interoperability Resources: Literature Review. *JMIR Medical Informatics*, 11(1), e44842. <https://doi.org/10.2196/44842>
- National Performance Goal #2: Culture of Safety | Joint Commission. (n.d.). Retrieved April 26, 2026, from <https://www.jointcommission.org/en-us/standards/national-performance-goals/culture-of-safety>
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. *Advances in Patient Safety, Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses*. https://www.researchgate.net/publication/49843266_Professional_Communication_and_Team_Collaboration/citation/download
- Oleribe, O. O., Taylor-Robinson, A. W., Chimezie, C. C., & Taylor-Robinson, S. D. (2025). ETHICS of AI Adoption and Deployment in Health Care: Progress, Challenges, and Next Steps. *JMIR AI*, 4(1), e67626. <https://doi.org/10.2196/67626>
- Park, M. N., & Roh, Y. S. (2024). Emergency department nurses' reflective thinking and patient safety competency: The mediating effect of patient safety culture. *Applied Nursing Research*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2024.151856>
- Parry, D., Odedra, A., Fagbohun, M., Oeppen, R. S., Davidson, M., & Brennan, P. A. (2023).

- Abbreviation use decreases effective clinical communication and can compromise patient safety. *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 61(8), 509–513. <https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2023.07.004>
- Pazar, B., Kavakli, O., Ak, E. N., & Erten, E. E. (2024). Implementation and Evaluation of the SBAR Communication Model in Nursing Handover by Pediatric Surgery Nurses. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*, 39(5), 847–852. <https://doi.org/10.1016/J.JOPAN.2023.12.021>
- Pinto, F., Roberto, P., Ferrario, L., Marotta, L., Montani, D., Auletta, G., Zoppini, L., & Foglia, E. (2025). Using 'Situation-Background-Assessment-Recommendation' Method in Palliative Care to Enhance Handover Quality and Nursing Practice: A Mix Method Study. *Journal of Clinical Nursing*, 34(1), 117–127. <https://doi.org/10.1111/JOCN.17537>;WEBSITE:WEBSITE:PERICLES;JOURNAL:JOURNAL:13652702;WGROU:STRING:PUBLICATION
- Provenzano, M., Cillara, N., Curcio, F., Pisu, M. O., González, C. I. A., & Jiménez-Herrera, M. F. (2024). Electronic Health Record Adoption and Its Effects on Healthcare Staff: A Qualitative Study of Well-Being and Workplace Stress. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(11). <https://doi.org/10.3390/IJERPH21111430>
- Qin, J., Nan, Y., Li, Z., & Meng, J. (2025). Effectiveness of Communication Competence in AI Conversational Agents for Health: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 27(1), e76296. <https://doi.org/10.2196/76296>
- Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., & Zwarenstein, M. (2010a). Interprofessional Teamwork for Health and Social Care. *Interprofessional Teamwork for Health and Social Care*. <https://doi.org/10.1002/9781444325027>
- Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., & Zwarenstein, M. (2010b). Interprofessional Teamwork for Health and Social Care. *Interprofessional Teamwork for Health and Social Care*. <https://doi.org/10.1002/9781444325027>
- Reime, M. H., Tangvik, L. S., Kinn-Mikalsen, M. A., & Johnsgaard, T. (2024). Intrahospital Handovers before and after the Implementation of ISBAR Communication: A Quality Improvement Study on ICU Nurses' Handovers to General Medical Ward Nurses. *Nursing Reports 2024*, Vol. 14, Pages 2072-2083, 14(3), 2072–2083. <https://doi.org/10.3390/NURSREP14030154>
- Rohayati, Ratnah, I., & Simamora, R. S. (2024). The relationship between therapeutic communication and the application of caring behavior for nursing students at stikes medistra indonesia in 2023. *Jurnal Medicare*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.62354/JURNALMEDICARE.V3I3.90>
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P.

- J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in Healthcare: Key Discoveries Enabling Safer, High-Quality Care. *The American Psychologist*, 73(4), 433. <https://doi.org/10.1037/AMP0000298>
- Rudberg, I., Olsson, A., Thunborg, C., & Salzmänn-Erikson, M. (2026). Interprofessional communication - a concept analysis inspired by Schwartz-Barcott and Kim's hybrid model. *BMC Health Services Research* 2026 26:1, 26(1), 308-. <https://doi.org/10.1186/S12913-026-14180-3>
- Saharuddin, Nurachmah, E., Masfuri, Gayatri, D., & Yona, S. (2025). Clinical Decision-Making in Nursing in the Emergency Department: Systematic Literature Review Synthesis. *Salud, Ciencia y Tecnologia*, 5, 1705. <https://doi.org/10.56294/SALUDCYT20251705>
- Sauter, S., Nordmann, K., Schaller, M., Redlich, M. C., & Fischer, F. (2025). Digitally supported interprofessional interaction in healthcare-a scoping review. *Frontiers in Digital Health*, 7. <https://doi.org/10.3389/FDGTH.2025.1688989>
- Schulson, L. B., Rodriguez, J. A., Cruz, R., Flynn, D., & Fernandez, A. (2025). Patient Safety Event Risk and Language Barriers: A Scoping Review. *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 51(6), 438–446. <https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2025.02.002>
- Schwappach, D., Hautz, W., Krummrey, G., Pfeiffer, Y., & Ratwani, R. M. (2025). EMR usability and patient safety: a national survey of physicians. *Npj Digital Medicine* 2025 8:1, 8(1), 282-. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01657-4>
- Shekelle, P. G., Motala, A., & Lawson, E. (2025). Use of Structured Handoff Protocols for Intrahospital Within-Unit Transitions. https://doi.org/10.23970/AHRQEPC_MHS4HANDOFF
- Shinta, N. D., & Bunga, A. L. (2024). The implementation of SBAR communication method for patient safety: A literature review. *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, 7(5). <https://doi.org/10.33024/MINH.V7I5.190>
- Shrivastava, S. R., Chong, S. V., & Bobhate, P. S. (2025). Facilitating effective communication through the adoption of SBAR tool in medical training. *Journal of Education and Health Promotion*, 14(1). https://doi.org/10.4103/JEHP.JEHP_1213_24
- Siokal, B., Amiruddin, R., Abdullah, T., Thamrin, Y., Palutturi, S., Ibrahim, E., Syam, Y., Adi Pamungkas, R., Mappanganro, A., & Mallongi, A. (2023). The Influence of Effective Nurse Communication Application on Patient Satisfaction: A Literature Review. *Pharmacognosy Journal*, 15(3), 479–483. <https://doi.org/10.5530/pj.2023.15.105>
- Şişman, A. Ç., & Acar, A. H. (2025). Artificial intelligence-based chatbot assistance in clinical decision-making for medically complex patients in oral surgery: a

- comparative study. *BMC Oral Health* 2025 25:1, 25(1), 351-.
<https://doi.org/10.1186/S12903-025-05732-W>
- Slawomirski, L., & Klazinga, N. (2022). The economics of patient safety: From analysis to action. *OECD Health Working Papers*, *OECD Health Working Papers*, 145(145). <https://doi.org/10.1787/761F2DA8-EN>
- Soed, N., Ludin, S. M., Abdullah, S. N. S., & Al-Zahrawi, R. (2025). Exploring the Impact of the SBAR on Nursing Handover: A Scoping Review. *The Malaysian Journal of Nursing*, 17(01), 233–245. <https://doi.org/10.31674/MJN.2025.V17I01.024>
- SOPS User Network, A. (2024). SURVEYS ON PATIENT SAFETY CULTURE® Surveys on Patient Safety Culture® Hospital Survey 2024 Database Report PATIENT SAFETY. www.ahrq.gov
- Subramanya, V., Spychalski, J., Coats, S., Gottstein, E., Chancellor, J., & Kulshreshtha, A. (2024). Empathetic Communication in Telemedicine: A Pilot Study. *PRiMER* (Leawood, Kan.), 8. <https://doi.org/10.22454/PRIMER.2024.644242>
- Sung, T. C., & Hsu, H. C. (2025). Improving Critical Care Teamwork: Simulation-Based Interprofessional Training for Enhanced Communication and Safety. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 18, 355–367. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S500890>
- Tataei, A., Rahimi, B., Afshar, H. L., Alinejad, V., Jafarizadeh, H., & Parizad, N. (2023). The effects of electronic nursing handover on patient safety in the general (non-COVID-19) and COVID-19 intensive care units: a quasi-experimental study. *BMC Health Services Research* 2023 23:1, 23(1), 527-. <https://doi.org/10.1186/S12913-023-09502-8>
- Teng, M., Yuan, Z., He, H., & Wang, J. (2024). Levels and influencing factors of mental workload among intensive care unit nurses: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Practice*, 30(4). <https://doi.org/10.1111/IJN.13167>
- The Joint Commission. (2025). Sentinel event data 2024 annual review. 2025. <https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/eac7511986c0442a9c1ae04b1aa02cc0?v=ad34daa0>
- Toumi, D., Dhouib, W., Zouari, I., Ghadhab, I., Gara, M., & Zoukar, O. (2024). The SBAR tool for communication and patient safety in gynaecology and obstetrics: a Tunisian pilot study. *BMC Medical Education*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/S12909-024-05210-X>
- Valdivia de la Fuente, M., Palacios Castañeda, D. J., & Martínez Sanz, N. (2025). The human factor and ergonomics in Patient Safety. *Medicina Intensiva*, 49(2), 96–104. <https://doi.org/10.1016/j.medin.2024.03.020>
- van Dongen, D., Guldenmund, F., Grossmann, I., & Groeneweg, J. (2024). Classification

of influencing factors of speaking-up behaviour in hospitals: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/S12913-024-12138-X>

- Vanderzwan, K. J., Kilroy, S., Daniels, A., & O'Rourke, J. (2023). Nurse-to-nurse handoff with distractors and interruptions: An integrative review. *Nurse Education in Practice*, 67, 103550. <https://doi.org/10.1016/J.NEPR.2023.103550>
- Waqar khan, Mahreen, Gormeet Singh, Haji Akhtar, Liaqat Alam khan, & Ahmad zeb. (2025). Standardization Of Resident's Handover, Improving Communication And Continuity Of Care For Better Patient Outcome. *Pakistan Journal of Advances in Medicine and Medical Research*, 3(1), 8–17. <https://doi.org/10.69837/PJAMMR.V3I1.58>
- Wianti, S., Warsini, W., Aminingsih, S., Setiani, D. Y., & Wijayanti, W. (2025). Peran Kepemimpinan Transformasional Dan Partisipatif Perawat Dalam Meningkatkan Kolaborasi Antarprofesi Dan Integrasi Teknologi Di Rumah Sakit. *Book of Abstract of Trend and Issue in Healthcare*, 2(1), 75–76. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=lcu13KEAAAAJ&citation_for_view=lcu13KEAAAAJ:UebtZRa9Y70C
- Wianti, S., Wijayanti, Wahyuni, S., Sujiyanti, & Ma'ruf, Moh. (2025). Role of Chatbot-Based Artificial Intelligence in Resolving Interprofessional Conflict in the Management of Type 2 Diabetes Mellitus with Obesity: A Scoping Review. *ASTEEC Conference Proceeding: Applied Science*, 2(2). <https://www.proceedings.asteec.com/index.php/acp-as/article/view/131>
- Wijayanti, Mulyani, T., & Mintarsih, S. (2024). Knowledge And Risk Of Needlestick Injuries In Nurses. *Prosiding University Research Colloquium*. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2853>
- World Health Organization. (2021a). Global patient safety action plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care. World Health Organization. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a28c34c0-089c-4f5d-a0b1-5d9c35a3cd67/content>
- World Health Organization. (2021b). Global Patient Safety Action Plan 2021-2030: Towards eliminating avoidable harm in health care, WHO, Geneva, (2021). World Health Organization, 1–96. <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan>
- Yari, M., Izadi-Avanji, F. S., & Sabery, M. (2026). Assessment of clinical handover among ICU nurses based on the structured ISBAR model (2025). *BMC Nursing* 2026. <https://doi.org/10.1186/S12912-026-04564-5>
- Yeom, S., Kim, M. G., & Park, J. H. (2026). Understanding nursing handoff errors in clinical practice: trends and contributing factors based on a systematic review

- and meta-analysis. *BMC Nursing* 2026 25:1, 25(1), 359-.
<https://doi.org/10.1186/S12912-026-04607-X>
- Yoon, J. H., & Lee, E. J. (2023). [Development and effectiveness of the stepwise handoff protocol based on the SBAR for long-term care hospital nurses: A nonequivalent control-group pre-posttest design]. *Journal of Korean Gerontological Nursing*, 25(4), 387–399.
<https://doi.org/10.17079/JKGN.2023.00010>
- Yun, J., Lee, Y. J., Kang, K., & Park, J. (2023). Effectiveness of SBAR-based simulation programs for nursing students: a systematic review. *BMC Medical Education* 2023 23:1, 23(1), 507-. <https://doi.org/10.1186/S12909-023-04495-8>
- Zhang, J., & Zhang, Z. ming. (2023). Ethics and governance of trustworthy medical artificial intelligence. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 23(1), 7.
<https://doi.org/10.1186/S12911-023-02103-9>
- Zhang, Y. K., Wang, Y. W., Jiang, M. Y., Sun, X. H., & Tang, L. Y. (2026). Effectiveness of non-technical skills training for healthcare professionals in emergency departments: a systematic review. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 34(1), 50.
<https://doi.org/10.1186/S13049-026-01574-9>

PROFIL PENULIS



Wijayanti, S.Kep.,Ns.,M.Kep., lahir di Boyolali pada 6 Maret 1988. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Aisyiyah Surakarta (2010–2012), serta Magister Keperawatan di Universitas Indonesia (2016). Sejak tahun 2012, penulis aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta dengan bidang pengajaran meliputi manajemen keperawatan, patient safety, keperawatan jiwa, etika dan hukum kesehatan, promosi kesehatan, serta sistem informasi keperawatan. Penulis produktif menghasilkan berbagai buku ajar, buku referensi, dan karya ilmiah yang berfokus pada

kepemimpinan keperawatan, keselamatan pasien, komunikasi efektif (SBAR), manajemen risiko, serta pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi. Selain itu, penulis aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya pada edukasi kesehatan, pencegahan penyakit tidak menular, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wijayanti@umpku.ac.id

Motto: "Hidup adalah untuk menebar manfaat; sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk."



Dr. Mukhoirotin, S. Kep., Ns., M. Kep., lahir di Jombang, 28 Maret 1978. Lulus Studi Program Diploma Keperawatan di AKPER Darul Ulum Jombang tahun 1998, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan ke Program Pascasarjana Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2014. Lulus program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2025.

Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, tahun 2007 s.d 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Keperawatan Maternitas Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2014 menjadi staf logistik dan Maintenance Laboratorium FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2012 menjadi Sekretaris Prodi Profesi Ners dan tahun 2015 sampai Agustus 2023 menjadi Sekretaris bidang Akademik Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu Jombang.

Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis berjudul Pendidikan Kesehatan Persalinan (2017), DISMENOREA: Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid (2018), dan Strategi Penatalaksanaan Dismenoreia Berbasis Molekuler (2024). Selain itu juga penulis telah menulis buku kolaborasi dan menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional.

E-mail: mukhoirotin@fik.unipdu.ac.id



Sulastri, SKp, M. Kep. Lahir di Bangka Selatan. Penulis merupakan lulusan Sarjana Keperawatan (SKp) pada Studi Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 1994 dan Magister Keperawatan (medikal bedah) di Universitas Indonesia lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan pada tahun 1994-1996 bekerja di RS. Islam Jakarta, kemudian pada tahun 1996-2025 bekerja di Akper Yaspen Jakarta dan sekarang di STIKES Pasar Rebo Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat dan anatomi fisiologi. Penulis telah menulis buku sebanyak 17 judul baik sebagai penulis tunggal maupun tim. Penulis juga telah melakukan beberapa publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal terakreditasi SINTA. Penulis juga telah menghasilkan beberapa Haki berupa buku, booklet, poster, dan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis merupakan salah satu pengurus Hipmebi DK Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulastrisutyono2@gmail.com

Motto: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya



Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep. Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan

lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn, dan Keperawatan Anak serta mengampu matakuliah etik dan komunikasi antar profesi pada program Interprofesionalism education (IPE) terpadu antara fakultas kedokteran dan fakultas Ilmu kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id.

Motto: "Menjadi optimis dan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.



Dr. Neny Triana, S.Kep.,Ns., M.Pd., M.Kep. Penulis adalah Dosen tetap Program Studi D3 Keperawatan STIKES Karya Husada Kediri. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur 1 April 1972, Penulis konsentrasi pada Keperawatan Anak dengan konsisten pada publikasi hasil-hasil penelitian. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 di AKPER Karya Husada Kediri tahun 1996, menyelesaikan S1 Pendidikan di IKIP PGRI Kediri tahun 2000, menyelesaikan D4 Perawat Pendidik peminatan Keperawatan Anak Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2001, menyelesaikan S2 Pendidikan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2010, menyelesaikan S2 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2016, menyelesaikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nenytriana979797@gmail.com

Pesan untuk para pembaca:

Jadilah dian yang selalu menyinari dikegelapan dan teruslah berkarya, dengan karyamu yang bisa dikenang, setelah kita tiada.



Dr. Ns Roma Sitio, S.Kep., M.Kep. Lahir di Tigaras, pada tanggal 14 Mei 1978. Penulis merupakan Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes, Aceh, dengan keilmuan Ilmu Keperawatan Medikal Bedah. Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Keperawatan dan Profesi Ners diselesaikan di Program Studi (Prodi) Keperawatan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sumatera Utara (USU), Medan tahun 2003. Jenjang Pendidikan Magister (S2) diselesaikan pada tahun 2016 di Prodi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan USU, Medan.

Pada tahun 2024, Penulis menyelesaikan Pendidikan Doktoral (S3) di Program Studi Doktor Matematika dan Aplikasi Sains (DMAS) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. Sejumlah karya tulis telah dipublikasikan oleh Penulis, baik pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Jurnal Ilmiah Internasional, Prosiding Internasional, dan Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi.

Hasil karya publikasi Penulis dapat dilihat pada profil Penulis (Roma Sitio) di <https://scholar.google.co.id/citations?user=xjID81YAAAAJ&hl=en> Sinta (ID: 6093064) dan Scopus (ID: 57211533324).

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: roma.sitio@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Satu kebaikan bisa mengubah banyak kehidupan"

Sinopsis

Buku referensi Komunikasi Terapeutik Keperawatan: Keterampilan Klinis, Hubungan Profesional, dan Keselamatan Pasien membahas konsep dasar, prinsip, dan penerapan komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan. Buku ini menjelaskan pentingnya komunikasi yang efektif, empatik, dan profesional dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat, pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya.

Pembahasan mencakup teknik komunikasi terapeutik, tahapan hubungan terapeutik, keterampilan mendengarkan aktif, pemberian edukasi kesehatan, serta komunikasi dalam berbagai situasi klinis. Buku ini juga menekankan peran komunikasi dalam meningkatkan keselamatan pasien, mencegah kesalahpahaman, dan mendukung mutu pelayanan keperawatan.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan komunikasi terapeutik secara profesional, humanis, dan berpusat pada pasien.

Buku referensi Komunikasi Terapeutik Keperawatan: Keterampilan Klinis, Hubungan Profesional, dan Keselamatan Pasien membahas konsep dasar, prinsip, dan penerapan komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan. Buku ini menjelaskan pentingnya komunikasi yang efektif, empatik, dan profesional dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat, pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya.

Pembahasan mencakup teknik komunikasi terapeutik, tahapan hubungan terapeutik, keterampilan mendengarkan aktif, pemberian edukasi kesehatan, serta komunikasi dalam berbagai situasi klinis. Buku ini juga menekankan peran komunikasi dalam meningkatkan keselamatan pasien, mencegah kesalahpahaman, dan mendukung mutu pelayanan keperawatan.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan komunikasi terapeutik secara profesional, humanis, dan berpusat pada pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-00-8 (PDF)



9

786347

756008